

Vérification des annotations qualitatives

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 30 juillet 2026

Table des matières

1	q1_1 — 1.1 Pourquoi ?	2
	Services complémentaires (n=21)	2
	Population spécialisée (n=10)	4
	Proximité et accès local (n=9)	4
	Besoins matériels immédiats (n=5)	5
	Méfiance / rupture de confiance (n=4)	6
	Renvoi / mandat du CIUSSS (n=4)	6
2	q2_1 — 2.1 Pour quelles raisons principalement ?	7
	Soins médicaux/santé physique (n=21)	7
	Services psychosociaux / soutien social (n=17)	8
	Orientation / information vers les services (n=14)	10
	Santé mentale (n=13)	11
	Accès administratif et programmes (RAMQ, inscriptions) (n=4)	12
	non classable (n=2)	12
3	q2_2 — 2.2 Pour quelles raisons principalement ?	13
	Santé mentale (n=11)	13
	Services sociaux/CLSC/DPJ (n=9)	14
	Services pour populations spécifiques (n=8)	15
	Soins médicaux et suivis (n=8)	15
	Services juridiques/administratifs (n=5)	16
	Accès numérique et aide pratique (n=2)	16
	non classable (n=3)	17
4	q4 — 4. Auriez-vous des suggestions de ce qui pourrait améliorer la connaissance des droits des usagers en santé et services sociaux ? Lesquelles ?	18
	Collaborer avec les partenaires de proximité (n=35)	18
	Diversifier les formats d'information (n=34)	21
	Accompagner individuellement (n=11)	24
	Réformer l'organisation et le financement (n=9)	25
	Adapter l'accessibilité linguistique/assistive (n=8)	26

Non classable (n=4)	27
5 q5_1 — 5.1 Pour quelles raisons sont-ils respectés ?	28
Accès/ressources limités (délais, surcharge) (n=13)	28
Professionnalisme et bonne volonté du personnel (n=13)	29
Procédures et information formelle en place (n=8)	30
Incertain / ne sait pas (n=5)	31
Respect conditionnel selon la situation (n=3)	31
Manque de connaissance/sensibilisation des usagers (n=2)	32
6 q5_2 — 5.2 Pour quelles raisons ne sont-ils pas respectés ?	33
Capacités / ressources insuffisantes (n=30)	33
Discrimination / barrières culturelles (n=12)	37
Manque d'information (n=9)	38
Attitudes / formation du personnel (n=5)	39
Comportements / complexité des usagers (n=2)	39
7 q5_3 — 5.3 Quelles sont vos suggestions afin de mieux inclure la voix des usagers eux-mêmes dans la défense de leurs droits ?	41
Informier et former (n=31)	41
Faire participer les usagers (comités) (n=29)	44
Simplifier l'accès aux démarches (n=13)	48
Assurer le suivi et l'évaluation (plaintes/sondages) (n=11)	49
Accompagner et soutenir individuellement (n=7)	50
Non classable (n=9)	51
8 q6 — 6. Quels types de situations problématiques votre organisme rencontre-t-il le plus fréquemment en lien avec le respect des droits des usagers ?	53
Accès aux services (n=26)	53
Refus, stigmatisation ou soins inadaptés (n=25)	55
Manque d'information/communication (n=18)	59
Délais et suivi insuffisants (n=17)	61
Aucun problème rencontré (n=11)	62
Confidentialité et consentement (n=8)	63
non classable (n=7)	64
9 q7 — 7. Selon votre expérience au sein de votre organisme, quels groupes d'usagers sont les plus vulnérables ou moins bien défendus ?	66
Personnes immigrantes/allophones (n=22)	66
Troubles de santé mentale et dépendance (n=21)	68
Personnes en situation de handicap / difficultés de communication (n=20)	71

Femmes et familles vulnérables (mères monoparentales, victimes, trans) (n=16)	73
Personnes âgées isolées (n=15)	74
Personnes en situation d'itinérance (n=8)	75
non classable (n=16)	76
10 q8 — 8. Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers ?	78
Méconnaissance / manque d'information (n=33)	78
Accès limité / manque de ressources (n=26)	83
Complexité bureaucratique et procédurale (n=16)	85
Manque d'accompagnement / peur et épuisement (n=13)	86
Barrière linguistique et communication (n=11)	87
non classable (n=9)	88
11 q9 — 9. Quels droits des usagers sont les plus souvent compromis selon vous ? (ex. accès aux services, consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions, etc.)	90
Accès aux services (n=60)	90
Consentement éclairé et participation (n=27)	97
Manque de ressources / délais / qualité des services (n=8)	100
Communication et langue adaptée (n=4)	101
Confidentialité (n=4)	101
non classable (n=9)	102
12 q10-Comment — 10. Comment votre organisme contribue-t-il actuellement à la défense des droits des usagers ?	103
Orienter / référer vers des services (n=5)	103
Collaborer avec des partenaires (n=4)	103
Offrir des services directs et un accompagnement (n=4)	104
Plaider et représenter les usagers (n=2)	104
Aider dans les démarches administratives (n=1)	104
Coordonner l'écosystème / mener de la recherche (n=1)	104
13 q11_1 — 11.1 Pour quelles raisons ?	105
Accessible/clair (n=9)	105
Méfiance envers le traitement des plaintes (n=3)	106
Ne sait pas / pas d'information (n=2)	106
Ressources/énergie insuffisantes (n=2)	106
Info présente mais manque formation (n=1)	106
14 q11_2 — 11.2 Pour quelles raisons ?	107
Méconnaissance / information (n=20)	107
Complexité / lourdeur administrative (n=18)	108

Barrières d'accès pratiques (n=15)	110
Capacités personnelles limitées (n=15)	111
Peur de représailles ou découragement (n=15)	115
non classable (n=5)	116
15 q12-Comment — 12. À quelle instance du réseau de la santé et des services sociaux pourriez-vous référer un usager qui aurait à exprimer une plainte ou une insatisfaction ?	117
Ne sait pas / impossible à identifier (n=5)	117
Organisme communautaire / aidant local (n=5)	117
Comité/porte-parole des usagers ou CAAP (n=4)	118
Instance de surveillance/ombudsman (n=4)	118
Instance juridique/ de protection des droits (Conseil, droit de la personne) (n=4) . . .	121
Établissement de santé local (CLSC/CIUSS) (n=4)	121
16 q13 — 13. Auriez-vous des commentaires à formuler sur la facilité de trouver la bonne instance pour porter plainte ou pour exprimer une insatisfaction ?	123
Propose une amélioration (n=25)	123
Signale une difficulté (n=24)	125
Dit que c'est clair/facile (n=5)	130
Aucun renseignement / refus de répondre (n=4)	130
non classable (n=5)	131
17 q16-Comment — 16. Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà entendu parler de l'existence de Comités des usagers ou de résidents (CLSC, hôpitaux, CHSLD) de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal ?	132
Connaissance limitée (n=3)	132
Très faible connaissance (n=3)	132
Connaissance générale (n=1)	132
Connaissance précise locale (n=1)	133
18 q17_1 — 17.1 Si oui, comment avez-vous trouvé l'expérience ?	134
Positif (n=3)	134
Négatif (n=2)	134
Très positif (n=2)	134
19 q18_1 — Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations	135
Relayer via des partenaires communautaires (n=13)	135
Diffuser en ligne (n=11)	136
Méconnaissance / incertain (n=11)	137
Tenir des sessions en présentiel (n=8)	138
Adapter l'accessibilité (n=6)	138

Distribuer des documents imprimés (n=5)	139
20 q18_2 — Promouvoir l'amélioration de la qualité de leurs conditions de vie	140
Consulter et faire participer les usagers (n=8)	140
Informer, former, promouvoir la santé (n=6)	141
Assurer la transparence / rendre compte (n=4)	141
Faire respecter les lois et la qualité des soins (n=2)	142
Plaider auprès des instances politiques (n=2)	142
Renforcer les moyens (personnel/financement) (n=2)	142
non classable (n=10)	142
21 q18_3 — Participer à l'évaluation de leur degré de satisfaction par rapport aux services obtenus de l'établissement	144
Sonder / administrer un questionnaire (n=11)	144
Adapter les modalités (n=8)	145
Exige rigueur professionnelle / critique méthodologique (n=4)	145
Assurer un suivi longitudinal (n=3)	146
Mener une approche qualitative (n=1)	146
non classable (n=11)	146
22 q18_4 — Défendre leurs droits et leurs intérêts collectifs	148
Incertitude / manque d'information (n=12)	148
Accroître la visibilité / informer le public (n=5)	149
Assurer l'accessibilité et le contact direct (n=5)	149
Collaborer avec des partenaires (n=5)	150
Actions ciblées vers communautés/linguistique (n=3)	150
Renforcer le pouvoir d'action du comité (n=3)	150
non classable (n=1)	151
23 q18_5 — À la demande d'une personne, défendre ses droits et ses intérêts en tant qu'usager(-ère) ou résident(e) auprès de toute autorité compétente	152
Accompagner individuellement (n=11)	152
Ne sait pas / sans objet (n=7)	153
Informé / sensibiliser (n=3)	153
Renforcer les comités (n=3)	154
Questionner / contrôler les intervenants (n=2)	154
Obligation des professionnels (n=1)	154
non classable (n=1)	154
24 q18_6 — Accompagner et assister tout(e) usager(-ère) ou résident(e) dans toute démarche, y compris pour formuler une plainte	155

Indécis/aucune précision (n=11)	155
Informé / expliquer (n=5)	156
Soutenir personnellement (n=5)	156
Renforcer les organismes (n=3)	156
Accompagnement pair-aidant/indépendant (n=2)	157
Aider concrètement (formulaire/représentation) (n=2)	157
non classable (n=3)	157
25 q19 — 19. Auriez-vous des suggestions afin que votre organisme puisse davantage collaborer avec les Comités des usagers de l'Est-de-l'Île-de-Montréal ?	158
Organiser des rencontres ou ateliers (n=20)	158
Communiquer / transmettre de l'information (n=15)	160
Désigner une personne-ressource (n=5)	162
Déjà collaborent / satisfaction (n=4)	162
Barrières ou manque de disponibilité (n=3)	162
non classable (n=5)	163
26 q20 — 20. Souhaitez-vous ajouter un commentaire ou une recommandation ?	164
Demande d'information / meilleure visibilité (n=15)	164
Pas de commentaire / refus de répondre (n=8)	165
Proposer collaboration avec le communautaire (n=4)	166
Améliorer accessibilité / communication inclusive (n=2)	166
Critique du sondage (moment / pertinence) (n=2)	167
Partager résultats avec organismes (n=2)	167
non classable (n=5)	167
27 q21-Comment — 21. Dans quel secteur d'activité votre organisme œuvre-t-il dans l'Est de Montréal ?	168
Santé et services médicaux/psychosociaux (n=12)	168
Emploi / insertion socioprofessionnelle (n=11)	169
Familles, victimes et soutien communautaire (n=8)	169
Handicap et neurodiversité (n=6)	170
Logement et itinérance (n=6)	170
Genre, femmes et LGBTQ+ (n=5)	171
non classable (n=2)	171
28 q23-Comment — 23. Quelle(s) clientèle(s) votre organisme dessert-il principalement ?	172
Adultes (n=8)	172
Communautés LGBTQ+ (n=6)	172
Personnes en situation de handicap (n=6)	173

Personnes vulnérabilisées / marginalisées (n=6)	173
Jeunes / tranches d'âge spécifiques (n=3)	174
Tous / non spécifié (n=3)	174
non classable (n=1)	174

29 q24-Comment — 24. Plus spécifiquement, dans quelle thématique votre organisme concentre-t-il sa mission ? **175**

Personnes avec déficience / maladies chroniques (n=18)	175
Itinérance / précarité résidentielle (n=16)	176
Jeunes, familles et proches aidants (n=13)	177
Aînés (n=6)	178
Femmes (n=6)	178
Immigrants / nouveaux arrivants (n=3)	179
non classable (n=12)	179

q1__1 — 1.1 Pourquoi ?

Question mère (q1) : Principale raison pour laquelle les usagers consultent l'organisme

Propriété annotée : *Quelle est la raison principale évoquée pour que les usagers consultent l'organisme (complémentarité, proximité, spécialisation, renvoi, besoins matériels, ou méfiance) ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 53 réponses (39 internet, 14 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Services complémentaires	21	39.6%	16	5
Population spécialisée	10	18.9%	8	2
Proximité et accès local	9	17.0%	8	1
Besoins matériels immédiats	5	9.4%	3	2
Méfiance / rupture de confiance	4	7.5%	2	2
Renvoi / mandat du CIUSSS	4	7.5%	2	2
Total	53		39	14

Services complémentaires (n=21)

#2 • internet

Parce qu'on offre des services différents, en éducation populaire, dans l'informel, sans diagnostic.

#5 • internet

Nous offrons des services d'hébergement et de loisirs à des adultes qui vivent avec des enjeux de santé mentale.

#12 • internet

Complémentarité des actions

#14 • internet

Nos services sont complémentaires

#24 • internet

Les usagers contactent notre organisme pour diverses raisons. Plusieurs recherchent des services que le CIUSSS n'offre pas directement, comme notre service d'écoute active, la réception de courrier pour les personnes en situation de précarité résidentielle ou d'itinérance, ainsi qu'un accompagnement flexible en recherche de logement et en intervention psychosociale.

D'autres ne savent pas toujours vers quelle ressource du CIUSSS se diriger ou font face à des barrières d'accès, comme les délais d'attente ou la complexité du système. Certaines personnes nous partagent également avoir vécu des expériences négatives dans des milieux institutionnels ou se sentir plus en sécurité dans un organisme communautaire qu'elles perçoivent comme plus accessible, moins formel et davantage axé sur la relation de confiance.

Enfin, plusieurs usagers utilisent à la fois les services du CIUSSS et ceux du milieu communautaire, puisque nos services viennent souvent compléter ceux du réseau public.

#29 • internet

veulent de l'information et des ressources juridiques ou des services administratifs, des activités ou

employabilité ou proches aidant

#49 • internet

Le CLSC offre peut de répit et de soutien aux PPA

#52 • internet

Fondation aidant les jeunes de la DPJ, nous fournissons des programmes et de l'aide supplémentaire en complémentarité avec le CIUSS et la DPJ.

#53 • internet

Les services du milieu communautaire offrent une gamme de service que les CIUSSS n'offrent pas, le contraire est vraie. Les services sont donc complémentaires. En tant qu'organisme communautaire, nous offrons des services de proximité à nos membres.

#60 • internet

Car nous offrons des services complémentaires à ceux du CIUSSS, notamment en matière de recherche d'emploi.

#62 • internet

Nous offrons plusieurs services : Garderie adapté, Centre de stimulation, centre de jour 21 ans et plus, camp de jour, camp de vacances (avec couchés), répits etc. Certain service ne sont pas offert par le CIUSSS d'autre oui, mais en pas en quantité suffisante

#70 • internet

Les services sont complémentaires.

#76 • internet

Certains usagers estiment que les services communautaires ont une approche plus flexible et adaptée à leur besoin (plus de rencontres psychosociales, plus de festivités qui ne sont pas comprises dans les activités des CIUSSS généralement)

#79 • internet

souvent nous somme une complémentarité des services du CIUSS ou un pont le temps que les personnes soient accepté en aide en santé mentale ou en aide psychosociale. Généralement elles viennent vers nous aussi après avoir eu des services du ciuss

#86 • internet

Service de loisirs

#98 • internet

Plusieurs raisons, avoir accès à de l'information et de l'aide , des groupes de soutien, de l'aide financière, du transport.

#115 • téléphone

Pour avoir des compléments aux services du CIUSS pour les personnes très vulnérables

#117 • téléphone

Le CIUSS n'offre pas de logement pour l'itinérance et la dépendance. Notre approche est globale

#124 • téléphone

L'hébergement n'est pas offert et accompagnement social communautaire

#128 • téléphone

En tant que centre communautaire on fait de la prévention santé et psychologie...

#129 • téléphone

Parce que c'est un besoin, ce sont des services complémentaires comme le dépannage alimentaire. Souvent c'est le CIUSS qui réfère les usagers

Population spécialisée (n=10)

#1 • internet

Population en presque totalité de nouvelles et nouveaux arrivants, aux besoins multiples et en situation de vulnérabilité extrême

#7 • internet

pour les RPCE et communautier LGBTQ

#35 • internet

Ils ne trouvent pas de répit pour leur jeune vivent avec une DI.

#61 • internet

Nous sommes spécialisé en réinsertion sociale mission qui n'est pas attribuée au CIUSSS.

#65 • internet

En raison du manque de ressources disponibles en langue des signes (LSQ) dans le réseau public et de la nécessité d'avoir des intervenants qui comprennent et respectent la culture des Sourds.

#72 • internet

Nous offrons l'hébergement avec peu de suivi, pour les personnes ayant des difficultés de santé mentale importants (psychotique)

#89 • internet

Notre Association offre des services aux personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique, une maladie chronique complexe peu connue des professionnel · les de la santé.

#95 • internet

Nous offrons un service spécialisé de soutien aux parents d'enfants ayant un enfant handicapés physiques ou retard moteur dans leur recherche et d'un service de garde et parcours d'inclusion en service de garde. Ce qui n'est pas offert par le CIUSSS

#107 • téléphone

Nous sommes un service plus spécialisé

#119 • téléphone

Population très stigmatisée, donc nous avons une clinique communautaire qui est plus proche des gens en offrant des alternatives. Notre communauté a de la difficulté à s'intégrer (itinérance, consommation, santé mentale...) mais la collaboration est positive

Proximité et accès local (n=9)

#26 • internet

Nous offrons le service d'hébergement aux femmes et enfants victimes de violence conjugale. Nous accueillons des femmes et enfants de différents quartiers de Montréal et de régions. Cependant, nous services externes (services sans hébergement) sont utilisé en grande majorité pour les femmes de l'ouest de l'île.

#32 • internet

Accès compliquer. Aire ouverte est souvent la porte d'accès.

Veulent des accompagnements et suivi de longue durée et à l'extérieur (proximité)

#34 • internet

Services de proximité moins formels que ceux du CIUSSS, cela leur fait moins peur. Aussi, souvent les services peuvent commencer plus rapidement et s'offrir en complémentarité de ceux du CIUSSS

#47 • internet

La peur d'être obligé de parler à quelqu'un qui ne fréquente pas. À l'organisme les intervenants sont connus. De plus, il est plus facile et proche de leur maison d'utiliser les services.

#63 • internet

Ils connaissent bien les intervenantes de milieu de notre organisme et se sentent à l'aise d'en demander de l'aide.

#77 • internet

Parce qu'ils ont besoin d'être accompagné vers le CIUSSS , ne se sentent pas entendu ou ils ne savent pas ce que le CIUSSS offre comme service. Et parce que nous offrons des services que vous n'offrez pas.

#90 • internet

Ils ont besoins des professionnels, mais les services SANS préjugés du communautaire sont appréciés. De plus, nous sommes ouverts soirs, matins, après-midis et fins de semaines.

#97 • internet

Souvent les usagers ne savent pas ce que le CIUSSS offrent comme services. Il n'a pas assez de visibilité, de publicité, d'information pour l'utilisateur. Personnellement, il m'a fallu aller sur le site afin de savoir que dans l'est il y avait 2 hôpitaux, 2 instituts universitaires, 19,000 employés etc.etc.

#125 • téléphone

Pour briser l'isolement et sentiment d'appartenance

Besoins matériels immédiats (n=5)

#38 • internet

Usagers en situation d'urgence

#68 • internet

Besoin de soutien direct (alimentaire, vestimentaire)

Besoin d'accompagnement

Méfiance face aux services sociaux (DPJ, travailleurs sociaux) et/ou mauvaise expérience antérieure.

Méconnaissance des ressources du CIUSSS et où des services publics québécois en général.

#80 • internet

Distribution de matériel, travail de nuit, salle de consommation supervisé

#112 • téléphone

LDes gens qui ont fait le tour de toutes les ressources sans avoir d'aide

#126 • téléphone

Logement, DPJ, itinérance...

Méfiance / rupture de confiance (n=4)

#19 • internet

la clientèle que nous desservons est féminine et judiciarisée. Pour certaines voire la majorité, il y a eu un bris de confiance aux système en place.

#33 • internet

L'organisme communautaire vient répondre à des besoins importants auxquels le réseau public ne répond pas (ex. sentiment d'appartenance, socialisation, valorisation, partage d'expérience, entraide....).

Pour certaines personnes, le réseau est un endroit où ils n'ont pas été bien reçus, vécus des expériences douloureuses, où les approches bio-médicales peuvent être réductrices de leurs expériences et la crainte de revivre des expériences difficiles font qu'ils sont à la recherche d'autre chose, qu'ils trouvent dans organismes communautaires.

#111 • téléphone

Par manque de confiance dans le CIUSS et le système qui ne les a pas bien servis dans le passé

#120 • téléphone

C'est du cas par cas, mais parfois ils trouvent cela difficile de parler de leurs difficulté ou parce qu'ils ne connaissent pas le système...

Renvoi / mandat du CIUSSS (n=4)

#4 • internet

Ou le CIUSSS leur a dit de venir nous voir pour faire des démarches

#42 • internet

Personne ne prends le temps de les guider vers les services disponibles pour eux et ceux qui sont disponibles, lorsqu'ils y ont droit, ne répondent souvent pas à leurs besoins.

#113 • téléphone

Et du milieu de l'emploi. Oui on les réfèrent selon leurs besoins spécifiques au CIUSS

#123 • téléphone

Pour savoir ou se diriger et ou aller dans le CIUSS

q2__1 — 2.1 Pour quelles raisons principalement ?

Question mère (q2) : L'organisme réfère-t-il des usagers à des services du CIUSSS ?

Propriété annotée : *Quel est le motif principal de la référence aux services du CIUSSS (type de besoin exprimé) ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 71 réponses (51 internet, 20 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Soins médicaux/santé physique	21	29.6%	15	6
Services psychosociaux / soutien social	17	23.9%	15	2
Orientation / information vers les services	14	19.7%	8	6
Santé mentale	13	18.3%	7	6
Accès administratif et programmes (RAMQ, inscriptions)	4	5.6%	4	0
non classable	2	2.8%	2	0
Total	71		51	20

Soins médicaux/santé physique (n=21)

#0 • internet

Pour des demandes de soins qu'ils n'arrivent pas à obtenir !

#9 • internet

pour avoir accès à des services en liens avec leurs santé physiques ou mentale

#13 • internet

santé

#20 • internet

Santé physique, santé mentale

#48 • internet

Soins podologiques infirmiers

#58 • internet

suivi pour épilepsie, accès à certaine ressources

#59 • internet

Nous sommes complémentaires. Nous travaillons avec femmes et enfants victimes de VC donc le plus souvent pour des services en lien avec la santé.

#65 • internet

Pour permettre aux usagers d'obtenir des diagnostics cliniques officiels. Ces évaluations professionnelles sont indispensables pour adapter nos interventions et justifier l'accès à des services spécialisés ou à des programmes de soutien.

#70 • internet

Avoir accès à un médecin ou autre professionnel de la santé.

#72 • internet

Nous demandons que les personnes aient un suivi médical pour avoir services

#80 • internet

soins de plaies et problèmes de santé + psychosociaux

#84 • internet

ORDRE MÉDICAL

#97 • internet

Besoin de consulter un médecin, prises de sang, demande de services pour une personne ayant besoin de soins.

#98 • internet

soins de santé, soin infirmier, etc

#102 • internet

Raison médicale

#109 • téléphone

soins de santé

#112 • téléphone

Santé physique et mentale

#119 • téléphone

Santé physique et mentale

#124 • téléphone

Services pédiatriques

#125 • téléphone

Accès au médecin de famille ou psychiatrie

#128 • téléphone

Oui urgences, traitements médicaux, santé mentale, diagnostics enfants...

Services psychosociaux / soutien social (n=17)

#3 • internet

Pour les services d'une travailleuse sociale.

#5 • internet

Parce qu'ils veulent un hébergement et qu'ils ne peuvent pas passer directement par nous.

#26 • internet

Services CLSC, soutien à domicile pour les femmes qui accouchent durant leur séjour, services d'ergo, physio, nutritionniste, psychologue, médecin de famille, etc.

#30 • internet

Proche aide, soutien à la santé mentale et services à domicile pour aînés

#31 • internet

cherche des ressources pour les aider. Ex : accompagnement à un RDV médical. proche aidant qui cherche de l'aide pour différents sujets

#44 • internet

Santé, soutien à domicile, évaluation psychosociale, besoin d'unE TS...

#49 • internet

Répét et SAD

#63 • internet

Pour avoir des services de soutien à domicile et du soin infirmier.

Pour pouvoir aller vivre dans un centre d'hébergement.

Pour pouvoir fréquenter le centre de jour.

#77 • internet

services à domicile, ergothérapie, travailleuse sociale, infirmière, service jeunesse, évaluation psychosociale

#78 • internet

Suivis médicaux ou psychosociaux

#79 • internet

pour le 0 à 5 ans SIPPE, Pour le programme OLO, Pour des services Psychosociales, santé mentale et aussi pour le programme Agir tôt

#85 • internet

Soutien à domicile

Aide psychosociale

#89 • internet

Demande de services en ergothérapie ;

Évaluation des besoins d'aide psychosociale ;

Évaluations des besoins pour des services d'aide à domicile ;

#91 • internet

Besoin psychosociaux, problèmes de santé nécessitant le réseau de la santé.

#95 • internet

Pour avoir accès aux équipes d'intervention précoce (DI-DP-TSA) pour avoir accès au soutien psychosocial, Places, protocoles, allocations, transport adapté, etc

#110 • téléphone

On référerait plus souvent si l'accès pour les soins en santé mentale et physique serait plus accessible, moins complexe et qu'il y aurait une réelle prise en charge de la personne, car ça arrive qu'ils ne l'ont pas. Disons pour une combinaison de manque de logement, d'alimentation et santé mentale par exemple, lorsque le cas est multiple c'est difficile de savoir vers où l'orienter efficacement.

#123 • téléphone

Un soutien à domicile

Orientation / information vers les services (n=14)

#21 • internet

Pour avoir accès aux services/programmes dont ils ne sont pas au courant.

#24 • internet

Nous référons fréquemment les usagers vers des services du CIUSSS lorsqu'ils ont besoin d'un suivi clinique ou psychosocial plus spécialisé, notamment pour accéder à un travailleur social, à des services de santé mentale, à des soins médicaux, ou à du soutien administratif lié à certaines démarches (ex. renouvellement ou obtention d'une carte RAMQ).

Nous faisons également des références lorsque les besoins dépassent notre mandat ou nécessitent des services du réseau public complémentaires à l'accompagnement communautaire que nous offrons.

#35 • internet

Parce que les familles n'ont pas été orientées vers le CIUSSS.

#42 • internet

Car les familles ne savent pas quels services existent et comment y avoir accès. Souvent, même le personnel du réseau ne connaissent pas l'offre de services disponible. Nous les référons automatiquement vers les CIUSSS, tout en offrant un soutien personnalisé pour qu'ils comprennent ce à quoi ils ont droit. Nous offrons plusieurs services complémentaires également qui répondent à leurs besoins réels.

#62 • internet

Dans le cadre de notre centre de jour 21 ans et plus, nous avons une entente avec le CIUSSS. Toutefois, celui-ci occupe un nombre limité de place, nous prenons donc aussi des ententes (privées) directement avec certains parents qui le demande

#68 • internet

Programme Agir Tôt

Suivi JED

Guichet d'accès pour les adultes

#76 • internet

référence vers les guichets d'accès pour du soutien psychosocial ou pour des évaluations médicales

#96 • internet

Nous offrons des ateliers de prévention en santé mentale auprès des jeunes de 11 à 18 ans, dans les écoles secondaires de l'Est-de-Montréal (pas nécessairement toutes, mais celles qui souhaitent nous inviter). Dans le cadre de notre atelier, nous nommons différentes ressources (communautaire et institutionnelle) pouvant accompagner les jeunes avec leur santé mentale. À ce moment, nous nommons les CIUSSS parmi les ressources disponibles

#108 • téléphone

Services CLSC et c'est complexe pour les listes d'attente infinies pour pys, médecin ou autre

#114 • téléphone

Orienter pour se retrouver dans les services offert par le CIUSS, enfants, papiers etc...

#115 • téléphone

De tout, suivis de grossesse, santé mentale, nouveaux arrivants, accès aux services de santé...

#116 • téléphone

En partenariat avec d'autres organismes plus proche des services du CIUSS

#121 • téléphone

CLSC

#129 • téléphone

Pour les services médicaux information par exemple pour les immigrants qui ne parlent pas la langue et sont perdus dans le système ou service pour les enfants. Informations et diriger dans le système

Santé mentale (n=13)

#2 • internet

Santé mentale, SIV, SIM, Soutien à domicile, accueil psychosocial, proxi-itinérance

#12 • internet

SM, Santé physique, dépendances

#25 • internet

Pour leur suivi en santé mentale

Medecin de famille, spécialiste, centre réadaptation, CHSLD, centre jeunesse etc..

#34 • internet

Santé mentale adulte : dépressions post-partum, évaluations et soutien pour enjeux de santé mentale
Guichet d'accès jeunesse : Enjeux de santé mentale chez les enfants (2-5 ans) comme des tocs, des troubles de comportements et d'opposition, etc.

#37 • internet

Psychologue, travailleurs sociaux, problème santé mentale et/ou physique

#43 • internet

Santé mentale, accueil psychosocial, santé

#53 • internet

Besoins demandant un soutien plus important, problématiques complexes, enjeux de santé mentale

#105 • téléphone

Problématique de santé mentale en général

#107 • téléphone

santé mentale et toxico

#111 • téléphone

Santé mentale, dépendance

#113 • téléphone

Santé mentale et suivis addictions ou santé physique

#117 • téléphone

Santé mentale, dépendance

#120 • téléphone

On fait appel au CIUSS en santé mentale et santé, soutien psychologique...

Accès administratif et programmes (RAMQ, inscriptions) (n=4)

#19 • internet

RAMQ, Santé mentale, etc

#38 • internet

Carte RAMQ, Suivis psychosociaux plus poussés

#52 • internet

Aide financière pour les jeunes suivi par la DPJ.

#94 • internet

Dans le but de bénéficier de programmes offerts par le CLSC (Soutien à domicile, santé mentale jeunesse, programme OLO)

non classable (n=2)

#1 • internet

Voir 1.1

#32 • internet

Aire ouverte.

q2_2 — 2.2 Pour quelles raisons principalement ?

Question mère (q2) : L'organisme réfère-t-il des usagers à des services du CIUSSS ?

Propriété annotée : *Quel type de services les répondants disent-ils référer au CIUSSS (catégorie principale du besoin) ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 46 réponses (41 internet, 5 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Santé mentale	11	23.9%	9	2
Services sociaux/CLSC/DPJ	9	19.6%	8	1
Services pour populations spécifiques	8	17.4%	7	1
Soins médicaux et suivis	8	17.4%	8	0
Services juridiques/administratifs	5	10.9%	5	0
Accès numérique et aide pratique	2	4.3%	1	1
non classable	3	6.5%	3	0
Total	46		41	5

Santé mentale (n=11)

#10 • internet

Nos usagers proviennent de partout en province, et leurs besoins touchent la dépendance, l'itinérance et la santé mentale principalement. Mais lorsque cela est possible et utile, nous nous y référons.

#11 • internet

Quand urgence psychosociale

#14 • internet

Notre mission et nos actions visent à améliorer les conditions de vie des personnes ayant un ou des troubles de santé mentale. En ce sens, les personnes qui utilisent nos services sont référé par les CIUSSS et les professionnels des équipes traitantes.

#16 • internet

Nos services touchent plus les activités et les programmes afin de maintenir une bonne condition physique et mentale et briser l'isolement

#36 • internet

Accès à des services en santé mentale

#60 • internet

Santé mentale

#69 • internet

Santé et services sociaux

#71 • internet

Pour problèmes liés à un choc post-traumatique

#92 • internet

Notre organisme est généralement en mesure de répondre aux besoins de ses usager · ères (personnes proches aidantes en santé mentale ou PASM) de manière autonome. On réfère généralement les PASM aux services du CIUSSS lorsqu'elles ont besoin de services pour leur propre santé mentale (e.g. GASMA, SMA).

#122 • téléphone

Tout ce qui est santé mental ou DPJ

#127 • téléphone

Probleme de suicide psycho social ou de santé

Services sociaux/CLSC/DPJ (n=9)

#8 • internet

Demande de T.S., Chèque-emploi de service, suivi psychosocial pour eux, Soutien à la famille (SAF) (comme familles) ou pour leur enfant/adulte ou proche ayant une déficience intellectuelle

#46 • internet

Nous remettons des robes et des habits aux finissants du secondaire

#47 • internet

Nous pouvons répondre directement aux besoins. Mais le CIUSSS n'est pas notre première idée lorsque nous choisisons de référer. Nous passons pas le réseau communautaire.

#50 • internet

parce qu'ils nous appellent pour nos services et que les CLSC ont terminé leurs rencontres avec eux ; ces clients, s'ils veulent continuer, doivent se chercher un autre organisme.

#51 • internet

De longues listes d'attente ou nos usagers ont déjà communiqué avec un CIUSSS

#54 • internet

Oui, de manière informelle. En tant que centre de jour, nous agissons comme vigie. Si la situation d'un usager se détériore, nous informons la famille ou l'utilisateur des ressources disponibles au CIUSSS pour qu'ils entreprennent les démarches.

#61 • internet

Nous référons quand ils ont des besoins particuliers, par contre nous ne sommes pas tant équipé pour identifier toutes les références potentielles (connaissances en détails des programmes). Nous n'avons aucun contact officiel avec le CIUSSS ce qui pourrait faciliter les échanges et la promotion des services respectifs.

#82 • internet

Référencement vers les services des CLSC.

#118 • téléphone

Travail social

Services pour populations spécifiques (n=8)

#6 • internet

Avoir des services pour les 21 ans et plus en déficience intellectuelle

#17 • internet

Le traitement infligé aux personnes qui fréquentent l'organisme (lesbiennes, lesboqueers, personnes trans et non-binaire qui ont subi et qui subissent encore des préjugés, du mégenrage et de la violence de la part du personnel des CIUSSS. Nous travaillons également en violence conjugale chez les lesbiennes, donc violence des femmes qui n'est pas reconnue et pris au sérieux.

Le manque de place

#22 • internet

Nous offrons de l'hébergement d'urgence. Les femmes qui sont chez nous ont souvent un statut migratoire non défini et vous ne pouvez pas les aider (par exemple, si elles n'ont pas de carte de la RAMQ

#74 • internet

Nous offrons des thérapies pour hommes ayant des problèmes avec les enfants!

#87 • internet

Notre organisme offre les services qui ne sont pas offerts par le CIUSSS. Nous approchons les résidences et les groupes communautaires pour offrir nos services.

#88 • internet

Nous travaillons à la promotion l'accès à l'information et à la communication adaptée pour la communauté sourde du Québec.

#100 • internet

Les CIUSSS offre pratiquement aucun service pour les personnes trans

Nous référons les CIUSSS pour faire son changement de carte de RAMQ et parfois pour les prises de sang

#126 • téléphone

Grossesse,handicaps

Soins médicaux et suivis (n=8)

#7 • internet

pour bilan santé

#23 • internet

Dépannage alimentaire

Santé mentale

Décrochage scolaire

Encadrement professionnel

Ergothérapie

#27 • internet

Demande de services de santé ou de services sociaux

#33 • internet

Besoin de voir un médecin, voir un psychitre, problèmes de santé physique,

#40 • internet

Problèmes de sante physique. Ils ne parlent pas le Français. Nous avons les demandeurs d’asile : ils ont le PSF et nous avons les aînés dont la majorité ont leur médecin de famille

#83 • internet

Certains suivis médicaux ou en communauté

#90 • internet

Seulement lorsque l’aspect médical est en jeu, crise ou médication par exemple.

#93 • internet

pour obtenir une consultation médicale ou avec une travailleuse sociale

Services juridiques/administratifs (n=5)

#15 • internet

Comme regroupement communautaire, nos communautés nous contactent pour obtenir des services en lien avec la défense des droits, le travail des groupes, nos représentations auprès du réseau et des gouvernements, etc. Quand les personnes ont des questions en lien avec les services du CIUSSS, elles se tournent plus souvent vers les groupes qui entretiennent des liens avec ce genre d’institutions.

#57 • internet

Les besoins de nos usagers sont juridiques

#101 • internet

problématiques juridiques

#103 • internet

Nous faisons de la défense collective des droits ; nous n’offrons pas de services individuels en santé et services sociaux

#104 • internet

Défense des droits des usagers

Accès numérique et aide pratique (n=2)

#55 • internet

Notre service est pour guider les usagers vers les ressources en formation uniquement

#106 • téléphone

Lorsqu’on nous demande des services que nous n’offrons pas et il y en a qui n’ont pas d’ordinateur. Surtout les personnes âgées ou pas les moyens d’en avoir. On dirait que le gouvernement ne comprends pas que certains ne soient pas en mesure de d’avoir accès internet

non classable (n=3)

#4 • internet

Car c'est plutôt les CIUSSS qui nous réfère des usager.es.

#29 • internet

déjà en place

#81 • internet

Nous référons plus souvent aux personnes ayant un accès plus direct avec les services du CIUSSS

q4 — 4. Auriez-vous des suggestions de ce qui pourrait améliorer la connaissance des droits des usagers en santé et services sociaux? Lesquelles?

Propriété annotée : *quelles sont les types d'action proposées*

Résumé des catégories

6 catégories • 101 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Collaborer avec les partenaires de proximité	35	34.7%	NA	NA
Diversifier les formats d'information	34	33.7%	NA	NA
Accompagner individuellement	11	10.9%	NA	NA
Réformer l'organisation et le financement	9	8.9%	NA	NA
Adapter l'accessibilité linguistique/assistive	8	7.9%	NA	NA
Non classable	4	4.0%	NA	NA
Total	101		NA	NA

Collaborer avec les partenaires de proximité (n=35)

#0 •

Des ateliers d'éducation populaire avec les groupes concernés. Par exemple, pour nous, nous avons des ateliers sur les principaux droits en santé mentale, mais aussi sur les LGSSS.

#2 •

Que des personnes du CIUSSS viennent donner un atelier dans notre groupe communautaire.

#14 •

Faire des activités de promotion auprès de petit groupe

#16 •

Nos membres ont la SP et ne savent pas trop vers qui se tourner lorsqu'ils reçoivent un diagnostic malgré le fait que l'on essaie d'être visible dans les cliniques SP.

#23 •

Foire de services

#26 •

Plus de publicité, faire de séances d'informations pour les nouveau arrivants, etc.

#32 •

Que les intervenants les connaissent et s'assurent de les transmettre aux jeunes

#38 •

Plus d'intervention du CIUSSS dans les ressources communautaires, comme les haltes chaleurs

#43 •

Des ateliers pour les groupes communautaires

#53 •

Présentation des services directement auprès de nos membres, à notre équipe de travail aussi afin qu'ils puissent les accompagner

#60 •

Oui, travailler en concertation avec l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS) pour permettre la meilleure connaissance des services parmi les diverses communautés.

#61 •

Créer des liens officiels avec les organismes communautaires. Ces liens pourraient permettre de planifier des séances d'information.

#62 •

Nos services s'adressent à des personnes en situation de handicap et à leurs familles, qui sont souvent rapidement appelées à rencontrer plusieurs médecins, spécialistes et intervenants du réseau.

Il serait pertinent que les établissements de santé, les médecins et les CIUSSS/CIUSSS informent davantage les familles dès les premières démarches, notamment par des références directes, des guides simples, des dépliants ou des outils numériques expliquant les services disponibles, les droits des usagers et les ressources d'accompagnement offertes.

Une meilleure diffusion de l'information dès le début du parcours permettrait aux familles de mieux comprendre le réseau et d'accéder plus rapidement aux services appropriés.

#63 •

Tenir des kiosques ou faire des séances d'information dans les habitations pour les aînés.

#71 •

On aimerait mieux connaître les possibilités de prise en charge sur le plan de la santé mentale. Actuellement, nous référons au 811 option 2.

#72 •

Que les organismes qui en font viennent se présenter à nos résidents

#79 •

venir former les intervenants sur vos services dans chaque organisme et table de concertation

#80 •

Tournée des organismes pour expliquer les droits de usagers.

#81 •

Distribuer l'information aux milieux qui regroupent le plus d'aînés (RDP- organismes communautaires des aînés, etc.

#83 •

Ce sont des ex-détenus fédéraux, donc ils reçoivent beaucoup d'information sur le fédéral mais peu du provincial durant leur incarcération. Possiblement s'assurer que l'info soit transmise aux établissements fédéraux également.

#90 •

Lorsqu'ils viennent dans les organismes communautaires, nous avons des dépliants, des conférences ou des intervenants qui vont au-devant des questions au moment où ils en ont besoin. Lorsqu'ils sont en institutions personnes n'est disponible ou ne prend le temps avec eux. Souvent, ils ont déjà oublié

ce qu'ils ont appris avec nous au communautaire ou ils ne désirent pas contrarié le professionnel. Ils connaissent bien aussi tous les préjugés à leur endroit, entre autres, pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale alors pour ne pas déplaire ils préfèrent se taire.

#96 •

Campagne de présentation des services du CIUSSS ainsi que les façons d'y accéder, selon les besoins, ciblé pour une clientèle adolescente et scolaire.

#101 •

formation avec des organismes communautaires implantés dans le milieu

#107 •

Un manque d'éducation et en procédure judiciaire il n'y a pas les informations nécessaires. Que les partenaires comme les avocats ou les policiers, DPJ offre ces informations plus systématiquement

#113 •

L'information et des partenariats locaux pour l'information et l'éducation

#114 •

Augmenter et améliorer la coordination et les relations entre le milieu communautaire et le CIUSS. Et, quand une personne fait affaire avec un professionnel du CIUSS santé, santé mentale, travail social etc... qu'il y ait une lecture des droits, donc la donner d'emblée aux usagers dès la première fois et faciliter l'accès aux informations

#115 •

De pouvoir faire des partenariats en séances collectives d'information, avec CIUSS, CLSC... et les nouveaux arrivants pour clarifier tout cela

#116 •

Faire un tour dans les ressources pour rencontrer les usagers, car ils ne lisent pas vraiment les dépliants, peut être une présence lors des diners communautaires

#118 •

Les intervenants CIUSS pourrait être plus présent sur le terrain

#120 •

Les ateliers en direct sur le plancher, CIUSS, CLSC pour éclairer les gens du milieu

#122 •

La population masculine a du mal à se soigner donc des campagnes de sensibilisation spécifiques dans le réseau et dans les milieux de travail très masculins : garages, mines, routiers, construction...

#124 •

Plus de proximité avec la population, mais le vrai problème c'est que les gens peuvent connaître leurs droits mais que les services tardent à rentrer

#126 •

Ateliers avec des organismes de défense des droits

#128 •

Les nouveaux arrivants ou les femmes au foyer depuis longtemps sont vraiment moins informés,

mais nous essayons de faire des présentations sur les droits des usagers

#129 •

Au départ il y a des informations qui ne sont pas données : par exemple il y a des informations qui disent qu'il faut passer par le CLSC pour avoir des services, mais rien n'est clair et efficace pour les joindre, ni ce qu'ils offrent vraiment et pourtant nous sommes un organisme communautaire qui sait s'informer

Diversifier les formats d'information (n=34)

#7 •

Envoyer plus souvent des brochures avec cet info pour partager

#8 •

Le principal élément serait d'avoir accès à une information claire, détaillée et accessibles sur les différents services existants et disponibles au sein du CIUSSS.

#10 •

Faire la promotion plus intensive d'un droit par mois, par des affiches invitantes pour les yeux (colorées et dynamiques), des bandes dessinées ou tout autre moyen créatif.

#11 •

At2lier d'information

#17 •

Formation continue enregistrée pour être écouter par le nouveau personne, dépliant, balados

#18 •

Produire des outils clairs, visuels et vulgarisés (infographies, capsules courtes)

Utiliser un langage simple et traduire en plusieurs langues

Faire de la sensibilisation dans les milieux de vie (organismes, bibliothèques, écoles, HLM)

Participer à des événements locaux (kiosques, journées thématiques)

Collaborer avec des organismes communautaires et offrir des services dans les milieux

Rendre les droits concrets (et pas théoriques) : Expliquer comment exercer ses droits (pas juste les nommer) Que faire si je ne suis pas satisfait d'un service? »

#20 •

Kiosques d'information, dépliants informatique.

#22 •

Nous envoyer une liste de tous vos services, qui fait quoi avec des coordonnées à jour.

#24 •

Plusieurs usagers ne connaissent pas pleinement leurs droits ou ne savent pas comment les faire valoir lorsqu'ils rencontrent des obstacles dans le réseau de la santé et des services sociaux. La complexité du système, les barrières linguistiques, la précarité résidentielle, les enjeux de santé mentale ainsi que les expériences négatives passées peuvent aussi nuire à l'accès à cette information.

Pour améliorer la connaissance des droits, il serait utile de :

- simplifier et rendre l'information plus accessible (langage clair, plusieurs langues, formats papier et numériques) ;
- diffuser davantage l'information dans les organismes communautaires, refuges, hôpitaux, CLSC et lieux fréquentés par les populations vulnérables ;
- offrir davantage d'accompagnement pour aider les usagers à comprendre et exercer leurs droits ;
- renforcer les collaborations entre les organismes communautaires et le réseau public afin de mieux orienter les usagers.

#25 •

La méconnaissance des droits demeure un enjeu majeur dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux. Plusieurs pistes concrètes pourraient améliorer cette connaissance.

Sur le plan de la communication et de la sensibilisation, des campagnes médiatiques soutenues et répétées, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et par affichage, permettraient d'ancrer les droits fondamentaux dans l'imaginaire collectif, à l'image de ce qui se fait pour la sécurité routière. Actuellement, la Semaine des droits des usagers, qui se tient à la fin septembre, reste peu connue du grand public. Il serait également pertinent de produire du matériel en langage clair et simplifié, disponible en plusieurs langues comme l'anglais, l'espagnol, le créole, l'arabe et les langues autochtones, ainsi qu'en formats adaptés tels que le braille, la LSQ et les pictogrammes pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Des capsules vidéo courtes, de 60 à 90 secondes, diffusées sur TikTok, Instagram et YouTube pourraient expliquer concrètement un droit à la fois à l'aide de mises en situation.

Sur le plan des établissements, il faudrait rendre systématique l'affichage des douze droits des usagers prévus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans toutes les salles d'attente, chambres d'hôpital, CHSLD et CLSC, avec les coordonnées du commissaire aux plaintes et du comité des usagers bien en évidence. Tout usager admis devrait recevoir systématiquement un document résumant ses droits, accompagné d'une mention verbale de la part du personnel soignant, plutôt qu'un simple papier glissé dans un dossier. Il serait aussi essentiel d'intégrer une formation obligatoire et récurrente sur les droits des usagers pour tout le personnel clinique et administratif, afin qu'il puisse les expliquer et les faire respecter plutôt que de les percevoir comme une menace.

Sur le plan éducatif, les droits en santé pourraient être abordés dans les cours d'éthique, de monde contemporain ou d'éducation à la citoyenneté au secondaire. Plusieurs jeunes adultes ignorent par exemple qu'ils peuvent consulter un professionnel de la santé sans leurs parents dès l'âge de 14 ans. Des ateliers gratuits offerts dans les bibliothèques, les centres communautaires et par des organismes comme l'Appui pour les proches aidants permettraient aussi de mieux outiller les personnes qui naviguent le système au nom de proches vulnérables.

Sur le plan du soutien direct, les comités des usagers et de résidents demeurent largement méconnus. Une présence plus active dans les milieux, par des kiosques, des rencontres et une présence sur les unités, augmenterait leur utilité. Il faudrait aussi mieux faire connaître le rôle du commissaire aux plaintes, puisque beaucoup d'usagers craignent des représailles s'ils portent plainte. Démystifier ce processus et en expliquer la confidentialité rassurerait davantage de personnes. À l'instar du 811, une ligne téléphonique unique et facile à retenir, dédiée aux droits des usagers et offerte avec un soutien multilingue, permettrait un accès rapide à l'information. Un partenariat renforcé avec les organismes communautaires, notamment les Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP), qui font un travail essentiel mais sous-financé, démultiplierait également l'impact sur le terrain.

Sur le plan technologique, une application mobile gouvernementale permettrait de consulter ses droits, de remplir une plainte, de trouver un CAAP ou un comité des usagers près de chez soi, avec des notifications ciblées selon la situation, par exemple lors d'une admission, d'un consentement ou d'un accès au dossier médical. Le Carnet santé Québec pourrait aussi intégrer un rappel des droits

pertinents selon le contexte, notamment au moment où un usager consulte son dossier médical.

En combinant ces différentes avenues, il serait possible d'améliorer réellement la connaissance des droits des usagers et, par le fait même, leur exercice effectif dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec.

#29 •

publicité

#31 •

faire plu de promotion dans les établissement du réseau

#33 •

Les publiciser, les afficher, offrir sessions informations...

#34 •

Un dépliant simple et explicatif des droits en santé et services sociaux (dans des mots simples et accessibles)

#35 •

En faire la promotion....

#36 •

Avoir des outils courts de vulgarisation pour les plus jeunes

#39 •

Des ateliers de sensibilisation, des ateliers portant sur les droits des individus

#54 •

Privilégier des approches de proximité comme des micro-capsules d'information lors des repas, des invitations de conférenciers externes (ex. comités d'usagers du CIUSSS) et des outils visuels simplifiés adaptés aux proches aidants.

#58 •

avoir plus d'information sur le site web, avoir des formations

#68 •

Des affichettes vulgarisées

#77 •

expliquer ce que peut faire le service des droits des usagers

#87 •

Oui.

La publication et la diffusion d'un guide et les sessions d'information sur une base régulière. Incorporer l'explication d'un droit dans chaque bulletin du CIUSSS.

#89 •

Promotion via des organismes communautaires, les réseaux sociaux ;

Développement de formations ;

Offrir des webinaires, des sessions de formations

#92 •

Pamphlets/affiches données systématiquement aux usagers pour les informer de leurs droits, capsules vidéos, informations digestes et synthétiques.

#94 •

-Informer la population des services offerts à travers différentes langues.

-Informer plus régulièrement la population des services offerts (internet, contact des services administratifs des centres communautaires, information partagée dans des lieux précis ex. arrêts d'auto-bus)

#95 •

Mieux expliquer la porte d'entrée et la voie d'accès pour les services en CLSC

#97 •

Sensibiliser et renseigner la population aux services qui sont offerts par des conférences, des portes ouvertes des CLSC, des hôpitaux et autres.

#98 •

Assurer une littéracie plus simple et beaucoup de communication.

#103 •

un site web clair qui résume les droits, surtout avec les récents changements de loi. Notamment besoin d'info sur les recours, et sur la protection de la vie privée avec le déploiement du DSN

#110 •

L'éducation en prévention, à l'école directement

#111 •

Dès qu'un service d'aide est offert, nommer leurs droits, nommer les Comités des usagers, comment fonctionne le CUIUSS

#117 •

Un outil mobile ou toutes les informations seraient au même endroit, et avec code QC applications mobiles pour reconnaître leurs droits, même en posant une question sur téléphone. Nous avons la Boussole de droit, ça pourrait être dans tous les établissements communautaires et au CIUSS

#123 •

Des formations en centre communautaires, des pamphlets pour informer mes usagers

#127 •

Mettre les affiches à jour dans les centres! Les numéros ont changé lorsqu'on appelle! S'assurer que l'info est à jour dans les organismes communautaires

Accompagner individuellement (n=11)

#15 •

Mieux former et outiller le personnel du réseau quant aux mécanismes de relations avec le milieu communautaire, mieux former le réseau quant aux questions de VIH et d'ITSS, adapter les services et les installations du réseau pour répondre aux besoins des personnes marginalisées (utilisatrices

de substances, en situation d'itinérance, en situation de pauvreté, vivant avec des handicaps ou des maladies chroniques, etc.) afin d'éviter la stigmatisation et le rejet de la part du réseau.

#28 •

1. Offrir une formation aux membres des comités, offerte par des avocats du Conseil pour la protection des malades, pour connaître le vrai rôle des comités
 2. Inclure ou mettre en copie le Conseil pour la protection des malades lors de plaintes, revendications ou autre doléance signalée à l'Administration
-

#42 •

Des outils de communications pour les familles dès l'inscription au guichet d'accès, encore mieux si un être humain peut prendre le temps avec eux de leur expliquer leurs droits.

#44 •

Avoir accès à une personne rapidement pour avoir une évaluation et un suivi. Ex : une personne qui a besoin du transport adapté ne devrait pas attendre pour avoir l'évaluation, une personne en détresse psychologique ou en grande perte cognitive ne devrait pas attendre à l'infini pour un suivi

#49 •

Offrir des formations

#66 •

Les personnes transgenres qui consomment des drogues ou qui sont en phase de désintoxication ont besoin de services mieux adaptés à leur réalité – des personnes ayant une expérience vécue dans ces deux domaines. Elles ont besoin d'entrer en contact avec des personnes capables de les comprendre et de les soutenir sans difficulté. Il faut davantage de connaissances et d'empathie.

#69 •

Outils et des formations pour le personnel qui offre les services et devraient mieux connaître les droits des usagers

#76 •

Rappel des droits des usagers à la fin de la période d'hospitalisation et inclure davantage les membres de l'entourage dans ces connaissances

#78 •

Leur en faire part directement lorsqu'ils ont recours aux services

#106 •

L'accès plus facile aux ordinateurs et à l'aide pour trouver le bon service

#119 •

Nous devons les accompagner, mais ce serait bien qu'il y ait une meilleure formation dans le réseau de la santé pour mieux accueillir et prendre en considération la personne comme elle est et de l'accompagner dans l'ensemble de sa réalité (santé mentale, toxicomanie etc...)

Réformer l'organisation et le financement (n=9)

#1 •

Sources de financement permettant directement la mise en place de ressources affectées à ce mandat

#21 •

C'est une chose avoir droits à des services, mais en réalité les listes d'attentes sont tellement longues (des années), et de plus le manque de connaissances lié au TSA chez les employés des CIUSSS est très évident. Souvent les besoins sont difficilement identifiés vu la complexité à communiquer leurs besoins. La détresse vécu par les personnes TSA et leurs familles est souvent aggravé par le manque d'accès à des services adaptés à leurs besoins rapidement.

#85 •

Plus de renseignement sur leurs droits sous forme papier ou électronique (par exemple, le droit de demander de changer de professionnel de la santé, de porter plainte, les processus de plaintes, etc) + une formation à vos travailleurs sociaux et intervenants pivots sur ces droits pour bien les communiquer aux usagers

#104 •

Plusieurs de nos membres connaissent leurs droits, mais c'est le RSSS qui ne les écoute pas.

Que le CIUSSS écoute et tienne compte des besoins réels des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière lorsqu'ils se présentent dans les établissements de santé du réseau et dans les soins à domicile qu'on leur donne.

#105 •

Cela devrait être enseigné au secondaire et au Cégep pour que ce soit un acquis social de connaître ses droits

#108 •

La connaissance existe, on a les power point du CIUSSS, mais c'est vraiment complexe même pour nous les organismes. Les usagers ont parfois des limites, alors l'accès aux services est vraiment complexe à cause d'internet et l'énorme machine de la centralisation des services. Les formulaires pour l'accès général est maintenant en ligne, il y a beaucoup de barrières et les documents sont complexes pour une personne en difficulté

#109 •

Ils connaissent leurs droits et ont besoin d'un médecin, mais il n'y en a pas. On ne fait pas de suivi

#112 •

Centraliser les informations pertinentes car même en tant que professionnel c'est complexe : les pages internet, formulaires, manque de communication entre le communautaire et le CIUSSS etc... imaginez les usagers en détresse!

#121 •

L'organisation des services est très vaste et complexe même pour nous, c'est un gros défi pour les usagers. Des initiatives ciblées pour essayer de donner la bonne information aux intervenants

Adapter l'accessibilité linguistique/assistive (n=8)**#4 •**

Avoir de l'information disponible en plusieurs langues, avoir de l'information disponible pour les gens avec un faible niveau de littératie (pictogrammes etc)

#30 •

Accès à l'interprétation : plusieurs des services sont limités à cause du manque d'interprétation. Malgré que l'interprétation n'est pas un service de notre organisme, on se voit souvent obligé de le faire pour que nos usagers puissent avoir accès aux services... idem pour l'accès au transport aux plus vulnérables et précaires de la communauté.

#40 •

Leur offrir des rencontres d'information sur leurs droits, dans leur langue maternelle.

#65 •

1. Former et sensibiliser le personnel du CIUSSS au respect du droit des usagers sourds de communiquer via un interprète officiel.
 2. Rendre l'information sur les droits de la santé accessible directement en langue des signes (capsules vidéo en LSQ) pour que les usagers connaissent mieux leurs recours.
-

#73 •

avoir un bottin aide et en plusieurs langue et des personne pour les accompagner

#88 •

Un plan de communication adaptée en langue des signe pour les populations sourdes.

#100 •

Le site internet n'est pas toujours clair. Pour ce qui touche la transidentité, c'est généralement refuser parce que le personnel se dit non compétent pour aider la plus part du temps. Alors, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui peut être offert

#125 •

Une vulgarisation des thèmes pour plus de facilité pour les problèmes de scolarisation ou de lecture. Plus inclusif dans comment c'est adresser, j'enlèrerais USAGER en fait et on appèlerait des personnes pour qu'ils puissent se reconnaître. Le terme lui même peut repousser les gens à penser s'y identifier. Adapter de façon plus universelle les termes des procédures et d'accès aux services

Non classable (n=4)

#46 •

Nous ne rencontrons les jeunes qu'une seule fois lors des journées boutique ou les jeunes sélectionnés viennent choisir leurs habits et robes.

#50 •

Non, car quelqu'un qui veut vraiment un service finit par le trouver.

Internet, 811, 211 et listes d'organismes données par de nombreuses cliniques, et organismes connexes

#55 •

On n'a pas d'interaction avec ses besoins.

#70 •

À moins que les personnes aient un problème, ce ne sont pas des informations pour lesquelles il y a de l'information accessible très facilement.

q5__1 — 5.1 Pour quelles raisons sont-ils respectés ?

Question mère (q5) : Sentiment que les droits des usagers sont respectés

Propriété annotée : *Sur quelle base les répondants affirment que les droits des usagers sont respectés (motif ou preuve avancée) ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 44 réponses (34 internet, 10 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Accès/ressources limités (délais, surcharge)	13	29.5%	6	7
Professionnalisme et bonne volonté du personnel	13	29.5%	12	1
Procédures et information formelle en place	8	18.2%	7	1
Incertain / ne sait pas	5	11.4%	4	1
Respect conditionnel selon la situation	3	6.8%	3	0
Manque de connaissance/sensibilisation des usagers	2	4.5%	2	0
Total	44		34	10

Accès/ressources limités (délais, surcharge) (n=13)

#27 • internet

Les services sont accessibles. Les délais sont toutefois importants.

#30 • internet

Les délais sont souvent disproportionnés, le jugement que certains professionnels portent sur les usagers en situation de vulnérabilité, la fermeture de certains à collaborer avec les intervenants du communautaire et à reconnaître leur expertise, ainsi que le roulement du personnel et le manque de suivi.

#34 • internet

Lorsqu'ils ne sont pas respectés pour nos membres, j'en entends parler et je les réfère vers l'ombudsman, le comité des usagers ou la CDPDJ. Cela arrive quelques fois, SURTOUT lors des accouchements en centre hospitalier. Il arrive aussi que les délais raisonnables pour obtenir un service soit largement dépassés (ex. 2 ans et plus pour le DI-TSA)

#71 • internet

Je pense que le système fait ce qu'il peut pour traiter les cas, mais qu'il est débordé

#93 • internet

Les usagers semblent avoir accès au services dont ils ont besoin et je n'entends pas parler de cas où leurs droits n'ont pas été respectés dans leurs démarches.

#95 • internet

Les intervenants font un bon travail mais le temps d'attente pour des familles 0-5 ans est trop long. Les familles sont souvent souffrantes, reçoivent de lourds diagnostics et sont perdus et sans ressources

#106 • téléphone

En général c'est bien, les infirmières sont super. Mais l'accès aux services reste long et difficiles

#113 • téléphone

Par rapport aux suivis qu'on voit les suivis avec les jeunes autonomes mais c'est plus difficile avec les jeunes non autonomes car il manque la relance et l'information plus serrée avec l'utilisateur

#114 • téléphone

On a pas vraiment de retours négatifs, lorsqu'il y en a l'enjeu est surtout les délais et la confusion de prise en charge

#117 • téléphone

Ça arrive que les jeunes soient référés, mais se faire dire qu'ils ne sont pas assez magannés pour avoir des services, il faudrait donc que le CIUSSS devrait prendre en considération toutes leurs problématiques. Parfois c'est difficile pour rejoindre les intervenants en cas de suivis, ou pour des demandes de dossiers ce qui freine les demandes chez nous aussi

#125 • téléphone

J'ai des contacts avec plusieurs personnes du CIUSSS et je sais que c'est important pour eux, mais cela se produit quand même car il y a trop de protocoles dans le réseau qui font que l'utilisateur devient plus un numéro. Et limitation de ce que les intervenants peuvent donner

#127 • téléphone

J'ai des situations où je vois qu'ils sont respectés en général mais il y a des cas où l'attente est trop longue et n'assure la sécurité de la santé

#129 • téléphone

Le délai pour entrer dans le système est trop long, mais une fois entrés le service est là

Professionnalisme et bonne volonté du personnel (n=13)

#3 • internet

Bonne volonté des travailleuses et travailleurs du Réseau.

#14 • internet

Nous constatons que le respect des droits est un élément permanent dans la réflexion des intervenants.

#22 • internet

Le personnel est professionnel et tente d'informer les usagers quand ils réussissent à entrer dans le système.

#23 • internet

Les intervenants considèrent leurs usages et s'efforcent de trouver des solutions créatives pour les aider

#38 • internet

Les équipes du CIUSSS sont plutôt efficaces

#60 • internet

Habituellement les services sont offerts de bonne foi et répondent aux besoins des usagers

#62 • internet

Nous constatons une réelle volonté des intervenants et des établissements de respecter les droits,

la dignité et la sécurité des usagers. Plusieurs professionnels font preuve d'écoute, d'humanité et d'engagement malgré un contexte de forte pression sur le réseau.

Toutefois, les délais d'accès, le manque de ressources, la complexité des démarches et les difficultés de communication peuvent parfois limiter l'exercice concret de certains droits, particulièrement pour les personnes vivant avec un handicap, des besoins complexes ou leurs proches aidants.

#70 • internet

Les intervenants en santé ont à coeur le bien des patients.

#76 • internet

Je constate que le droit aux soins dans les périodes de crise est accordé

#79 • internet

je n'entends pas beaucoup de mauvaises situations et commentaires de la part des gens qui utilisent vos services

#92 • internet

Les personnes reçoivent des services, le consentement est respecté, les proches sont intégrés dans la mesure du possible.

#98 • internet

Les personnes soignantes et y travaillant sont des professionnels qui ont à coeur le bien des usagers

#121 • téléphone

Je n'ai pas eu d'expériences négatives à ce sujet

Procédures et information formelle en place (n=8)

#1 • internet

Protocole universel

#2 • internet

Refus de traitement possible et écouté

Changer d'intervenant.e.s ou de programme au besoin

#7 • internet

Nos clients reçoivent toujours leurs rendez- vous prévus

#10 • internet

Dans nos centres, les droits ainsi que les coordonnées du commissaire aux plaintes sont expliqués à chaque nouvel arrivant, en plus de la promotion d'un droit par mois et de la disponibilité du comité de résidents et des usagers.

#50 • internet

Liberté de consulter où on veut.

#53 • internet

Avec l'arrivée des nouvelles normes, on sent un vent de changement pour le respect des droits mais il reste du travail à faire.

#54 • internet

Oui, assez respectés. Le réseau de la santé s'est doté de mécanismes de surveillance et de recours solides (comme le Commissaire aux plaintes et les comités d'usagers) qui font une réelle différence et permettent de corriger le tir en cas de manquement. De plus, la culture de bientraitance est bien implantée chez les professionnels.

#120 • téléphone

Les droits sont respectés en général lorsqu'ils sont dans le système. Une fois que tout est bien expliqué

Incertain / ne sait pas (n=5)

#32 • internet

En fait, je ne le sais pas. Je crois qu'en général ils le sont mais parfois au niveau du volontariat et de la confidentialité les usages peuvent sentir des lacunes.

#48 • internet

je ny vois pas de problématique associées

#81 • internet

Difficile a évaluer...

#83 • internet

Je n'ai pas d'exemples récents où ils ne le sont pas.

#105 • téléphone

De manière générale il ya de bons services sauf parfois

Respect conditionnel selon la situation (n=3)

#5 • internet

Ils ont le pouvoir de choisir et de consentir à leurs soins. Parfois même s'ils en ont pas tout à fait la capacité malheureusement...

#72 • internet

Ca dépend vraiment des situations. Si la personne a une ordonnance de traitement, là ça se complique si elle n'est pas d'accord avec son traitement.

#100 • internet

J'hésite entre assez et peu respecté. Ça dépend de l'administration et des professionnels de la santé. L'employé à un grand pouvoir sur le respect ou le non respect. Tout le monde peut être respectueux et une personne ne l'est pas et l'expérience devient négative.

C'est mieux qu'avant, mais le mégenrage est encore présent. Certaines places auront une politique pour le prénom choisi d'autre non. Parfois, le personnel n'applique la politique.

Pour des soins réguliers en général ça va bien. Le syndrome du bras cassé est moins présent qu'avant (ex : une personne va pour un bras cassé, mais les services lui sont refusés parce que c'est une personne trans et le personnel ne sait pas comment interagir avec une personne trans, même si ça n'a aucun rapport avec sa transidentité).

Manque de connaissance/sensibilisation des usagers (n=2)

#6 • internet

Ils sont respecté dans la mesure ou les usagers connaissent leurs droits

#58 • internet

je pense que les usagers ne connaissent pas tout leur droits

q5_2 — 5.2 Pour quelles raisons ne sont-ils pas respectés ?

Question mère (q5) : Sentiment que les droits des usagers sont respectés

Propriété annotée : *Quel type de cause principale la réponse identifie-t-elle pour l'irrespect des droits des usagers (informative, structurelle, discriminatoire, professionnelle ou liée à la complexité des usagers) ?*

Résumé des catégories

5 catégories • 58 réponses (46 internet, 12 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Capacités / ressources insuffisantes	30	51.7%	27	3
Discrimination / barrières culturelles	12	20.7%	10	2
Manque d'information	9	15.5%	6	3
Attitudes / formation du personnel	5	8.6%	2	3
Comportements / complexité des usagers	2	3.4%	1	1
Total	58		46	12

Capacités / ressources insuffisantes (n=30)

#0 • internet

Voir les différents portraits situations en santé mentale, entre autres, mais pas seulement. Pensons seulement au droits du consentement libre et éclairé. Sans parler de l'état des lieux, de la réduction du personnel et, du même coup, de la qualité des soins. Ce qui est un droit fondamental.

#8 • internet

Principaux enjeux et obstacles

- Accès fragmenté aux services : Les familles font souvent face à un manque de soutien, à des listes d'attente importantes et à des ressources inadaptées, compliquant l'accès aux soins essentiels.

Défis de l'autodétermination : Le droit des personnes à participer aux décisions qui affectent leur vie est parfois limité par des approches paternalistes ou un manque de mesures d'adaptation. D'autre fois l'autodétermination est utilisée de manière inappropriée et nuit au respect de la personne concernée et de ses besoins réels.

- Milieux de vie inadaptés : Certains usagers se retrouvent dans des lieux qui ne répondent pas à leurs besoins, ou sont victimes d'abus, nécessitant une meilleure protection de leur dignité et de leur sécurité.

- Répit et soutien à la famille : Les familles témoignent souvent d'un isolement et d'un manque de soutien (répit, aide financière), augmentant la pression sur les proches aidants. Elles ne sont pas écoutées voir même trop souvent stigmatisées.

#9 • internet

Les droits ne peuvent pas être respectés, car l'accès est très difficile surtout pour des personnes en grandes vulnérabilité. Les délais sont très long, les besoins ne sont pas toujours compris et ou répondu

#11 • internet

Manque de ressources ou manque de méthodologie

#15 • internet

La centralisation et le décuplement des couches administratives dans le réseau de la santé (notamment Santé Québec, mais également la réforme inachevée de 2015 et la reprise par le réseau de la santé des CLSC et des cliniques communautaires) créent une série d'embûches à l'accès aux soins pour la majorité des personnes, et particulièrement pour les personnes marginalisées.

#16 • internet

Les usagers sont baladés

#18 • internet

Le taux d'insatisfaction semble élevé et les recours ne sont pas simples.

#21 • internet

l'inaccessibilité aux services

#24 • internet

Plusieurs usagers que nous accompagnons rapportent des difficultés à faire respecter leurs droits en raison de délais importants, de la complexité du réseau, du manque d'information sur leurs recours, ainsi que de barrières liées à la langue, à la santé mentale, à la précarité résidentielle ou à la consommation.

Certaines personnes vivant des situations d'itinérance ou de grande vulnérabilité mentionnent également se sentir jugées, non écoutées ou exclues de certaines démarches, ce qui peut nuire à leur confiance envers le réseau.

Le manque de ressources et la surcharge du système peuvent aussi limiter l'accès rapide à des services adaptés.

#25 • internet

Ayant observé l'évolution du réseau québécois de la santé et des services sociaux depuis les 10 dernières années, mon appréciation est nuancée. Les droits des usagers sont globalement reconnus sur le plan formel et légal, mais leur respect dans la pratique quotidienne demeure inégal et, à plusieurs égards, préoccupant.

Sur le plan des acquis, le Québec dispose d'un cadre législatif solide. La Loi sur les services de santé et les services sociaux consacre douze droits fondamentaux, dont le droit à l'information, le droit de recevoir des services adéquats, le droit au consentement libre et éclairé, le droit d'accès à son dossier, le droit de participer aux décisions et le droit de porter plainte. Des mécanismes existent également pour soutenir l'exercice de ces droits, notamment les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, les comités des usagers et de résidents, le Protecteur du citoyen, les CAAP et, dans certains cas, le Curateur public ou la Commission des droits de la personne. Ce cadre est, à plusieurs égards, parmi les plus avancés au Canada.

Cependant, plusieurs constats permettent de douter du respect effectif de ces droits dans la réalité. Le droit de recevoir des services adéquats sur le plan à la fois scientifique, humain et social est régulièrement mis à mal par les délais d'attente, tant à l'urgence qu'en chirurgie, en santé mentale et en première ligne. Des centaines de milliers de Québécois n'ont toujours pas de médecin de famille, ce qui compromet la continuité des soins. Les conditions d'hébergement en CHSLD, mises crûment en lumière lors de la pandémie de COVID-19, ont révélé des atteintes graves à la dignité des personnes âgées. Les rapports du Protecteur du citoyen en témoignent année après année.

Le droit à l'information et au consentement libre et éclairé est souvent appliqué de manière inégale. Plusieurs usagers rapportent ne pas comprendre ce qui leur arrive, recevoir peu d'explications sur les traitements proposés, les effets secondaires ou les alternatives possibles, et se sentir bousculés lors de décisions importantes. Les personnes vulnérables, qu'il s'agisse d'ânés, de personnes ayant

une déficience intellectuelle, de personnes en situation d'itinérance ou ne maîtrisant pas le français ou l'anglais, sont particulièrement exposées à ces lacunes.

Le droit de porter plainte sans crainte de représailles, bien qu'inscrit dans la loi, demeure théorique pour bien des usagers. La peur des conséquences sur la qualité des soins reçus, surtout en CHSLD ou auprès d'un médecin traitant difficile à remplacer, dissuade plusieurs personnes de faire valoir leurs droits. Les délais de traitement des plaintes, parfois longs, découragent également les démarches.

Le droit à l'accompagnement et à la représentation est inégalement soutenu. Les comités des usagers font un travail remarquable, mais leurs ressources sont limitées et leur visibilité demeure faible. Les CAAP, malgré leur rôle essentiel, demeurent sous-financés par rapport aux besoins.

Certaines populations subissent des atteintes plus systémiques. Les peuples autochtones, comme l'a rappelé tragiquement le décès de Joyce Echaquan en 2020, font face à du racisme et à des préjugés qui compromettent directement leur droit à des services respectueux et sécuritaires. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale, particulièrement celles soumises à une garde en établissement ou à une autorisation judiciaire de soins, voient régulièrement leurs droits questionnés par les instances de défense, dont Action Autonomie et le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Les personnes âgées en perte d'autonomie demeurent parmi les plus vulnérables aux atteintes à la dignité et à l'intégrité.

Enfin, la pression exercée sur le réseau par le manque de personnel, l'épuisement professionnel, les réorganisations administratives successives et le sous-financement chronique de certaines missions finit par se répercuter sur les usagers. Un personnel à bout de souffle, même bien intentionné, n'a ni le temps ni l'énergie nécessaires pour offrir l'écoute, l'information et le respect auxquels chaque personne a droit.

Mon sentiment général est donc le suivant : les droits des usagers sont respectés lorsque les conditions le permettent, c'est-à-dire lorsque les ressources sont suffisantes, que le personnel est formé et soutenu, et que l'utilisateur a les capacités ou l'accompagnement nécessaires pour les faire valoir. Mais dès qu'une de ces conditions fait défaut, et elles font défaut trop souvent, les droits deviennent fragiles, parfois virtuels. Il ne s'agit pas tant d'un problème de mauvaise volonté que d'un problème structurel, où le discours officiel sur les droits se heurte à une réalité terrain qui ne permet pas toujours de les honorer pleinement.

Améliorer ce respect passe donc autant par une meilleure connaissance des droits, comme évoqué précédemment, que par des conditions concrètes permettant leur exercice : des ressources humaines suffisantes, une culture organisationnelle centrée sur la personne, une reddition de comptes rigoureuse et un soutien réel aux mécanismes de défense des droits.

#26 • internet

Il est possible que le droit à recevoir des services adaptés à leurs besoins ne soit pas respecté. Le commentaire "cas très lourd" peut être utilisé.

Droit à choisir le professionnel, pas tant respecté, pas bcp de professionnels disponibles pour s'accorder le droit de choisir, longues liste d'attente..

#28 • internet

Au-delà des lois, règlements, politiques et plans d'actions adoptés par les autorités gouvernementales, c'est sur le terrain, dans les établissements que les droits ne sont pas respectés à la hauteur de ce qui est pourtant prévu à ces lois, règlements, politiques et plans d'action. C'est le terrain qui ne livre pas ce qui est décidé par le MSSS ou SQ.

#29 • internet

désorganisation du système pour accéder aux soins et aux médecins. manque de confiance en l'utilisateur qui doit passer par le filtre du médecin de famille ou 811 et perd du temps

#35 • internet

PAs de services ou au compte goutte, pas de transparence car pas de budget, services coupés ou donnés en "périodes".

#36 • internet

Les rendez-vous ne sont généralement pas assez longs pour avoir le temps de poser les questions afin d'être bien informé

Les patients sont limités par les codes postaux quant aux établissements de soins, et surtout peuvent rarement choisir le professionnel qu'ils souhaitent consulter

Le droit de participer aux décisions est aussi rarement respecté

#39 • internet

On ne les consulte pas, on les place en urgence là où il y a de la place, des listes d'attentes

#42 • internet

Souvent les familles ne se font pas offrir les services auxquels ils auraient droit. Souvent, les familles n'ont pas le choix du professionnel qui les accompagne, si elles veulent changer, elles se font couper les services. L'accès aux services est très difficile et un réel casse-tête pour les familles. Dans les deux dernières années, la situation est encore pire.

#44 • internet

Les gens qui sont respectées sont celles qui ont accès aux services... et c'est rare !

#49 • internet

On devrait avoir droit à des services gratuits de qualités et en quantité suffisantes

#63 • internet

La liste d'attente pour certains services ou traitements est excessivement longue. Les requêtes de certains usagers sont rejetées. Des frais sont demandés à certains usagers pour remplir un formulaire p.ex transport adapté.

#68 • internet

Les délais de prise en charge extrêmement longs, de même que la volatilité des équipes et la surcharge du réseau nuisent considérablement à plusieurs droits des usagers.

#84 • internet

La difficulté à voir un médecin. La vitesse à laquelle les hôpitaux mettent les patients dehors faute de places.

#85 • internet

Peu de considération de leurs besoins, surtout pour les personnes qui ont besoin de soutien à domicile. Difficile de se faire entendre par les intervenants pivots. Les services sont de plus en plus coupés malgré les besoins grandissants. Peu de transparence dans les processus d'attribution des heures de soutien à domicile. Accès aux documents internes très difficile malgré la Loi sur l'accès à l'information.

#89 • internet

Énormément de refus et de diminution des services au niveau de l'aide à domicile ;

Méconnaissance des enjeux d'invalidité pour les personnes atteintes de conditions chroniques complexes ;

Absence de prise en charge globale pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et handicapées ;

Manque de financement dans les programmes et les organismes communautaires pour supporter les demandes et les besoins ;

Manque de reconnaissance et de soutien pour les personnes proches aidantes ;

#91 • internet

Très peu de soutien pour les personnes ayant beaucoup de problématiques, pas adaptés pour les organismes, mais considéré comme « trop autonome » pour être en CHSLD. Ils sont peu soutenus pour l'hébergement par le réseau de la santé.

#94 • internet

-Certains usagers mentionnent la difficulté d'accès aux services existants du CLSC (complexité lors de l'inscription au programme offert par le CLSC, délai d'attente ou refus, car ils ne répondent pas aux critères d'admissibilité)

-Certains usagers trouvent de la difficulté à accéder aux services du CLSC dans leur langue d'origine ou en anglais.

#97 • internet

Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecins de famille.

Nous avons dans notre société une population vieillissante qui nécessite des soins. Ces personnes doivent faire des appels pour trouver une clinique pour consultation, renouveler les médicaments. Cette situation crée un stress.

#112 • téléphone

Pas respectés car l'accès aux ressources sont très longues et complexes, même avec les formulaires dit rapides, et la pertinence des demandes sont remises en questions. L'utilisateur n'a pas assez de respect de son droit d'être soigné mentalement ! Beaucoup de cas 1 sur 6 qui sont évalués, on ne parle même pas de suivi qui peut prendre 6 mois d'attente, même en grande détresse psychologique

#118 • téléphone

Les personnes marginalisées n'ont pas d'accès à la santé, mauvaise connaissance de l'utilisateur, mais aussi complexité du système et manque de prise en compte de leurs multi-problématiques

#128 • téléphone

Les personnes qui n'ont pas de médecin de famille, difficile d'avoir des suivis sociaux (lenteur du système bureaucratique et délais...) font que leurs droits ne sont pas nécessairement bien appliqués

Discrimination / barrières culturelles (n=12)

#12 • internet

Particulièrement lorsqu'il est question des populations désaffiliées. Stigmatisation, préjugés, etc.

#13 • internet

aucun accès pour une femme violentée par un partenaire qui n'a pas de statut ou qui n'a pas de carte RAMQ

#17 • internet

Méconnaissance, fermeture d'esprit, préjugés à l'égard de notre clientèle

#19 • internet

beaucoup de préjugés

#20 • internet

Peu pris en considération, vive beaucoup de jugement et discrimination.

#65 • internet

Les droits ne sont pas pleinement respectés en raison des délais excessifs pour obtenir un interprète en langue des signes. Le personnel tarde souvent à faire la demande, et la lenteur du processus d'attribution d'un interprète retarde indûment les soins. Cette barrière systémique compromet l'accès équitable aux services et engendre une détresse psychologique importante (frustration, sentiment d'exclusion) chez les usagers.

#66 • internet

Au fil du temps, les services de santé mentale et les centres de détention ont nié la capacité des usagers de drogues à donner leur consentement de manière active. Cette situation se reflète dans la société, où les usagers de drogues sont ignorés et stigmatisés.

#88 • internet

70 % de l'information que nous recevons nous vient par l'ouïe. 65% de la population sourde de plus de 30 ans est analphabète alors que la majorité des informations disponibles ainsi que les plateformes d'accès au service de santé sont écrites.

#99 • internet

trop de stigmatisation

#101 • internet

discrimination, barrière de la langue, racisme systémique

#116 • téléphone

Leurs droits sont respectés, mais ils peuvent être jugés facilement

#123 • téléphone

Tout la fraction numérique : RDV, annulations etc.... Ce n'est pas accessible pour les aîés c'est difficile

Manque d'information (n=9)

#31 • internet

parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les services auxquels ils ont droits. parceque les usagers ont toujours peur d'avoir des représailles.

#40 • internet

Parce que personne les informe sur leurs droits non seulement de recevoir, mais d'adapter les soins d'accord à leurs besoins.

#61 • internet

La méconnaissance rend peu accessible. Les processus administratifs peuvent aussi être lourd et décourageant pour la clientèle judiciairisé.

#69 • internet

Méconnaissance des droits des usagers et compétition entre les droits des travailleurs et ceux des usagers

#77 • internet

manque de qualité des services, manque de respect de la dignité des usagers, manque d'explication aux usagers

#103 • internet

notre intervention se situe à un autre niveau : à savoir sur le fait que les personnes et communautés doivent avoir leur mot à dire dans les décisions concernant les services sociaux et de santé.

#115 • téléphone

Ils ne les connaissent pas leurs droits, ils doivent venir ici redemander de l'aide pour comprendre, donc peu respectés par manque d'information et de suivi. Il manque de sensibilisation pour les professionnels de la santé par rapport aux diverses difficultés des nouveaux arrivants 9languem, culture, différents réseaux de santé, traumatismes...)

#122 • téléphone

Encore beaucoup d'errance médicale et les intervenants ne respectent pas vraiment les droits en santé mentale et surtout la population ne connaît pas ses droits

#126 • téléphone

Accessibilité des soins et compréhension des droits

Attitudes / formation du personnel (n=5)**#90 • internet**

Les préjugés, le manque de temps, de ressources humaines et financières.

#104 • internet

Le réseau de la santé n'écoute n'est pas toujours à l'écoute des besoins des personnes qui ont une lésion médullaire.

#110 • téléphone

Le manque de crédibilité accordée au vécu, l'expérience et parole de l'utilisateur

#111 • téléphone

Souvent des jeunes ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, il y a un manque de contact humain des intervenant par fatigue, les usagers se sentent parfois comme des numéros

#119 • téléphone

Manque de formation du personnel dans le réseau de la santé pour mieux accueillir et prendre en considération la personne comme elle est et de l'accompagner dans l'ensemble de sa réalité (santé mentale, toxicomanie etc...)

Comportements / complexité des usagers (n=2)

#80 • internet

Nos usagers peuvent déranger, avoir des comportements anti-sociaux, avoir des problématiques complexes, se désorganiser lors des rencontres ou manquer des rdvs.

#124 • téléphone

Il y a trop d'attente et souvent les situations dégénèrent

q5_3 — 5.3 Quelles sont vos suggestions afin de mieux inclure la voix des usagers eux-mêmes dans la défense de leurs droits ?

Question mère (q5) : Sentiment que les droits des usagers sont respectés

Propriété annotée : *quelles sont les types d'action proposées*

Résumé des catégories

6 catégories • 100 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Informers et former	31	31.0%	NA	NA
Faire participer les usagers (comités)	29	29.0%	NA	NA
Simplifier l'accès aux démarches	13	13.0%	NA	NA
Assurer le suivi et l'évaluation (plaintes/sondages)	11	11.0%	NA	NA
Accompagner et soutenir individuellement	7	7.0%	NA	NA
Non classable	9	9.0%	NA	NA
Total	100		NA	NA

Informers et former (n=31)

#0 •

1. Les informer et les accompagner dans leurs droits.

2. les écouter (par exemple, dans le présent débat du PL-23, la garde en établissement, on a toujours refusé d'écouter les premières personnes concernées qui non seulement parlent en leur nom mais qui sont souvent déléguées par leur organisme pour parler au nom de ceux-ci. 3. Les médias et les institutions préfèrent écouter seulement ceux qui pensent comme eux et qui sont "patients partenaires", ex. Luc Vigneault vs les centaines de personnes concernées qui n'ont aucun oreille.

#5 •

Les outiller à comprendre quand ils doivent accepter des soins contre leur gré pour leur bien être. C'est davantage cette partie qui n'est pas clair pour eux selon moi.

#16 •

Mieux les informés sur les services offerts et mieux les diriger. Ainsi ils pourront mieux défendre leurs droits.

#18 •

Offrir de la formation sur les droits et les recours

Proposer un accompagnement individuel ou collectif pour s'exprimer (ex. : soutien pour témoigner ou rédiger une plainte)

Rendre les démarches simples et compréhensibles

Adapter les approches pour rejoindre les personnes marginalisées ou peu entendues

Travailler avec les organismes communautaires pour créer des ponts

Utiliser différents formats (oral, visuel, multilingue)

#19 •

apprendre à écouter et à connaître priorisé la personne

#24 •

Il serait important de consulter directement les usagers sur leurs besoins, leurs expériences et les obstacles qu'ils rencontrent afin qu'ils puissent participer activement aux décisions qui les concernent. Leur voix devrait être intégrée de façon plus systématique dans l'évaluation et l'amélioration des services.

Un changement de culture à l'échelle du système est également nécessaire afin de favoriser des approches davantage centrées sur la personne, le respect, la dignité et la collaboration avec les usagers.

Finalement, davantage de formation et de sensibilisation pour les intervenants sur les réalités des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale, de précarité résidentielle, de consommation ou d'autres formes de vulnérabilité pourrait contribuer à réduire la stigmatisation, les préjugés et améliorer l'expérience des usagers dans le réseau.

#28 •

1. Offrir une vraie formation aux membres des comités, offerte par des avocats du Conseil pour la protection des malades, pour connaître le vrai rôle des comités
 2. Inclure ou mettre en copie le Conseil pour la protection des malades lors de plaintes, revendications ou autre doléance signalée à l'Administration
 3. Faire respectueusement savoir à l'Administration que les comités, CUÉ, CU et CR, formés de bénévoles ont des rôles prévus à la Loi et qu'ils méritent le respect et qu'on s'occupe de leurs demandes
-

#30 •

Une plus grande ouverture et sensibilisation aux plusieurs réalités.

#40 •

Prendre le temps de bien informer les usagers de leurs droits.

#42 •

Les informer.

#53 •

Qu'ils aient plus de connaissance sur leurs droits, que cela soit plus accessible au niveau de la compréhension.

#61 •

Faire la promotion de ces droits avant tout. Les informer puis créer des groupes de travail.

#65 •

1. Créer et diffuser un guide pratique pour le personnel du CIUSSS intitulé : "Comment communiquer avec les usagers sourds, malentendants et sourds-aveugles", incluant une liste des fournisseurs de services d'interprétation et la procédure pour les contacter rapidement.
 2. Instaurer un protocole de suivi transparent pour l'utilisateur : l'informer en temps réel dès qu'un interprète est demandé et lui confirmer sa venue afin de briser l'incertitude et de réduire l'anxiété liée à l'attente.
-

#67 •

davantage de services dans d'autres langues que le français

#70 •

Documentation écrite sur papier est toujours une valeur sûre.

#72 •

Ne sait pas, probablement s'investir dans les organismes de défense et avoir de meilleures connaissances de leur droit.

#77 •

Une meilleure publicité de ce droit, et meilleure explication (vulgarisée)

#88 •

Une information ciblée et adaptée. Un programme de sensibilisation quant à la démocratisation des services et au rôle que peuvent jouer ces acteurs provenant du milieu au sein des comités, des CA de CLSC par exemple, permettant aux organisations de contribuer à la sensibilisation des organismes de la santé et des services sociaux.

#89 •

Favoriser l'éducation sur les droits des usagers ;

Offrir de la formation et de l'accompagnement ;

Présenter des webinaires dans différents milieux ;

S'assurer d'offrir une prise en charge et des parcours de soins adaptés aux différents besoins

#91 •

Mieux communiquer les informations dans les organismes, se montrer présent et disponible.

#93 •

Leur rappeler régulièrement leurs droits afin qu'ils soient en mesure de juger s'ils sont respectés ou non, s'ils peuvent mieux les faire valoir.

#97 •

Être mieux renseigner, avoir un plan de communication plus efficace afin de mieux connaître les services offerts dans les CIUSSS de chaque région. Savoir à qui s'informer si une situation d'abus de pouvoir survient.

#101 •

formation, sensibilisation politique culturelles adaptées

#111 •

Tout est remis sur le communautaire qui pallie, cela devrait être au CIUSS à faire son travail et offrir les bases des droits à tous les usagers de façon plus accessible. Ne pas attendre que la personne vive une situation frustrante que ce soit nommé de prime abord

#115 •

Mieux les informer dans leur langue d'origine

#116 •

Il faudrait qu'ils connaissent leurs droits par les intervenants du CIUSS

#120 •

De meilleures explications des intervenants

#123 •

Connaitre le comité des usagers en premier ! Donc information, car ils ne savent pas ou n'osent pas

#126 •

Que les usagers connaissent mieux leurs droits. Respecter l'expertise des usagers. Informer et éduquer au niveau en partenariat avec les écoles ou les organismes communautaires

#127 •

Mettre à jour l'information dans les centres communautaires car parfois les usagers ne se débrouillent pas seuls

#128 •

L'approche et la sensibilisation de l'information, les dépliants et affiches, électronique n'est pas fameux c'est surtout les informations que l'ont peut leur donner qui est plus efficace, au niveau des interventions en amont

Faire participer les usagers (comités) (n=29)**#2 •**

Continuer de les consulter

#10 •

Mettre des boîtes à suggestion à leur disposition, faire savoir aux usagers lorsqu'une de leur suggestion a été acceptée et mise de l'avant ; rencontre régulière pour en discuter.

#12 •

Créer davantage de maillage communautaire / CIUSS pour démystifier et outiller

#14 •

Activités de promotion en petit groupe dans la communauté

#15 •

Que chaque établissement de santé ait son comité d'usagers, que ce comité ait préséance sur les décisions d'un conseil d'administration, que les usagers aient accès aux bâtiments du réseau de la santé (retirer les agents de sécurité, mettre fin aux pratiques discriminatoires et de stigmatisantes), mettre en place des partenariats avec les groupes communautaires qui défendent les droits des populations, notamment en ce qui a trait d'accès et de droits à la santé.

#23 •

Les inclure dans l'élaboration de projets, règlement et politiques

#25 •

Inclure véritablement la voix des usagers dans la défense de leurs droits suppose un changement de posture important dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux. Trop souvent, les usagers sont consultés de manière symbolique ou tardive, sans que leur parole n'influence réellement les décisions. Plusieurs avenues permettraient de renverser cette tendance.

D'abord, il faut renforcer et valoriser les comités des usagers et de résidents. Ces comités constituent le principal lieu formel d'expression collective des usagers, mais ils demeurent souvent méconnus, sous-financés et parfois perçus comme marginaux par les directions d'établissement. Leur donner davantage de ressources humaines et financières, assurer la formation continue de leurs membres,

protéger leur indépendance par rapport à l'administration et garantir qu'ils soient consultés en amont des décisions importantes, et non seulement informés après coup, permettrait d'accroître considérablement leur influence réelle. Il faudrait également faciliter le recrutement de membres issus de milieux diversifiés, notamment des jeunes, des personnes racisées, autochtones, allophones ou vivant avec un handicap, afin que ces comités reflètent la diversité des usagers.

Ensuite, il est essentiel d'institutionnaliser la participation des usagers et de leurs proches aux instances décisionnelles. Cela signifie leur donner une place réelle, avec droit de vote, sur les conseils d'administration des CIUSSS et CISSS, dans les comités de vigilance et de la qualité, dans les comités d'éthique clinique, ainsi que dans les processus d'agrément. Plusieurs provinces et pays ont avancé davantage sur ce plan, notamment en adoptant des modèles de gouvernance partagée où les usagers participent à la définition des orientations stratégiques. Il faut que leur présence ne soit pas décorative, mais soutenue par une formation adéquate, une rémunération de leur contribution et un véritable pouvoir d'influence.

L'approche du patient partenaire, développée notamment par l'Université de Montréal, mérite aussi d'être généralisée et approfondie. Cette approche reconnaît l'utilisateur comme un acteur à part entière de son parcours de soins et comme porteur d'un savoir expérientiel précieux. Intégrer des patients partenaires dans la formation des professionnels de la santé, dans la recherche clinique, dans l'évaluation des services et dans l'élaboration des politiques publiques permettrait d'ancrer durablement la perspective des usagers dans toutes les dimensions du réseau. Il faudrait toutefois veiller à ce que cette approche ne se limite pas à quelques personnes déjà bien outillées, mais qu'elle s'étende aux populations habituellement moins entendues.

Il serait également pertinent de soutenir davantage les organismes communautaires autonomes de défense des droits. Ces organismes, comme les CAAP, le Conseil pour la protection des malades, Action Autonomie, le Regroupement des comités des usagers du Québec, AGIDD-SMQ ou encore les regroupements autochtones en santé, portent la parole des usagers avec une liberté que les structures internes du réseau ne peuvent offrir. Leur financement demeure précaire et insuffisant au regard de leur mission. Un rehaussement significatif et récurrent de leurs ressources, dans le respect de leur autonomie politique, permettrait de renforcer considérablement la capacité des usagers à faire entendre leur voix, notamment lorsqu'elle est critique envers le réseau.

La création d'espaces sécuritaires d'expression constitue une autre avenue essentielle. Beaucoup d'utilisateurs, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité, hésitent à prendre la parole par peur de représailles ou par manque de confiance envers les institutions. Des forums citoyens, des cercles de parole, des assemblées délibératives ou des démarches de consultation menées par des tiers indépendants permettraient à ces voix de s'exprimer plus librement. Pour les communautés autochtones, cela suppose de respecter les protocoles culturels, de travailler en collaboration avec les conseils de bande et les organisations autochtones, et de reconnaître les savoirs traditionnels en matière de santé et de mieux-être.

Les technologies numériques offrent aussi des possibilités intéressantes, à condition d'être utilisées avec prudence. Des plateformes de signalement anonyme, des sondages d'expérience patient menés de manière indépendante, des applications permettant aux usagers d'évaluer en temps réel leur parcours de soins ou de signaler une atteinte à leurs droits pourraient compléter les mécanismes existants. Il faut cependant s'assurer que ces outils ne creusent pas davantage la fracture numérique et qu'ils demeurent accessibles aux personnes moins à l'aise avec la technologie.

Par ailleurs, il est crucial de mieux entendre les voix traditionnellement marginalisées. Les personnes itinérantes, les personnes vivant avec un trouble de santé mentale sévère, les personnes ayant une déficience intellectuelle, les personnes âgées en perte d'autonomie cognitive, les nouveaux arrivants, les personnes incarcérées recevant des soins, les jeunes pris en charge par la protection de la jeunesse, sont trop souvent absentes des lieux de consultation. Aller à leur rencontre, plutôt que d'attendre qu'elles viennent aux institutions, en collaborant avec les organismes qui les côtoient au quotidien, permet de recueillir une parole autrement inaccessible. Des démarches de recherche participative

menées avec et par ces populations se sont avérées particulièrement fécondes dans d'autres contextes. La formation des usagers eux-mêmes est également un levier puissant. Soutenir le développement de leur littératie en santé et en droits, à travers des ateliers, des guides, du mentorat par des pairs et des formations adaptées aux différentes réalités, augmente considérablement leur capacité à faire valoir leurs droits individuellement et collectivement. Le modèle des pairs aidants, déjà implanté en santé mentale et en dépendance, pourrait être étendu à d'autres secteurs comme la gériatrie, la réadaptation, les soins de fin de vie ou les services en déficience.

Enfin, il importe de rendre le système redevable à l'égard de la parole des usagers. Consulter ne suffit pas si la parole recueillie n'a pas d'effet concret. Il faudrait obliger les établissements à rendre compte publiquement de la manière dont les recommandations des comités des usagers, les plaintes reçues, les résultats des sondages d'expérience et les recommandations des organismes de défense des droits ont été prises en compte ou non, et à justifier les écarts. Cette reddition de comptes transparente enverrait un signal clair que la voix des usagers compte véritablement dans les décisions.

En somme, inclure davantage la voix des usagers dans la défense de leurs droits suppose de passer d'une logique de consultation à une logique de participation véritable, puis à une logique de co-construction. Cela demande du courage politique, un financement adéquat des mécanismes et organismes qui portent cette parole, un engagement soutenu à rejoindre les voix les moins entendues, et une culture de reddition de comptes qui traduit la parole recueillie en changements concrets. Sans ces conditions, l'inclusion des usagers risque de demeurer un discours bien intentionné, mais déconnecté de la réalité vécue par les personnes qui dépendent du réseau pour leur santé et leur bien-être.

#32 •

Leur demander directement ce qu'ils souhaitent. Et s'assurer lors de rencontre comment ils vont et s'ils se sentent respectés.

#35 •

Ecouter les groupes déjà existants du communautaire.

#38 •

Venir les entendre dans les ressources

#39 •

faire partie des comités, avoir une voix à plus haute échelle

#49 •

Les inclure dans la démarche

#54 •

Pour mieux inclure la voix des usagers, il faut privilégier des méthodes de proximité adaptées à leur quotidien : créer des cercles de discussion informels (formule café-causerie), valoriser le partage d'expérience entre pairs (usagers-ambassadeurs) et utiliser des outils d'expression visuels ou simplifiés qui éliminent la barrière de la bureaucratie.

#58 •

les inclure dans les prises des décisions

#60 •

Travailler en concertation avec les milieux communautaires qui les accueillent

#62 •

Impliquer davantage les usagers et les proches dans les décisions qui les concernent réellement ;

Consulter les organismes communautaires et les groupes représentant les usagers plus tôt dans les processus de décision ;

Utiliser un langage plus simple et accessible dans les communications ;

Créer davantage d'espaces de consultation adaptés aux personnes vivant avec des limitations ou des difficultés de communication ;

Reconnaître l'expertise vécue des usagers et des familles comme une contribution essentielle à l'amélioration des services.

#66 •

en choisissant des personnes qui soient parfaitement acceptables pour la majorité de la société afin de représenter le mouvement.

#69 •

Les usagers qui participent à un comité devraient être rémunéré à la hauteur du respect et de la valeur que l'on donne à leur participation dans l'amélioration des soins.

#78 •

Comité usagers, leur demander du feedback systématiquement, consulter les organismes communautaires et adapter les pratiques aux usagers plus vulnérables de la société tel les personnes en situation d'itinérance.

#85 •

Accès direct entre les usagers et les personnes décideuses du CIUSSS.

#90 •

Mettre à leur portée un lieu favorable aux échanges respectueux, sans préjugés et sans que les professionnels les laissent croire qu'eux (les professionnels) savent tout et qu'eux (les personnes concernées) ne savent rien ou ne comprennent rien. Reconnaître le savoir expérientiel.

#92 •

Inclure les usagers dans les réflexions et le développement de nouvelles pratiques, guides et programmes. Encourager une posture d'humilité chez les gestionnaires et les équipes traitantes pour rester ouverts aux perspectives et discours des usagers. Valoriser le vécu expérientiel et le soutien par les pairs.

#96 •

S'assurer d'être transparent lors du partage d'information entre professionnels ou auprès de parents (dans le cas d'un ados de moins de 14 ans - hors danger pour sa sécurité), voir à avoir un comité consultatif afin de cibler les craintes ou les freins aux demandes d'aide ou poursuite de suivi. Voir à faire appel aux jeunes utilisant les services des Aire Ouvertes

#103 •

La participation démocratique des populations est une composante clef du droit à la santé tel que reconnu en droit international. une participation démocratique des populations dans les décisions les concernant en matière de santé. La collectivité doit participer directement à la définition des priorités, à la prise de décisions, à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des stratégies visant à améliorer la situation en matière de santé. À cet égard, la LDL souligne que cette participation est essentielle « pour que les installations, biens et services soient accessibles sans discrimination et que les politiques, programmes et plans d'action tiennent compte des enjeux aux-

quels sont confrontées la population et différentes communautés de notre société ». voir : Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (2000). Observation générale no 14 : Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) au par. 54, E/C.12/2000/4

#104 •

Inclure les personnes ayant une lésion médullaire dans les comités qui discutent des question qui les concernent tant localement au CLSC que dans les établissements hospitaliers et au CIUSSS.

#106 •

comité des usagers, il y a un manque de communication entre le CIUSSS et

#114 •

Améliorer la visibilité et les mandats des Comités des usagers dans le CIUSSS et les organismes communautaires

#119 •

Le Comité des usagers du CIUSSS serait vraiment le bon choix pour aider les usagers à mieux connaître et défendre leurs droits, mais j'aimerais vraiment avoir plus de liens avec eux, car c'est nécessaire. On sait qu'ils existent sans avoir vraiment de relation

#129 •

Je sais bien qu'il y a des comités des usagers car j'ai déjà siégé au CLSC, mais les gens du public ne le savent pas assez. L'information devrait être beaucoup plus donnée largement, les comités et les institutions du CIUSSS devraient faire des représentations et donner des informations plus claires et concrètes aux organismes communautaires. De précis : un téléphone joignable, un courriel efficace

Simplifier l'accès aux démarches (n=13)

#11 •

Plus de ressources

#13 •

Considérer les femmes et enfants victimes de violence conjugale hébergé en hébergement d'urgence au même titre que les personnes sans domicile fixe. Leur permettre l'accès aux services en itinérance puisqu'elles sont elles aussi dans domicile fixe.

#26 •

Diminuer les liste d'attente, faciliter l'accès aux services adaptés aux besoins de la clientèle.

Améliorer les services existents afin de pouvoir offrir des services à une clientèle victime de violence conjugale et atteint d'un TCC.

Faciliter les références aux centres de réadaptation pour les femmes atteignent d'un TCC

#29 •

permettre un accès direct aux spécialistes

#50 •

D'offrir des services adaptés aux personnes dans le besoin et pas juste un 'patching' job...

#68 •

Vulgariser l'information et l'imager

Avoir une ressource dédiée à l'accompagnement lors de défense des droits

Faciliter au maximum les processus d'appels et/ou de plaintes

#98 •

Simplifier au maximum les étapes pour augmenter la compréhension et l'accès.

#105 •

Il faut qu'il y ait des moyens faciles de communiquer lorsqu'il y a une insatisfaction au CLSC et plus direct à un niveau plus humain et proche de l'utilisateur. C'est difficile de trouver pour quelqu'un qui veut se plaindre, et nommer l'insatisfaction fait peur par crainte de perdre le service

#107 •

Plus d'information sur les processus de plainte clairs et d'information sur les bonnes instances d'aide : accessibiliser. Par internet c'est complexe. Lorsque qu'on essaie de rejoindre pour une démarche c'est complexe même pour nous. Les usagers vont vite se décourager que ce soit pour un service ou une plainte

#108 •

Décentraliser pour pouvoir redonner des interlocuteurs à taille humaine. Donc ce sont vraiment les personnes en grande difficulté (immigrants sans la langue, toxico etc...) qui manquent de connaissances et de services en bout de ligne, c'est pas adapté

#112 •

Simplifier l'accès et le donner surtout en santé mentale, soutenir l'utilisateur et débloquer des fonds pour le communautaire

#117 •

Application mobile d'accès à l'information centralisée et d'éducation lors des premières minutes de toute entrevue avec le CIUSS

#125 •

Adapter les mécanismes, de les rendre plus simples, car les procédures sont lourdes pour les personnes en difficultés ou avec des enjeux en santé mentale ou autre...

Assurer le suivi et l'évaluation (plaintes/sondages) (n=11)

#7 •

donner la possibilité aux usagères de répondre à des questionnaires afin de vérifier s'ils connaissent leurs droits

#17 •

Avoir un recours simple pour elleux et surtout, être écouté et pris en considération.

#36 •

Avoir un processus de plainte simple et rapide - des formulaires clairs et courts, des méthodes alternatives pour ceux qui ont de la difficulté avec la compréhension de texte et l'écriture

Avoir un accompagnement soutenu dans le processus

#44 •

Écouter les commentaires et les suggestions de façon humble (pas en se cachant derrière le système et les listes d'attente) et trouver et appliquer des solutions à chacune des embuches mentionnées.

#63 •

Diffuser des messages d'intérêt public dans les médias ; mettre en place des boîtes à suggestions et des lignes d'assistance téléphonique dédiées aux plaintes, et créer des comités d'usagers.

#76 •

Sondage à la fin de la période d'hospitalisation aux usagers sur comment ils ont apprécié les services

#81 •

Peut-être que peu d'utilisateur aînés ne savent pas qu'il existe un tel comité...

#94 •

-Sonder la qualité des services reçus, anonymement, à la fin du suivi.

-Considérer la possibilité d'aller un peu plus loin dans l'offre de service lorsque possible, afin d'éviter de réorienter l'utilisateur ailleurs. Ceci augmenterait leur sentiment d'être entendus dans leur besoin.

#95 •

Faire des suivis réguliers avec les familles en liste d'attente pour entendre leurs besoins et les prioriser

#100 •

Le processus de plaintes sont complexes et ne donne pratiquement jamais de résultat. Le CAP rend ça beaucoup plus facile, mais ça n'a pas de mordant. Les mêmes problèmes continuent d'arriver. Pour faire une plainte à l'ordre, c'est rarement retenu même dans les cas d'agression. Le monde fait pratiquement jamais de plaintes pour ces raisons.

Cela dit, avec les années, le travail des communautés et les plaintes ont amené des changements positifs, mais c'est long. C'est mieux aujourd'hui qu'il y a 15 ans.

En gros, simplifier le système de plainte, avoir un suivi lors d'une plainte et que celles-ci servent à quelques choses.

#113 •

La relance des interventions et sensibilisation auprès des professionnels pour un meilleur suivi du dossier si le jeune ne collabore pas assez

Accompagner et soutenir individuellement (n=7)

#1 •

Financement supplémentaire permettant l'arrimage et la mise en commun de ces voix via l'action communautaire autonome

#8 •

Remettre de l'expertise dans un réseau qui en a perdu beaucoup, plus écouter les proches aidants qui sont des experts de leur proche aidé et changer les pratiques pour que les différents professionnels du réseau aient plus de temps réel à consacrer à l'accompagnement direct. Écouter réellement les usagers et leurs proches est un exercice long et qui prend du temps (en plus d'une expertise), ce temps que les équipes n'ont plus.

#20 •

Avoir des points de contacts dans les organismes pour échanger régulièrement. Assurer une prise en charge et accompagnement des usager.ère.s dans le milieu de la santé.

#33 •

Soutenir leur démarche, leur prise de parole et la défense de leurs droits. Ex. conseillers, accompagnateurs

#34 •

Avoir plus de soutien dans les démarches, car les plaintes sont un parcours du combattant que beaucoup abandonnent en cours de route. Ex, un accouchement difficile durant lequel un enfant et/ou un parent meure ou passe près de mourir suite à des fautes médicales, par exemple, le parent endeuillé n'a pas l'énergie pour mener à terme la démarche.

#118 •

Une approche plus globale de leur santé

#122 •

Il y a des barrières pour les usagers, ils n'ont ni les moyens ni l'énergie. Il faudrait plus de budget dans le milieu communautaire pour aider spécifiquement à la protection des droits et à l'aide des usagers

Non classable (n=9)

#21 •

Le système est trop gros et n'est pas adapté pour répondre rapidement à toutes les clientèles censées être desservies. Tant que les services sociaux vont être jumelés au réseau de la santé, il est difficile que les choses s'améliorent. Une majeure partie du problème est systémique, et ne s'améliore pas malgré tous les plans d'actions, etc. Au lieu de se spécialiser, les services se diluent.

#31 •

pas d'idée

#55 •

Je n'ai pas d'opinion là dessus

#71 •

Aucune idée

#80 •

être tolérant et être en mesure de recevoir certains comportements dérangeant si le respect est maintenu

#83 •

Aucune idée

#84 •

La classe politique est trop occupé ailleurs ou ne sait pas comment arriver à une fluidité des services sociaux.

#87 •

Aucune suggestion

#124 •

Avoir un réel désir gouvernemental, la rigidité et lourdeur administrative qui bloque

q6 — 6. Quels types de situations problématiques votre organisme rencontre-t-il le plus fréquemment en lien avec le respect des droits des usagers ?

Propriété annotée : *Quel est le type principal de problème signalé par la réponse (barrière d'accès, information/communication, confidentialité/consentement, refus/stigmatisation/soins inadaptés, délais/suivi, ou absence de problème) ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 112 réponses (90 internet, 22 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Accès aux services	26	23.2%	25	1
Refus, stigmatisation ou soins inadaptés	25	22.3%	19	6
Manque d'information/communication	18	16.1%	12	6
Délais et suivi insuffisants	17	15.2%	10	7
Aucun problème rencontré	11	9.8%	11	0
Confidentialité et consentement	8	7.1%	7	1
non classable	7	6.2%	6	1
Total	112		90	22

Accès aux services (n=26)

#2 • internet

avoir peur d'être hospitalisé de force en santé mentale

accès aux programmes

#7 • internet

les services disponibles

#9 • internet

Accès à des services

#13 • internet

L'accès aux soins de santé puisqu'elles ne cadrent pas dans aucun service de première ligne tel que les cliniques itinérantes qui permettent aux gens sans domicile fixe d'obtenir des soins

#15 • internet

L'incapacité des personnes à accéder aux ressources de santé : environnement hostile (i.e. gardes de sécurité, personne d'accueil qui doivent contraindre une personne à une grille d'analyse plutôt qu'à son entièreté), bâtiments inaccessibles (loin des transports en commun, manque de rampe d'accès ou d'ascenseur), refus de services (stigmatisation, manque de papiers, usagers à qui on doit parler de manière vulgarisée et simple).

#19 • internet

Impossibilité de relocaliser nos clientes à cause de leur précarité financière et de leur antécédant judiciaire

#21 • internet

l'inaccessibilité aux services quand ils existent, ou tout simplement les services ne sont pas dispo-

nibles pour personnes TSA.

De plus, la lourdeur des démarches administratives en place aux CIUSSS

#26 • internet

Pas d'accès aux services, logue liste d'attente, pas de services adaptés aux besoins, résultats différents de la consultation si la personne est accompagnée ou non.

#32 • internet

L'Accessibilité aux services

Volontariat

Ouverture d'esprit et le non jugement de la part des professionnels.

#36 • internet

L'accès aux soins est compliqué pour les personnes qui ne sont pas déjà dans le réseau, ce qui fait en sorte que plusieurs n'ont pas accès à des services dont ils auraient besoin

#39 • internet

accès à l'habitation, accès à des services de soutien

#41 • internet

la barrière de la langue

#42 • internet

L'accès aux services.

#43 • internet

L'Accès aux services

#48 • internet

les soins podologiques sont un besoin tres présent aupres de la clientele mais non couvert par les CIUSSS, peut de protocole en place pour la prise en charges des problématiques podologiques ni pour la prestations des services au seins des CIUSSS ou CHSLD ou autres instances publiques. Etant un services non couvert par la RAMQ, les usagés ont besoins des services mais l'acces est limité ou inexistant

#49 • internet

Droit au SAD et répit

#59 • internet

Souvent nos usagers se retrouvent en zone grise (sans statut migratoire clair) et n'ont pas accès à vos services. Il y a aussi souvent une barrière de langue.

#61 • internet

Je suis la directrice de l'organisme et j'ai une formation en droit et sincèrement moi-même je n'ai aucune idée de quels droits des usagers vous faites références. L'accès? Si ce sont les droit par rapport à l'accès je dirais que c'est la lourdeur des procédures.

#64 • internet

Difficulté d'accès dans les lieux ou refus d'accès pour les bénéficiaires de chien-guide ou de chien d'assistance

#67 • internet

des services dans leur langue maternelle (pas français)

#69 • internet

Le droit des autochtones à être servi en anglais si c'est leur choix

#80 • internet

difficulté à accéder à des rendez-vous surtout lorsqu'il s'agit de voir un spécialiste. Aussi, passer le triage.

#81 • internet

L'accès aux services...

#91 • internet

Même réponse que précédemment. Je rajouterais qu'il est parfois complexe pour un usager d'avoir un suivi par un travailleur social.

#94 • internet

-Certains usagers mentionnent avoir dû insister avant d'avoir accès aux services d'un CLSC.

-D'autres mentionnent que le nombre de rencontres n'est pas suffisant pour répondre à leur besoin.

-Plusieurs de nos usagers expriment leur besoin d'être reçus dans leur langue d'origine ou en anglais et n'ont pas de réseau personnel pouvant les accompagner à leur rendez-vous au CLSC. Lors du rendez-vous ils constatent qu'il n'auront pas accès à un interprète et par conséquent l'aide qu'ils nécessitent.

#112 • téléphone

Santé mentale, itinérance, manque de ressources et manque de responsabilisation du gouvernement dans les cas difficiles et en demande de réinsertion. Les problèmes de fond de toxicomanie et de santé mentale ne sont pas en compte par le CIUSS et sont retournés dans la rue. Manque d'un organisateur communautaire pour nous aider.

Refus, stigmatisation ou soins inadaptés (n=25)

#4 • internet

Manque de respect, patience, racisme, non présentation de tous les services disponibles

#12 • internet

Pas d'accès aux services, stigmatisation, manque d'adaptation

#17 • internet

Préjugés, refus de traitement, mégenrage, utilisation du "dead name"

#25 • internet

En tant qu'organisme œuvrant dans le domaine des chiens d'assistance pour personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale, l'Académie Stella se trouve à l'intersection de plusieurs réalités où les droits des usagers sont régulièrement mis à l'épreuve. Les situations problématiques rencontrées sont nombreuses, récurrentes, et révèlent à la fois des lacunes dans la compréhension du rôle du chien d'assistance et des préjugés persistants envers les personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

La première catégorie de situations concerne les refus d'accès dans les lieux publics et les commerces. Malgré le fait que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdise la discrimination fondée sur le handicap, incluant le recours à un moyen pour pallier ce handicap comme un chien d'assistance, plusieurs usagers se voient refuser l'entrée dans des restaurants, des épiceries, des taxis, des transports collectifs, des hôtels ou même des établissements de santé. Lorsque le handicap est invisible, comme c'est souvent le cas en santé mentale, les refus sont plus fréquents, car les commerçants ou employés présumant que la personne n'a pas de raison légitime d'être accompagnée d'un chien. Les usagers doivent alors faire la preuve de leur condition, ce qui porte atteinte à leur dignité, à leur vie privée et à leur droit à la confidentialité de leur diagnostic.

La deuxième catégorie de situations concerne les difficultés d'accès aux services de santé et de services sociaux. Paradoxalement, les établissements mêmes du réseau public refusent parfois l'entrée du chien d'assistance, que ce soit dans les salles d'urgence, les cliniques externes, les unités d'hospitalisation, les CLSC ou les CHSLD lors de visites. Certains professionnels de la santé méconnaissent le cadre légal applicable ou invoquent des règles d'hygiène, des allergies ou des protocoles internes pour justifier le refus. Or, priver un usager de son chien d'assistance dans un moment de détresse, particulièrement en santé mentale, peut aggraver considérablement sa condition et compromettre son droit de recevoir des services adéquats, sécuritaires et respectueux de sa personne.

La troisième catégorie touche le logement. Plusieurs propriétaires refusent de louer à des personnes accompagnées d'un chien d'assistance, invoquant des clauses interdisant les animaux, alors que la jurisprudence québécoise et les tribunaux ont clairement établi qu'un chien d'assistance ne constitue pas un animal de compagnie au sens habituel et que son refus peut constituer de la discrimination. Les usagers doivent alors entreprendre des démarches longues et stressantes auprès du Tribunal administratif du logement ou de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ce qui exige des ressources émotionnelles et financières considérables, souvent hors de portée pour des personnes déjà fragilisées.

La quatrième catégorie concerne le milieu du travail et les études. Des employeurs et établissements d'enseignement, malgré leur obligation d'accommodement raisonnable, hésitent ou refusent d'accueillir un chien d'assistance. Les personnes se voient parfois forcées de divulguer des informations sensibles sur leur santé mentale pour justifier leur demande, ce qui les expose à de la stigmatisation et à des conséquences sur leur parcours professionnel ou scolaire.

La cinquième catégorie de situations problématiques est liée à la reconnaissance même du chien d'assistance en santé mentale. Contrairement aux chiens guides pour personnes aveugles, dont la reconnaissance légale et sociale est bien établie depuis longtemps, les chiens d'assistance pour handicap psychologique souffrent d'un déficit de reconnaissance. Au Québec, le cadre réglementaire demeure moins clair que pour d'autres types de chiens d'assistance, et plusieurs instances exigent des preuves, des certifications ou des accréditations qui ne sont pas uniformément définies. Cela crée une zone grise où les droits des usagers sont difficiles à faire respecter, car ils dépendent souvent de la bonne volonté de l'interlocuteur plutôt que d'une application claire de la loi.

La sixième catégorie est celle des préjugés envers la santé mentale elle-même. De nombreux usagers de l'Académie Stella rapportent avoir été traités avec suspicion, condescendance ou incrédulité lorsqu'ils mentionnent qu'ils sont accompagnés d'un chien pour des raisons de santé mentale. Des commentaires tels que « votre maladie ne paraît pas », « vous semblez bien aller pourtant », ou encore « c'est pas un vrai chien d'assistance » minent la dignité des personnes et traduisent une méconnaissance profonde des réalités du trouble de stress post-traumatique, du trouble anxieux sévère, de la dépression majeure, du trouble panique avec agoraphobie, du trouble de la personnalité limite, des troubles dissociatifs ou du trouble du spectre de l'autisme, pour ne nommer que ces conditions.

La septième catégorie concerne le droit à l'information et au consentement éclairé. Plusieurs usagers rapportent que les professionnels de la santé ne connaissent pas l'existence ou l'utilité des chiens d'assistance en santé mentale, et ne les présentent jamais comme une option complémentaire aux

traitements classiques. Le chien d'assistance demeure un outil marginalisé dans l'offre de services, alors qu'il constitue pour plusieurs personnes un soutien déterminant dans leur rétablissement, leur autonomie et leur qualité de vie. Cette absence d'information prive les usagers d'un choix réellement éclairé quant aux moyens qui pourraient les aider.

La huitième catégorie est celle des difficultés administratives et financières. Les chiens d'assistance pour handicap psychologique ne bénéficient pas du même niveau de soutien financier public que d'autres aides techniques. Les frais d'acquisition, de formation, d'entretien, de soins vétérinaires et d'équipement reposent largement sur les usagers ou sur les dons aux organismes comme le nôtre. Cette inégalité de traitement compromet le droit à l'accès équitable aux moyens permettant de pallier un handicap, droit pourtant reconnu par les principes d'équité en santé.

La neuvième catégorie touche les situations de crise et d'hospitalisation. Lorsqu'un usager vit une crise en santé mentale et doit être hospitalisé, la question de la prise en charge du chien d'assistance devient souvent problématique. Les établissements ne permettent généralement pas la présence du chien pendant l'hospitalisation, malgré le rôle thérapeutique que celui-ci pourrait jouer, et les proches ou les ressources communautaires doivent improviser une prise en charge temporaire. Cette séparation forcée peut aggraver la détresse de la personne et complique son rétablissement.

Enfin, une dixième catégorie concerne le manque de recours accessibles. Lorsqu'un usager voit ses droits bafoués, les démarches pour les faire respecter sont complexes, longues et émotionnellement exigeantes. Porter plainte à la Commission des droits de la personne, entreprendre un recours devant un tribunal, contester une décision administrative, tout cela demande de l'énergie que plusieurs personnes vivant avec un trouble de santé mentale n'ont tout simplement pas. Résultat, plusieurs situations discriminatoires ne sont jamais dénoncées, et les pratiques problématiques persistent.

Ces situations, loin d'être isolées, traduisent une double vulnérabilité pour les personnes que nous accompagnons : celle d'être en situation de handicap psychologique, souvent invisible et mal compris, et celle d'être tributaires d'un outil d'assistance, le chien, dont la reconnaissance demeure imparfaite. Les droits des usagers, bien qu'inscrits dans les lois et les chartes, se heurtent quotidiennement à l'ignorance, aux préjugés, aux rigidités administratives et aux limites du cadre réglementaire. L'Académie Stella, à travers son travail de formation, de sensibilisation et d'accompagnement, tente de faire avancer la reconnaissance de ces droits, mais beaucoup reste à faire pour que les personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale puissent exercer pleinement leur citoyenneté, accompagnées de leur chien d'assistance, dans tous les lieux et toutes les situations de la vie quotidienne.

#28 • internet

1. le non-respect des droits que les usagers possèdent en regard du réseau de la santé

#34 • internet

Les droits ignorés ou bafoués durant l'accouchement. Malheureusement, en milieu hospitalier, sans accompagnante à la naissance, il arrive beaucoup trop souvent que les femmes aient des traumatismes qui auraient dûs être évités. Cela arrive même lors d'un accouchement "facile" cela devient presque systématique lors d'accouchement difficile.

Aussi, avec la DPJ, les nouveaux arrivants et les familles ayant une légère déficience.

Le père n'est pas pris en considération par les infirmières les médecins

#50 • internet

Que l'OPQ ait promulgué que la population doivent surtout consulter des psychologues!

#66 • internet

La présence policière est excessive. Les gens sont maltraités et traités comme si c'était pour leur

bien. Les personnes transgenres sont exposées à un danger extrême dans les centres de détention et face à la police : elles sont victimes de nombreuses violences sexuelles et de brutalités. Comment aider les gens alors que la société ne fait qu'aggraver le problème ?

#68 • internet

Des femmes en situation de vulnérabilité qui ont besoin de soins pour leurs enfants et/ou elles-mêmes et qui se retrouvent dans des dédales du CIUSSS de façon interminable et dans des prises en charge complètement déficientes.

#70 • internet

Difficultés des usagers de se sentir écouté par certains professionnels.

#77 • internet

manque de professionnalisme du personnel de santé, refus de donner un service sans justification, incompétence des professionnels de la santé.

#78 • internet

mauvais accueil en raison de profilage, barrières linguistiques, limites de services en raison de précarité de statuts migratoires

#85 • internet

Coupures de services à domicile injustifiées. Mépris du personnel de la santé quant à la situation complexe des personnes en situation de handicap.

#89 • internet

Absence de prise en charge médicale et psychosociale ;

Gaslighting ;

Absence ou coupures de services au niveau des services d'aide à domicile ;

Non respect des besoins biopsychosociaux ;

Manque de reconnaissance des limitations fonctionnelles et des handicaps ;

Manque de connaissances et de formations des professionnel · les de la santé ;

#96 • internet

Une mauvaise expérience avec un · e professionnel · le de la santé (minimiser ce qu'ils vivent, prendre la situation pas assez ou trop au sérieux, ne pas prendre le temps d'expliquer les étapes actuelle et à venir, ne pas les informer d'à qui les informations seront divulgués, avoir un cadre d'intervention avec un manque de flexibilité)

#99 • internet

manque de considération et de souplesse face aux enjeux que peuvent vivre les usagers.

#100 • internet

Les droits aux soins comme l'hormonothérapie. Techniquement, ce n'est pas illégale de prescrire des hormones, mais aucun CIUSSS offre un service aussi simple.

Se faire mégenrer c'est le problème majeur et souvent expliquer que ça doit être le prénom légal, mais lorsque la personne se fait appeler ou offrir des soins ce n'est pas nécessaire de la mégenrer. Ça va nuire aux soins de la personne et elle ne va pas retourner en chercher si elle en a de besoin à nouveau.

Certains professionnels ne sont pas d'accord avec la transidentité et vont refuser d'offrir des services

ou leur aide va s'approcher à la thérapie de conversion. Heureusement ce n'est plus tant fréquent. Les plaintes ne servent presque à rien. Demande beaucoup pour peu de résultats.

#102 • internet

Reconnaissance des séquelles oncologiques par les professionnels de la santé

#104 • internet

Lorsque nos membres expliquent leurs besoins selon leur condition de lésée médullaire, ils ne sont pas écoutés ou pris au sérieux.

#110 • téléphone

le droit de vivre en famille (placement d'enfant pour cause de pauvreté)

#111 • téléphone

Le refus de service et d'aide

#116 • téléphone

Jugement de l'utilisateur (toximanie, itinérance, santé mentale, immigration, difficulté de comprendre le système, pauvreté...)

#119 • téléphone

Stigmatisation, même une forme de peur des personnes en itinérance

#121 • téléphone

Nos situations sont surtout avec la DPJ

#126 • téléphone

Le manque de considération de leur propre expertise et ressentis (handicaps ou santé mentale)

Manque d'information/communication (n=18)

#5 • internet

Comme je dis c'est plutôt l'inverse, ils défendent leur droit même quand ils auraient besoin d'être davantage protégés. Ils devraient être informés sur les cas où ils doivent se laisser aider...

#8 • internet

- Les situations d'hébergement
- Non information ou désinformation sur les services disponibles

#11 • internet

Le manque de connaissances des usagers de leurs droits et leurs difficultés à faire valoir.

#20 • internet

Les gens sont envoyés en refuge sans valider ce qu'il désire, aucune information transférée à l'organisme, ne reçoivent pas les soins adéquats.

#24 • internet

Les situations problématiques que nous rencontrons le plus fréquemment concernent les difficultés d'accès aux services (délais d'attente, difficulté à obtenir un rendez-vous ou à rejoindre les bons services), le manque d'information claire sur les démarches à suivre, ainsi que des enjeux liés à la

continuité des services.

Nous accompagnons aussi des usagers qui rapportent se sentir jugés, peu écoutés ou stigmatisés en raison de leur situation de précarité résidentielle, de leur santé mentale, de leur consommation ou de leur situation socioéconomique.

Certaines personnes vivent également des difficultés administratives (ex. RAMQ, documentation, références) qui peuvent retarder l'accès aux soins et aux services auxquels elles ont droit.

#33 • internet

Difficulté à changer de médecin. Difficulté à avoir toutes l'information sur la médication psychiatrique. Difficulté à être accompagné dans réduction de la médication. Situation de masquage diagnostique lorsque les personnes ayant des enjeux de santé mentale se présentent pour des enjeux de santé physique.

#35 • internet

manque d'information et de prise en charge. Pas de pivot central.

#65 • internet

Les situations problématiques les plus fréquemment rencontrées concernent l'incomplétude des informations essentielles, le fait que certaines étapes soient sautées ou absentes dans les procédures, guides ou ressources disponibles. Avec le temps, ces situations peuvent devenir plus complexes et entraîner des difficultés supplémentaires pour les usagers dans la compréhension et l'accès aux services.

#82 • internet

Difficulté d'entrer en contact avec les personnes ressources du CLSC. Difficile d'obtenir de l'information pour mieux comprendre les services offerts.

Circuit de référence, d'orientation, de suivi et de liste d'attente parfois obscur pour nous à comprendre.

#88 • internet

L'absence d'information et de connaissances. L'absence de mécanisme ou d'interface de communication adaptés, par exemple de services d'interprètes LSQ en cas d'urgence permettant un meilleur accès à nos services de santé. L'absence de messages ciblés invitant à la participation de tous et toutes.

#90 • internet

Le droit à l'information. Ils reviennent avec des médicaments, ne savent pas à quoi ils servent. Difficulté à réduire les doses, etc.

#97 • internet

Lors des rencontre des tables de concertation des quartiers, le langage utilisée par les gens du CIUSSS est hermétique et compris par les autres organismes qui côtoient les usagers . Le citoyen qui représente les aînés, lors de ces rencontres y perd le fil.

#107 • téléphone

Droit à l'informations, ils ne sont pas informés. Il faut tout réexpliquer, même au niveau du système de santé avec les changements internet des dernières années. Ce n'est pas enseigné et pas adapté pour des clientèles en difficulté. quand leur question ou besoins n'entrent pas dans une case, il n'y a pas de suivi ou de personne humaine pour les diriger

#115 • téléphone

Les difficultés de langue et le manque de connaissance des statuts d'immigration (ce qu'ils ont droit ou pas en santé et services sociaux)

#117 • téléphone

Le manque de référencement au bon endroit ou le manque d'accompagnement face à la situation globale du jeune usager. Le CIUSS ne prend pas vraiment en compte notre évaluation ou les efforts du jeune pour se reprendre en main car il ne coche pas toutes les cases

#123 • téléphone

L'accès information et le suivi lorsque l'aîné est seul sans soutien. Parfois, on demande que le suivi soit fait avec l'organisme et il n'y en a pas... Donc manque de communication

#127 • téléphone

Manque d'accessibilité aux information et suivi trop lent

#129 • téléphone

Le manque d'informations claires pour avoir accès aux services et aussi le réseau internet n'est pas accessible à tous pour les aînés, les nouveaux arrivants, ceux qui n'ont pas de technologie ou les compétences...

Délais et suivi insuffisants (n=17)

#27 • internet

Listes d'attente trop longues pour des besoins non urgents, mais auxquels on doit répondre dans un délai beaucoup plus court.

#29 • internet

absence de médecin de famille,

pas de médecins ou de psychologues disponibles, trop de listes d'attente

#31 • internet

dossier perdu et l'utilisateur doit recommencer son processus.

#44 • internet

Le non accès aux services, les délais d'attente qui les mettent dans des situations impossibles. Par exemple, une personne attendue plus d'un an une évaluation pour avoir un transport adapté. Ce transport était essentiel pour aller à l'hôpital recevoir des traitements et une opération. Après 3 fois où l'opération a été remise, faute de transport adapté ou de moyen pour y aller en transport privé, cette personne a perdu son tour et les conséquences sur sa santé sont permanentes.

#53 • internet

Fermeture de dossier alors qu'il y a beaucoup de besoin non répondu

#54 • internet

À l'interne, notre organisme ne rencontre pas de situations problématiques majeures : la culture de respect des droits est bien ancrée et le climat du centre de jour est sain. Les seules tensions extérieures que nous observons concernent les délais du réseau public (ex. : accès à un travailleur social, accès à un psychiatre) qui affectent indirectement la condition de nos usagers.

#62 • internet

Nous observons principalement des difficultés liées aux délais d'accès aux services, au manque de continuité entre les différents intervenants du réseau, à la complexité des démarches administratives ainsi qu'au manque d'information claire pour les familles.

Certaines familles ont également de la difficulté à comprendre les services auxquels elles ont droit ou à faire valoir leurs besoins auprès des différentes instances.

#63 • internet

La liste d'attente pour certains services ou traitements est excessivement longue. Les requêtes de certains usagers sont rejetées. Des frais sont demandé à certains usagers pour remplir un formulaire p.ex transport adapté.

#84 • internet

le syndrome de la porte tournante. Ils ont besoin de plus de services mais on soigne et mets dehors sans travailler sur la ou les causes du pourquoi le patient c est retrouvé a l hôpital.

#95 • internet

Problème d'accès aux places protocoles CLSC-CPE. Les critères d'accès sont variables d'un CLSC à l'autre. De plus, l'attente d'une TS et ensuite l'attente d'une place protocole est de plus 24 mois!

Enjeux majeurs pour trouver qui au CLSC est en charge de l'enseignement du gavage en service de garde.

#105 • téléphone

La plainte recue le plus souvent c'est l'attente et la difficulté d'être aidé, surtout en santé mentale ou autre

#113 • téléphone

Le manque de relance du dossier pour ceux qui ont des difficultés

#114 • téléphone

La prise de position avec les enfants dans les situations problématiques et les retards et confusion face à la prise en charge, les délais sont trop longs

#118 • téléphone

Ne pas de suivi adéquat par rapport à leur demande

#122 • téléphone

La difficulté d'entrer dans le système, l'attente trop longue, alors que les hommes demandent en extrême urgence car ils n'ont pas tendance à demander pour se soigner

#124 • téléphone

Le manque de dossiers pris assez rapidement en charge, il faut des pressions du milieu pour faire accélérer. Il y a désabusement des usagers qui perdent confiance

#128 • téléphone

Les délais trop importants pour recevoir des services (sociaux et santé)

Aucun problème rencontré (n=11)

#3 • internet

Rien à signaler.

#6 • internet

nous ne rencontrons pas vraiment de problème

#10 • internet

Très peu puisqu'il y a une grande écoute et collaboration de la part de la direction. Facilement accessible et ouverte d'esprit.

#16 • internet

Nos membres ne nous en parlent pas vraiment

#18 • internet

je ne suis pas certaine.

#23 • internet

Aucun

#45 • internet

aucun

#55 • internet

N.A

#60 • internet

Sans objet

#71 • internet

Ne sais pas

#83 • internet

Aucune.

Confidentialité et consentement (n=8)

#14 • internet

La tension existante entre la responsabilité de protéger et la recherche d'autonomie et de liberté de choix.

#40 • internet

La confidentialité et le consentement, de ne pas leur avoir averti de leurs droits. Par exemple, droit d'avoir un interprète, un médecin femme ou homme, droit à un soin spirituel ou de leur religion.

#47 • internet

La demande de bailleurs de fonds sur des questions personnelles et qui n'a aucune raison en lien avec l'aide.

Besoin alimentaire : adresse, sexe, âge, langue, etc. ??????

Go Toucan de Moisson Montréal en est un exemple!

#72 • internet

Les ordonnances de traitements, les gens sont peu écoutés quand ils sont non compliant. Aussi, ils

apprennent leur diagnostics en lisant des extraits de dossiers de la cour. Ca frappe, pas d'explication

#76 • internet

Les membres de l'entourage veulent avoir davantage d'informations lors de la période d'hospitalisation, mais les règles de confidentialité empêchent à l'équipe traitante de donner des détails ou parfois même de faire de l'éducation psychologique sur les symptômes.

#92 • internet

Les personnes proches aidantes qui ne sont pas incluses dans les rencontres avec les équipes traitantes même lorsque les usagers donnent leur consentement. Informations trop opaques données aux usagers et à leurs proches, ce qui limite leur capacité à comprendre leur situation, les services et à donner un consentement éclairé.

#101 • internet

violations chartes

#125 • téléphone

Hospitalisations forcées avec la P38. Et une partie de la clientèle ne savent pas vraiment ce qu'ils prennent ou sont mêlés dans les suivis, donc une confusion dans le droit à l'information claire du dossier. dès qu'il y a un historique en santé mentale l'utilisateur n'est pas compris ou cru lorsqu'il a d'autres problématiques de santé physique.

non classable (n=7)

#0 • internet

Voir mission d'Action Autonomie

#1 • internet

Situation de vulnérabilité extrême provoque absence de mise de limites ou d'assurance par les personnes

#30 • internet

Voir les questions précédentes

#38 • internet

le service à l'hôpital

#79 • internet

logement insalubre

DPJ

Crises suicidaire

Aînés en perte d'autonomie

immigration

séparation

#87 • internet

#109 • téléphone

La rénoviction de logement (abusivement)

q7 — 7. Selon votre expérience au sein de votre organisme, quels groupes d’usagers sont les plus vulnérables ou moins bien défendus ?

Propriété annotée : *Quel groupe d’usagers vulnérable est cité comme prioritaire (catégorisation par type de vulnérabilité) ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 118 réponses (93 internet, 25 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Personnes immigrantes/allophones	22	18.6%	15	7
Troubles de santé mentale et dépendance	21	17.8%	13	8
Personnes en situation de handicap / difficultés de communication	20	16.9%	18	2
Femmes et familles vulnérables (mères monoparentales, victimes, trans)	16	13.6%	14	2
Personnes âgées isolées	15	12.7%	12	3
Personnes en situation d’itinérance	8	6.8%	7	1
non classable	16	13.6%	14	2
Total	118		93	25

Personnes immigrantes/allophones (n=22)

#1 • internet

Personnes nouvelles arrivantes

#27 • internet

Les personnes issues de l’immigration.

#29 • internet

les femmes immigrantes, les précaires économiquement ou vulnérables psychologiquement

#40 • internet

Les aînés immigrants

#41 • internet

Immigration sud-asiatique et Africaine

#42 • internet

Les familles issues de l’immigration ayant peu d’éducation.

#59 • internet

mère immigrantes

#60 • internet

Je pense que les personnes nouvellement arrivées et moins alphabétisées ont des niveaux plus élevés de vulnérabilité

#63 • internet

Les aînés issus des communautés culturelles et avant des barrières de langue.

#69 • internet

Autochtones anglophones

#78 • internet

Personnes migrantes ou à statuts précaires, personnes LGBTQ+, personnes en situations d'itinérances, toxicomanes.

#79 • internet

immigration

femmes

ainés

#92 • internet

Les mineurs, les personnes allophones, immigrants, personnes avec des enjeux de santé mentale considérés comme graves, personnes qui connaissent moins le système et qui sont moins aptes à le naviguer de manière autonome, personnes âgées et/ou avec des troubles neurocognitifs.

#98 • internet

Ceux qui ne parlent ni français ni anglais/ les gens avec des statut économique faible et une littéracie faible, les personnes sourdes.

#101 • internet

immigrants, personnes racialisées, nouveaux.elles arrivants

#107 • téléphone

Les personnes issues de l'immigration et les personnes âgées

#108 • téléphone

Les personnes peu scolarisées, ou allophones, ou immigrants récents

#111 • téléphone

Les personnes marginalisées, les migrants, la santé mentale ...

#114 • téléphone

Les familles migrandes qui viennent d'arriver (langue, détresse, culture...)

#121 • téléphone

les populations immigrantes

#122 • téléphone

Les allophones, les immigrés récents qui n'ont jamais eu affaire au réseau

#128 • téléphone

Les femmes âgées et les nouvelles mères immigrantes qui ne connaissent pas les services et les informations (l'inégalité pour l'accès linguistique, culturel, et peur de la DPJ= tous les services gouvernementaux sont dangereux

Troubles de santé mentale et dépendance (n=21)

#0 • internet

Les personnes qui ont des diagnostics en santé mentale

#14 • internet

Les personnes ayant un trouble de santé mentale sévère et persistant.

#15 • internet

Les personnes qui consomment des substances.

#20 • internet

Les gens avec des enjeux plus complexes, santé mentale et consommation.

#25 • internet

Au fil de nos années d'expérience au sein de l'Académie Stella, nous avons pu constater que certains groupes d'usagers vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale sont nettement plus vulnérables et moins bien défendus que d'autres dans le réseau de la santé et des services sociaux. Cette vulnérabilité accrue nous place régulièrement dans l'obligation d'intervenir directement auprès des instances, des professionnels et des administrations, afin que la voix de nos bénéficiaires soit entendue, prise au sérieux et respectée. Sans cet accompagnement soutenu, plusieurs d'entre eux ne seraient tout simplement pas en mesure de faire valoir leurs droits.

Le premier groupe particulièrement vulnérable est celui des personnes vivant avec un trouble de stress post-traumatique sévère, notamment les survivantes et survivants d'agressions sexuelles, de violence conjugale, d'événements traumatiques militaires ou policiers, ou de traumatismes complexes vécus dans l'enfance. Ces personnes présentent souvent une hypervigilance, des épisodes dissociatifs, des réactions de panique dans certains environnements, et une grande difficulté à verbaliser leur expérience, particulièrement devant des figures d'autorité. Lorsqu'elles se retrouvent dans une salle d'urgence, devant un commissaire aux plaintes, un propriétaire ou un employeur, elles sont fréquemment incapables de défendre leur position avec clarté et assurance. Nous devons alors les accompagner physiquement dans leurs démarches, parler en leur nom lorsqu'elles le demandent, rédiger des lettres explicatives, préparer les rencontres avec elles et faire le suivi auprès des instances pour nous assurer que leur parole soit non seulement entendue, mais traitée avec le sérieux qu'elle mérite.

Le deuxième groupe est celui des personnes vivant avec un trouble anxieux sévère ou un trouble panique avec agoraphobie. Pour elles, le simple fait de sortir du domicile, de se présenter à un rendez-vous ou de téléphoner à un service peut constituer un obstacle majeur. Les démarches administratives, déjà complexes pour la population générale, deviennent pour elles des montagnes infranchissables. Nous les accompagnons dans leurs déplacements, nous nous présentons avec elles aux rendez-vous médicaux, nous intervenons lorsqu'un commerçant refuse leur chien d'assistance, et nous portons leur voix lorsqu'elles se retrouvent paralysées par l'anxiété au moment crucial où elles devraient faire valoir leurs droits. Sans cet appui, ces personnes abandonneraient fréquemment leurs démarches, renonçant à des services auxquels elles ont pourtant pleinement droit.

Le troisième groupe concerne les personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite. Ces personnes souffrent souvent d'une instabilité émotionnelle qui les rend particulièrement vulnérables dans leurs interactions avec les institutions. Elles sont régulièrement étiquetées comme « difficiles », « manipulatrices » ou « non collaboratives » par le personnel soignant, ce qui teinte négativement la perception de leurs demandes légitimes. Lorsqu'elles dénoncent une atteinte à leurs droits, leur parole est souvent minimisée ou interprétée comme une manifestation de leur trouble plutôt que comme une plainte fondée. L'Académie Stella doit alors se faire leur voix, crédibiliser leur parole auprès des instances, et rappeler que leur diagnostic ne diminue en rien la validité de leurs droits.

ni la légitimité de leurs revendications.

Le quatrième groupe, particulièrement mal desservi, est celui des personnes vivant avec des troubles dissociatifs, incluant le trouble dissociatif de l'identité. Ces conditions, encore largement méconnues et stigmatisées, y compris parmi certains professionnels de la santé, placent les personnes dans une situation où leur parole est systématiquement remise en doute. Nous rencontrons régulièrement des usagers qui se font dire que leur condition « n'existe pas » ou qui sont soupçonnés de simulation. L'Académie Stella joue alors un rôle crucial de défense et d'éducation auprès des intervenants, fournissant de la documentation, rappelant les consensus scientifiques actuels et insistant pour que ces personnes reçoivent des services adaptés et respectueux.

Le cinquième groupe est celui des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, particulièrement les adultes chez qui le diagnostic est venu tardivement. Ces personnes rencontrent des difficultés importantes dans les interactions sociales, la communication verbale sous pression et la navigation des systèmes complexes. Elles peuvent être perçues comme froides, distantes ou inadéquates, ce qui nuit à l'accueil de leurs demandes. Nous les accompagnons en traduisant, en quelque sorte, leur réalité aux institutions, en préparant des documents écrits pour appuyer leurs démarches orales, et en nous assurant que les accommodements nécessaires leur soient réellement offerts plutôt que simplement mentionnés.

Le sixième groupe particulièrement vulnérable est celui des personnes ayant vécu une hospitalisation psychiatrique involontaire ou ayant fait l'objet d'une garde en établissement. Ces personnes portent souvent le poids d'une méfiance institutionnelle persistante. Leur dossier médical les suit, teinté d'interprétations qui peuvent nuire à leurs démarches ultérieures. Lorsqu'elles tentent de faire valoir un droit, on leur oppose parfois implicitement leur historique, comme si celui-ci disqualifiait leur parole actuelle. L'Académie Stella doit alors travailler sans relâche pour rétablir leur crédibilité, rappeler que leur condition présente est stable, et insister pour qu'elles soient traitées avec la même dignité que tout autre usager.

Le septième groupe concerne les personnes cumulant plusieurs vulnérabilités, notamment celles vivant à la fois avec un trouble de santé mentale, une situation de précarité économique, un statut d'immigration précaire, une appartenance à une minorité sexuelle ou de genre, une origine autochtone ou une barrière linguistique. Ces personnes subissent une discrimination intersectionnelle qui multiplie les obstacles à l'exercice de leurs droits. Elles sont parmi celles qui ont le plus besoin d'un chien d'assistance, mais aussi parmi celles qui rencontrent le plus de résistance lorsqu'elles souhaitent en obtenir un ou le faire accepter dans les différents lieux de leur vie. Notre organisme doit alors déployer un accompagnement particulièrement intensif, travailler en collaboration avec d'autres organismes communautaires spécialisés et, parfois, mener de véritables batailles administratives et juridiques pour que leurs droits soient reconnus.

Le huitième groupe est celui des anciens combattants, des vétérans, des premiers répondants et du personnel correctionnel vivant avec un trouble de stress post-traumatique lié à leur emploi. Bien qu'ils bénéficient parfois de programmes spécifiques, ces personnes se heurtent souvent à une culture du silence, à une difficulté à demander de l'aide et à des préjugés sur leur « solidité ». Lorsqu'ils finissent par faire appel à un chien d'assistance, ils rencontrent fréquemment des résistances, tant dans leur milieu de travail que dans leur entourage immédiat, et ont besoin d'un accompagnement constant pour faire respecter leur nouveau statut et leurs besoins d'accommodement.

Le neuvième groupe, trop souvent oublié, est celui des jeunes adultes en transition entre les services pédiatriques et les services aux adultes. Ces jeunes, souvent suivis depuis l'enfance pour des troubles anxieux, dépressifs ou liés au spectre de l'autisme, se retrouvent brusquement sans filet de sécurité lorsqu'ils franchissent le cap de la majorité. Leurs parents ne peuvent plus intervenir au même titre qu'auparavant, les services aux adultes sont moins coordonnés, et leur maturité pour naviguer seuls dans le système est souvent insuffisante. L'Académie Stella devient alors, pour plusieurs d'entre eux, un relais essentiel qui les accompagne dans leurs démarches, parle en leur nom lorsque nécessaire et les outille progressivement pour qu'ils puissent défendre eux-mêmes leurs droits.

Enfin, le dixième groupe particulièrement vulnérable est celui des personnes isolées socialement, sans réseau familial ou amical. Pour ces personnes, le chien d'assistance est parfois le seul compagnon du quotidien, et l'Académie Stella constitue souvent le seul interlocuteur humain régulier en dehors des rendez-vous médicaux. Leur isolement les rend particulièrement vulnérables aux abus, aux négligences et aux atteintes à leurs droits, car personne d'autre qu'elles-mêmes ne peut témoigner de ce qu'elles vivent. Notre rôle devient alors crucial : nous sommes parfois les seuls témoins extérieurs de leur réalité, les seuls à pouvoir alerter les instances compétentes lorsque quelque chose ne tourne pas rond, les seuls à pouvoir porter leur voix jusqu'aux décideurs.

Dans toutes ces situations, l'Académie Stella ne se limite pas à former des chiens d'assistance et à les jumeler à des bénéficiaires. Notre mission s'étend bien au-delà : nous devons aider activement nos bénéficiaires à traverser les obstacles administratifs, les suivre dans la durée pour nous assurer que leurs droits continuent d'être respectés une fois le chien remis, les accompagner physiquement lorsque cela est nécessaire dans les démarches les plus difficiles, et parler en leur nom lorsque leur condition les empêche de le faire elles-mêmes. Nous rédigeons des lettres, nous intervenons auprès des commerçants, des propriétaires, des employeurs, des établissements de santé et des instances gouvernementales. Nous les préparons aux rencontres importantes, nous les soutenons émotionnellement avant, pendant et après ces démarches, et nous assurons un suivi rigoureux pour que rien ne tombe entre les mailles du filet.

Cette réalité impose à notre organisme une charge considérable qui dépasse largement son mandat initial. Elle révèle surtout une lacune profonde du système : ces personnes, qui sont parmi les plus vulnérables de notre société, ne disposent pas, en dehors d'organismes comme le nôtre, d'un accompagnement structuré et constant pour faire valoir leurs droits. Sans l'Académie Stella, plusieurs d'entre elles ne seraient ni entendues, ni prises au sérieux, ni défendues. C'est pourquoi le soutien à des organismes comme le nôtre, qui portent au quotidien la voix des usagers les plus fragilisés, constitue à notre avis un enjeu fondamental pour le respect réel et non seulement formel des droits des personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale au Québec.

#36 • internet

Les jeunes (en bas de 18 ans)

Les personnes avec des problématiques en santé mentale

#37 • internet

Personnes ayant des problème de santé mentale et de toxicomanie

#71 • internet

Tous nos usagers sont susceptibles d'être vulnérables, car ils ont subi un choc important, se traduisant par du stress post-traumatique. Ils ont besoin d'aide psychologique, mais peinent à trouver des ressources au privé, et certains n'ont pas les moyens financiers pour ces ressources

#72 • internet

Nous ne recevons que des gens ayant des troubles psychotiques, mais ceux avec ordonnance de traitement sont les plus touchés.

#77 • internet

Les aînées (particulièrement quand la démence a commencé à s'installer) et les handicapés. Les personnes qui sont aux prises avec de la détresse psychologique et les toxicomanes alcooliques.

#80 • internet

les personnes qui consomment des drogues, les personnes avec des problématiques de santé mentale.

#84 • internet

La santé mental.

#90 • internet

Présentant des troubles mentaux.

#112 • téléphone

Les hommes : santé mentale et toxicomanie par manque de ressources

#113 • téléphone

jeunes moins soutenus par leur entourage, ou problème de toxicologie ou santé mentale

#116 • téléphone

ceux qui ont des problématiques en santé mentale

#117 • téléphone

santé mentale, minorités visibles

#119 • téléphone

Situation d'itinérance et personnes qui consomment des drogues

#120 • téléphone

Les personnes qui ont des problématiques en santé mentales et diagnostics de déficience intellectuelle et les très jeunes ou les très vieux

#125 • téléphone

Les gens qui ont des enjeux en santé mentale.

#126 • téléphone

Les handicaps invisibles (santé mentale, maladie de chron, déficience intellectuelle...)

Personnes en situation de handicap / difficultés de communication (n=20)

#6 • internet

les personnes handicapées intellectuelles

#8 • internet

Les personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans autisme. Que la déficience soit légère, moyenne ou sévère.

#21 • internet

les personnes handicapées, non-verbales, ou multihandicapées

#24 • internet

Selon notre expérience, les personnes les plus vulnérables sont souvent celles qui vivent plusieurs réalités simultanément. Ces enjeux sont rarement isolés — l'itinérance ou la précarité résidentielle, les enjeux de santé mentale, la consommation, la pauvreté, l'isolement social et les difficultés administratives s'entrecroisent souvent et amplifient la vulnérabilité des usagers.

Nous observons également une augmentation du nombre de personnes âgées et de très jeunes adultes qui contactent notre organisme, souvent en raison d'isolement, de difficultés financières, de logement ou d'un manque de soutien pour naviguer les services.

Nous remarquons aussi une hausse de personnes vivant avec des handicaps ou des réalités de neurodiversité (ex. personnes malvoyantes, malentendantes/sourdes, autistes, ou vivant avec des limitations à la suite d'accidents), qui rencontrent parfois des obstacles supplémentaires pour accéder à des services adaptés à leurs besoins.

Certaines femmes vivant des situations de vulnérabilité peuvent également être davantage à risque, particulièrement lorsque plusieurs déterminants sociaux de la santé se cumulent.

De façon générale, ce sont souvent les personnes vivant à l'intersection de plusieurs formes de précarité qui sont les moins bien défendues et qui rencontrent le plus d'obstacles dans l'accès à leurs droits.

#31 • internet

personne handicapées et âgées

#35 • internet

parents de personnes ayant une déficience intellectuelle.

#39 • internet

Les personnes ayant une déficience intellectuelles isolées

#46 • internet

les enfants qui ont des suivis avec la DPJ ou nos jeunes transgenres, les jeunes handicapés

#53 • internet

personnes ayant une déficience intellectuelle n'ayant pas ou peu d'entourage pour les soutenir

#58 • internet

les personnes qui vivent avec l'épilepsie mais qui n'ont pas d'autre handicap

#62 • internet

Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou des limitations importantes, particulièrement lorsqu'elles ont des difficultés de communication ou peu de soutien familial, sont parmi les plus vulnérables.

Les proches aidants vivant de l'épuisement ou ayant une faible connaissance du réseau peuvent également avoir davantage de difficulté à défendre leurs droits et ceux de leurs proches.

#64 • internet

Les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et ou avec un déficience intellectuelle.

#65 • internet

Selon notre expérience, les usagers les plus vulnérables sont souvent les personnes ayant des difficultés de communication, un faible accès à l'information, un isolement social ou vivant plusieurs problématiques simultanément. Ces situations peuvent limiter leur compréhension des procédures, leur capacité à défendre leurs droits et leur accès adéquat aux services et ressources disponibles.

#85 • internet

Personnes en situation de handicap, en particulier les femmes, les personnes racisées et les personnes en pertes cognitives

#88 • internet

EN générale les personnes en situation de handicap de la communication ; sourds, sourds aveugles, autistes et malentendants

#91 • internet

Déficiência intellectuelle, autisme, personne à statut précaire, personne âgé.

#93 • internet

Ceux ayant des déficiences cognitives ou autres problématiques de santé affectant leur capacité à appréhender la réalité.

#104 • internet

Ce sont les personnes qui ont une lésion à la moelle épinière.

#109 • téléphone

les personnes a ressources mentales et physiques limitées

#127 • téléphone

ceux qui ont des limitations mentales ou de scolarisation... peu de capacité à aller sur internet. Ils abandonnent rapidement

Femmes et familles vulnérables (mères monoparentales, victimes, trans) (n=16)

#2 • internet

travailleuses du sexe

personnes trans ayant besoin de chirurgie de réaffirmation de genre

femmes

personnes en situation d'itinérance, de consommation

#9 • internet

femmes vulnérables souvent très stigmatisée par les enjeux qu'elles vivent (consommation, travail du sexe, pauvreté, etc)

#13 • internet

les femmes et les enfants victimes de violence conjugale

#17 • internet

Les femmes trans, personnes trans et non-binaire

#19 • internet

les femmes

#26 • internet

Les femmes avec un statut d'immigration précaire, les femmes allophones, les femmes atteignent d'un TCC, les femmes avec des situations de santé multiples (physique et mentale)

#34 • internet

Les nouvelles mamans (1er accouchement); les nouveaux arrivants;

Les pères (la majorité ne sont pas pris en compte lorsqu'il est question de leurs enfants)

#66 • internet

trans, travailleuses de sexe, migrantes et réfugiées

#68 • internet

Les femmes racisées cumulant les facteurs de vulnérabilité.

#82 • internet

Femmes marginalisées.

Femmes trans.

#94 • internet

-Les femmes monoparentales

-Les personnes âgées

-Les usagers ayant un trouble de santé mentale non diagnostiqué

#95 • internet

Les familles d'enfants handicapés (grand enjeux à se déplacer au CLSC pour les suivis)

Les familles immigrantes ou demandeurs d'asile

Les mères mono parentales (elle travaillent, pas le temps de voir une TS entre 9h-5h)

#97 • internet

femmes âgées ayant des revenus insuffisants pour vivre, se loger, s'habiller.

femmes âgées qui sont proches aidants

#100 • internet

Travaillant auprès des personnes trans, je vais mentionner la communauté trans. Davantage les personnes trans féminines migrantes et racisées. Le système étant en partie misogyne et raciste, ces personnes ont souvent des moins bons services.

#110 • téléphone

Les mères

#115 • téléphone

nouveaux arrivants, surtout les femmes monoparentales et les demandeurs d'asile et statuts précaires. Ou les pertes de documents suite à troubles mentaux et les soins en santé mentale car les délais sont trop longs

Personnes âgées isolées (n=15)

#4 • internet

Les personnes âgées, isolées, les personnes allophones, et les personnes avec une compréhension basse du français

#5 • internet

Je dirais les personnes plus âgées qui connaissent moins bien leurs droits. Les plus jeunes sont bien informés.

#16 • internet

Les personnes en situation de pertes cognitives et itinérance. Bien que l'on parle souvent des personnes âgées, il n'en demeure pas moins que les personnes âgées sont de plus en plus informées car

cette clientèle change depuis les 20 dernières années.

#30 • internet

Aînés

#44 • internet

Les personnes âgées en situation de vulnérabilité et isolées seules à domicile

#45 • internet

person age

#54 • internet

Les usagers isolés sans réseau familial actif, qui n'ont personne pour naviguer dans la bureaucratie ou revendiquer des services en leur nom.

Les personnes présentant des pertes cognitives, qui perdent graduellement la capacité d'exprimer elles-mêmes leurs besoins et de défendre leurs choix.

#67 • internet

personnes âgées

#70 • internet

Les aînés et les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

#81 • internet

Les aînés qui sont seuls...

#87 • internet

Les aînés à risque de démence, ou qui sont atteints de la démence et leurs proche aidants.

#102 • internet

Personnes âgées, faible revenu

#106 • téléphone

Les personnes âgées 85 et plus et surtout les personnes seules sans soutien familial

#123 • téléphone

Les personnes âgées en perte d'autonomie et sans soutien familial

#129 • téléphone

Les aînés qui n'ont pas accès et connaissance de la technologie et nouveaux arrivants langue et méconnaissance du système

Personnes en situation d'itinérance (n=8)

#12 • internet

Itinérance, Santé mentale, dépendance

#18 • internet

les personnes en situation d'itinérance

#28 • internet

- ceux qui sont seuls, souvent pauvres, souvent sans proches, famille ou amis pour les appuyer lorsqu'ils ne sont pas traités selon la Loi

#38 • internet

la population itinérante

#61 • internet

Les personnes qui retournent souvent en détention ainsi que ceux qui ont de la difficulté à lire ainsi qu'une méconnaissance des nouvelles technologies.

#83 • internet

Les itinérants

#99 • internet

Les personnes en situation d'itinérance et vivant avec des enjeux de dépendance et de santé mentale.

#118 • téléphone

les personnes sans revenus ou en itinérance

non classable (n=16)

#7 • internet

RPCE

#11 • internet

Même réponse qu'à la question 6

#23 • internet

Aucun

#32 • internet

Les jeunes marginalisés

#33 • internet

Ceux qui

#43 • internet

Pour notre part, nous travaillons avec les 16 35 ans

#49 • internet

Tous les gens à domicile

#50 • internet

Les plus démunis

#52 • internet

Nous travaillons seulement avec les personnes de moins de 18 ans.

#55 • internet

N”A

#73 • internet

femme enfant et femme enceinte et homme seul

#76 • internet

Les membres de l’entourage (famille, parent, amis, conjoint.e). Les proches veulent aider mais ne peuvent avoir accès à l’information pour mieux soutenir.

#89 • internet

L’ensemble de la patientèle de notre Association souffrent du manque de connaissance et de reconnaissance des besoins des personnes atteintes d’encéphalomyélite myalgique.

#96 • internet

Au niveau de la vulnérabilité, les ados sont dans une période charnière de leur développement et on sait que d’intervenir rapidement aidera à un rétablissement tout aussi rapide.

#105 • téléphone

Pas un groupe en particulier

#124 • téléphone

Les enfants

q8 — 8. Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers ?

Propriété annotée : *Quel type principal d'obstacle l'auteur identifie-t-il pour l'exercice des droits des usagers ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 108 réponses (84 internet, 24 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Méconnaissance / manque d'information	33	30.6%	25	8
Accès limité / manque de ressources	26	24.1%	16	10
Complexité bureaucratique et procédurale	16	14.8%	14	2
Manque d'accompagnement / peur et épuisement	13	12.0%	10	3
Barrière linguistique et communication	11	10.2%	10	1
non classable	9	8.3%	9	0
Total	108		84	24

Méconnaissance / manque d'information (n=33)

#5 • internet

La compréhension.

#6 • internet

la non connaissance de leurs droits

#12 • internet

Ne connaisse pas leurs droits et se disent que de toute façon, ça ne servira à rien.

#18 • internet

la connaissance des droits

#24 • internet

Selon nous, les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers incluent le manque d'information claire sur leurs droits et les recours disponibles, ainsi que la complexité du réseau de la santé et des services sociaux, qui peut être difficile à naviguer.

Les délais d'attente, le manque de ressources, les barrières administratives et linguistiques peuvent également freiner l'accès aux services.

Nous observons aussi que la stigmatisation liée à la santé mentale, à la consommation, à l'itinérance, au handicap ou à d'autres situations de vulnérabilité peut nuire à la qualité des services reçus et décourager certaines personnes de demander de l'aide.

Enfin, plusieurs obstacles sont liés aux déterminants sociaux de la santé — pauvreté, instabilité résidentielle, isolement social, handicap, neurodiversité, traumatisme — qui peuvent limiter la capacité des usagers à défendre leurs droits dans un système déjà complexe.

#25 • internet

À partir de l'expérience quotidienne de l'Académie Stella auprès des personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale, nous pouvons identifier plusieurs obstacles majeurs qui entravent l'exercice réel des droits des usagers dans le réseau de la santé et des services

sociaux. Ces obstacles sont de nature diverse, parfois structurels, parfois culturels, parfois strictement individuels, mais ils se conjuguent généralement pour créer un parcours semé d'embûches, particulièrement décourageant pour des personnes déjà fragilisées.

Le premier obstacle, et sans doute le plus fondamental, est la méconnaissance des droits eux-mêmes. Beaucoup d'usagers ignorent tout simplement qu'ils ont des droits, ou ne connaissent pas l'étendue réelle de ceux-ci. Le Code civil du Québec, la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et plusieurs autres textes juridiques consacrent pourtant des protections importantes. Mais sans connaissance de ces protections, il est impossible de les invoquer. Cette méconnaissance est encore plus prononcée chez les personnes ayant un faible niveau de littératie, chez les nouveaux arrivants, chez les personnes âgées ou chez celles vivant avec une déficience intellectuelle en plus d'un trouble de santé mentale. L'information disponible, souvent rédigée dans un langage juridique ou bureaucratique, demeure inaccessible à une grande partie de la population qui en aurait pourtant le plus besoin.

Le deuxième obstacle est la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale. Malgré les campagnes de sensibilisation des dernières années, les préjugés demeurent profondément ancrés dans la société et, trop souvent, au sein même du réseau de la santé. Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale voient régulièrement leur parole minimisée, réinterprétée à travers le prisme de leur diagnostic, ou purement et simplement écartée. Lorsqu'une personne en détresse psychologique tente de dénoncer une atteinte à ses droits, on lui répond trop souvent que sa perception est faussée par sa condition, plutôt que d'examiner sérieusement la situation qu'elle décrit. Cette stigmatisation constitue un obstacle invisible mais redoutable, car il décrédibilise d'entrée de jeu la parole des personnes concernées.

Le troisième obstacle est la complexité administrative et bureaucratique du réseau. Pour faire valoir un droit, il faut souvent naviguer entre plusieurs instances, comprendre des procédures différentes selon le type de plainte, respecter des délais précis, fournir des documents multiples et maintenir une persévérance à toute épreuve. Le régime d'examen des plaintes, bien qu'instauré pour protéger les usagers, demeure complexe à comprendre et à utiliser. Entre le commissaire local aux plaintes, le Protecteur du citoyen, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Tribunal administratif du Québec, le Curateur public et les différents ordres professionnels, l'utilisateur se perd rapidement et ne sait plus à qui s'adresser ni dans quel ordre. Cette complexité décourage même les personnes les mieux outillées et encore davantage celles qui vivent avec un trouble de santé mentale.

Le quatrième obstacle est la peur des représailles. De nombreux usagers hésitent à dénoncer une atteinte à leurs droits par crainte des conséquences sur les services qu'ils reçoivent ou qu'ils recevront. Cette peur est particulièrement présente chez les personnes dépendantes d'un suivi continu, comme c'est souvent le cas en santé mentale. Porter plainte contre un psychiatre alors qu'on sait devoir le revoir dans quelques mois, dénoncer un comportement inapproprié de la part d'un intervenant alors qu'on dépend de son équipe pour ses soins, tout cela constitue un risque perçu comme trop grand. Même lorsque les mécanismes garantissent théoriquement la confidentialité et l'absence de représailles, la perception subjective du risque suffit à dissuader l'utilisateur d'agir.

Le cinquième obstacle est l'épuisement des personnes concernées. Faire valoir ses droits exige du temps, de l'énergie, de la clarté mentale, une capacité à écrire, à téléphoner, à se déplacer, à répéter son histoire à plusieurs interlocuteurs, à supporter des délais parfois longs. Or, les personnes vivant avec un trouble de santé mentale sont justement celles dont ces ressources sont les plus limitées. Demander à une personne en épisode dépressif majeur de remplir un formulaire de plainte, de rédiger une lettre détaillée ou de se présenter à une audience relève parfois de l'impossible. L'épuisement devient ainsi un filtre implicite qui exclut du processus de défense des droits celles et ceux qui en auraient le plus besoin.

Le sixième obstacle est la fracture numérique. De plus en plus, l'accès aux services, aux informations

et aux recours passe par des plateformes numériques. Or, une part significative des usagers n'a ni les compétences, ni les équipements, ni la connectivité nécessaires pour naviguer efficacement dans cet univers. Les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, certaines personnes vivant avec un trouble de santé mentale sévère se retrouvent exclues d'un nombre croissant de démarches. Cette exclusion numérique devient une exclusion des droits eux-mêmes.

Le septième obstacle est le manque de ressources d'accompagnement indépendantes. Les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes existent, mais leur capacité demeure limitée au regard des besoins. Les organismes communautaires de défense de droits sont sous-financés et débordés. Les délais pour obtenir un accompagnement peuvent être longs, alors même que les délais pour déposer une plainte sont courts. Plusieurs usagers renoncent à leurs démarches non par manque de volonté, mais faute d'avoir pu être accompagnés au bon moment.

Le huitième obstacle est la méconnaissance des droits par les intervenants eux-mêmes. Nous rencontrons régulièrement des professionnels de la santé, des employés de commerces, des propriétaires ou des gestionnaires qui ignorent tout simplement le cadre juridique applicable à leur situation. Ignorance de la Charte des droits et libertés, ignorance des règles sur les chiens d'assistance, ignorance des obligations d'accommodement raisonnable, ignorance du droit à l'information, du droit au consentement, du droit à la confidentialité. Cette ignorance crée des situations où le droit est bafoué sans malice, simplement par absence de connaissance, ce qui rend les démarches de correction plus laborieuses puisqu'il faut d'abord éduquer avant de revendiquer.

Le neuvième obstacle est le déséquilibre de pouvoir entre l'utilisateur et les institutions. Devant un hôpital, une compagnie d'assurances, un propriétaire ou un employeur, l'utilisateur se retrouve en position de faiblesse structurelle. Les institutions disposent de services juridiques, de ressources financières, de temps, d'expertise. L'individu, lui, doit puiser dans ses propres ressources, souvent limitées. Ce déséquilibre conduit à des règlements inéquitables où l'utilisateur accepte moins que ce à quoi il aurait droit, simplement parce qu'il n'a pas les moyens de poursuivre la lutte.

Le dixième obstacle concerne les lacunes du cadre réglementaire lui-même. Certains droits sont insuffisamment protégés par la loi, ou protégés de manière ambiguë. La reconnaissance des chiens d'assistance en santé mentale, par exemple, demeure imparfaite au Québec, ce qui laisse place à des interprétations variables selon les lieux, les personnes et les circonstances. De même, le droit à l'accommodement raisonnable, bien qu'établi par la jurisprudence, demeure flou dans son application concrète, laissant aux employeurs et aux institutions une marge d'appréciation considérable. Ces zones grises réglementaires favorisent les atteintes aux droits et compliquent leur défense.

Le onzième obstacle est la lenteur des recours. Obtenir une décision de la Commission des droits de la personne peut prendre plusieurs années. Un recours devant le Tribunal administratif du logement, devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou devant un tribunal civil s'étire souvent sur des mois, voire des années. Cette lenteur décourage les plaignants, dont la situation a parfois évolué avant même qu'une décision ne soit rendue. Pour une personne vivant avec un trouble anxieux, l'attente prolongée d'une décision constitue en elle-même une source de détresse qui peut aggraver sa condition.

Le douzième obstacle, particulièrement pernicieux, est l'autodéfense des institutions. Lorsqu'un usager dénonce une situation, les institutions ont tendance à se protéger, à minimiser les faits, à opposer leur version des événements, à invoquer des procédures internes pour justifier leurs actions. Cette posture défensive, parfois compréhensible, transforme la défense des droits en un affrontement inégal où l'utilisateur doit non seulement prouver l'atteinte à son droit, mais aussi surmonter la résistance organisée d'une institution. Les règlements à l'amiable, souvent privilégiés, se font fréquemment aux conditions des institutions plutôt qu'à celles des usagers.

Le treizième obstacle est le manque de transparence et de reddition de comptes. Les informations sur les plaintes traitées, sur les suites données, sur les correctifs apportés demeurent souvent peu accessibles au public. Les rapports annuels des commissaires aux plaintes, bien que publiés, sont

rarement lus et rarement intégrés à une réflexion collective. L'absence de visibilité sur le traitement des plaintes crée un sentiment d'inutilité chez les usagers : pourquoi dénoncer si personne ne voit le résultat de la dénonciation, si aucun changement tangible n'en découle ?

Enfin, le quatorzième obstacle est la fragmentation des services. Un usager qui vit une atteinte à ses droits doit souvent s'adresser à plusieurs instances différentes selon la nature du problème. Un même incident peut relever à la fois du commissaire aux plaintes pour l'aspect clinique, de la Commission des droits de la personne pour l'aspect discriminatoire, de l'ordre professionnel concerné pour l'aspect déontologique, et d'un recours civil pour l'aspect indemnitaire. Cette fragmentation multiplie les démarches, les délais, les efforts, et décourage la grande majorité des plaignants.

Tous ces obstacles se conjuguent pour créer une réalité où l'exercice réel des droits des usagers demeure fortement inégalitaire. Les personnes les mieux informées, les mieux soutenues, les plus persévérantes et les plus aptes à naviguer dans les systèmes complexes parviennent à faire valoir leurs droits. Les autres, qui constituent la majorité, particulièrement parmi les personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale, renoncent, s'épuisent ou se résignent. Cette inégalité dans l'accès à la justice et à la défense des droits constitue, à notre avis, l'un des enjeux les plus criants du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Elle appelle une réflexion profonde sur la simplification des recours, le renforcement des mécanismes d'accompagnement indépendants, la formation continue des intervenants, la lutte contre la stigmatisation et une reconnaissance pleine et entière du savoir expérientiel des usagers comme fondement de toute amélioration du système.

#31 • internet

l'accès à l'information

#35 • internet

A 21 ans on doit tout recommencer, les contacts sont perdus.

Peu d'information et de pivot central. Manque de transparence car pas de budget pour donner les services.

#39 • internet

l'accessibilité, la connaissance, l'accompagnement, l'ignorance, le manque d'information, analphabétisme

#40 • internet

La méconnaissance de ses droits

#58 • internet

l'ignorance des droits, les personnes qui tombe dans les craques du système

#63 • internet

Manque de connaissances à cet égard

Crainte de l'autorité

La bureaucratie

#65 • internet

Selon nous, les principaux obstacles à l'exercice des droits des usagers sont les difficultés de communication, le manque de sensibilisation dans certains milieux professionnels ainsi que la non-reconnaissance de leurs droits. Ces obstacles peuvent limiter l'accès à l'information, aux services et à une participation équitable dans la société.

#72 • internet

Un manque de connaissance.

#77 • internet

Ils ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte, ou porter plainte et comment documenter une plainte

#81 • internet

Méconnaissance de ces droits...

#83 • internet

Leurs manques de connaissance ou d'informations sur leurs droits.

#87 • internet

Mauvaise connaissance des droits.

#88 • internet

La communication, l'information et la prévention ciblée.

#90 • internet

La méconnaissance de leurs conditions.

#92 • internet

Manque de connaissance sur les droits, difficulté d'affirmer ses droits dans un contexte de rapports d'autorité, difficulté d'accès aux services, équipes traitantes qui sont inconfortables de partager certaines informations dans le peur de ne pas respecter la confidentialité (manque de clarté sur ce qui peut et ne peut pas être partagé).

#93 • internet

Leur connaissance de ceux-ci.

#95 • internet

La connaissance de leurs droits

#98 • internet

Méconnaissance de leur droit/ incompréhension des étapes/ des démarches

#100 • internet

Être pris au sérieux

Faire des plaintes facilement

Connaître ses droits! Très rarement les gens connaissent leurs droits et où aller pour les faire appliquer ou porter plainte. Ce n'est pas clair d'emblé.

#107 • téléphone

Le manque d'information

#111 • téléphone

Manque d'accès à la connaissance

#113 • téléphone

Le manque d'information et la difficulté d'intégrer les cas problématiques dans les structures existante.

#117 • téléphone

L'absence d'information

#121 • téléphone

Le manque de connaissance des institutions et la complexité. Le manque de temps et d'énergie, ils sont en mode survie

#122 • téléphone

La méconnaissance du système, les hommes ne savent pas à quelle porte frapper

#126 • téléphone

Le manque de connaissance

#129 • téléphone

Le manque d'information et manque d'accès au réseau

Accès limité / manque de ressources (n=26)

#1 • internet

Précarité socio économique et financement insuffisant des organismes

#14 • internet

Le faible investissement des gouvernements à offrir des services de soutien pour améliorer les conditions de vie des personnes ayant un trouble de santé mentale

#26 • internet

La demande dépasse l'offre, services non adaptés, des enjeux d'immigration,

#29 • internet

le manque de disponibilité et d'offre de soins, le manque d'accès direct et rapide

#48 • internet

l'accessibilité au service et une ressources fiable et compétente référé a la clientèle pour assurer la prestation par une infirmière et non une podologue

#49 • internet

Manque de ressources et manque d'investissement dans le RSSS

#50 • internet

Coût de la santé au privé.

#53 • internet

L'accès directement

#62 • internet

Les longs délais d'attente ;

Le manque de ressources disponibles ;

Les difficultés de communication entre les différents services ;

La fatigue et l'épuisement des familles et proches aidants ;

Le manque d'information accessible et simplifiée ;

La complexité du réseau de la santé et des services sociaux.

#68 • internet

Difficulté d'accès au réseau en général et délais interminables de prise en charge.

Équipes surchargées qui veulent prendre des décisions rapidement et négligent donc le droit des usagers à participer aux prises de décision.

Racisme et barrières culturelles des équipes.

Système qui vise le curatif plutôt que le préventif et qui travaille en silo.

#70 • internet

Le manque de connaissance sur les ressources d'aide et la capacité de se mobiliser lorsqu'on vit une trop grande détresse et que c'est au dessus de nos forces.

#84 • internet

Le manque de soin. C-A-D de travaillé sur le pourquoi le patient ne vas pas bien.

#85 • internet

Méconnaissance des droits ; pauvreté et peu de ressources

#91 • internet

Manque de connaissance du réseau, difficulté à avoir le soutien nécessaire.

#94 • internet

-Les listes d'attentes

-L'accès à l'accompagnement et/ou aux interprètes

-La méconnaissance des services existants

-Le manque d'information par rapport aux transformations du système de santé et de services sociaux.

-La difficultés que trouvent certains usagers à compléter des demandes diverses à travers les plateformes numériques.

#104 • internet

Très peu d'écoute de leurs besoins et réalité notamment dans les hôpitaux.

Dans les CLSC, très souvent, il y a beaucoup de roulement du personnel qui engendra des soins qui ne sont pas efficaces ou qui sont mal faits et cela engendre souvent des problème de santé, apparition plaie de pression, infections.

#105 • téléphone

L'accès aux services et à l'aide rapide et efficace. Présentement c'est long et difficile car les portes d'entrées sont complexes pour une personne seule et sans soutien

#106 • téléphone

Très difficile pour faire des demandes, soit pas d'ordinateur ou trop complexe de s'y retrouver. Les âgés ne sont pas à l'aise avec ce système et c'est long d'avoir des services. Les personnes très âgés ont parfois de la difficulté à s'exprimer et à demander le bon service

#108 • téléphone

L'accessibilité à la bonne personne pour les aider et le manque de connaissance

#112 • téléphone

La facilité d'accès, le manque de transparence et de facilité, le manque de moyens, les programmes internet complexes et décourageant pour nous et pour les usagers

#115 • téléphone

L'accès aux services, la méconnaissance de leurs droit, la complexité du système

#118 • téléphone

l'accès aux services, le manque de personnel, l'analphébitasation des usagers

#120 • téléphone

L'accessibilité et l'attente

#124 • téléphone

accès aux services, je ne sais pas où va l'argent de nos taxes !

#127 • téléphone

Manque d'accessibilité aux informations et suivi trop lent et les moyens de communication qui ne sont pas accessibles pour eux (internet, web...)

#128 • téléphone

Les déplacements et les difficultés pour l'accès internet pour les personnes très âgées et immigrants

Complexité bureaucratique et procédurale (n=16)

#13 • internet

Le cadre imposé à certains services tel que le service offert aux personnes sans domicile fixe qui ne considère pas une femme victime de violence conjugale hébergée en hébergement d'urgence comme sans domicile fixe

#15 • internet

Réseau de la santé centralisé et rigide, incapable d'action parce qu'allourdi par une structure dictée par des gens déconnectés du terrain et incapables de comprendre qu'un système de santé doit soigner une personne et pas un numéro.

#16 • internet

Les chemins pour faire valoir leurs droits est tortueux : un peu la maison des fous d'Astérix !

#19 • internet

la rigidité du système

#20 • internet

Les gens ne sont pas formés et ou ne prennent pas le temps adéquats afin d'expliquer clairement les options et ou entendre les réels besoins d'une personne. Si le besoin ne concorde pas avec les services ils sont souvent directement redirigés et doivent se débrouiller seuls.

#21 • internet

trop de protocoles administratifs et pas de solutions à offrir même si des plaintes officielles sont entamées.

Le commissaire/mécanisme de plaintes n'est plus indépendant d'un CIUSSS. Il est difficile pour les établissements d'admettre/de reconnaître quand ils ont tort.

#27 • internet

La complexité bureaucratique.

#28 • internet

- le non respect des lois, règlements, politiques et plans d'action adoptés et pourtant clairs mais souvent ignorés par les autorités des établissements

#36 • internet

Le poids que représente les procédures, le fait de devoir remplir des formulaires

#38 • internet

les institutions

#54 • internet

La complexité systémique : La lourdeur de la bureaucratie et le jargon du réseau qui rendent les recours intimidants.

La vulnérabilité des usagers : L'isolement social, l'épuisement des proches aidants et les pertes cognitives qui privent les individus des ressources nécessaires pour entreprendre des démarches.

La crainte de répercussions : La peur infondée mais réelle de voir ses services actuels réduits ou altérés si l'on formule une insatisfaction.

#78 • internet

La rigidité de la structure du CIUSSS.

#89 • internet

Le manque d'informations et de connaissances ;

Le manque de soutien et d'accompagnement lors de plaintes ;

L'immense bureaucratie du système de santé et services sociaux ;

#101 • internet

complexité recours juridiques, langue, ressources, temps, argent

#114 • téléphone

Méconnaissance de leurs droits, la complexité du système rend difficile de trouver l'information et la bonne personne

#119 • téléphone

Les milliers de différents programmes, le manque d'approche holistique globale de chaque cas

Manque d'accompagnement / peur et épuisement (n=13)

#0 • internet

Manque d'information, manque de défense respectueuse (avocat qui défend la volonté de la personne et non son intérêt), manque d'accompagnement, etc.

#4 • internet

La connaissance des recours, l'accompagnement pour les exercer

#9 • internet

Lorsqu'elles sentent qu'elle n'ont pas eu le service adéquat, elle n'ont souvent pas l'énergie nécessaire de porter plaintes.

#33 • internet

Stigmatisation, manque de temps, peur,

#34 • internet

Les dédales administratifs et la peur des représailles, mais aussi l'épuisement parental.

#42 • internet

Ils ont peur qu'on leur retire le peu qu'on leur offre s'ils font une plainte. Le processus de plainte est également complexe et SOUVENT peu concluant, alors décourageant pour les familles. Il en ressort quelques recommandations, qu'on se justifie de ne pas respecter par manque de personnel ou de budget.

#44 • internet

Les personnes âgées ont peu tendance à être en mode défense de droit et accepte tout comme une fatalité.

#64 • internet

La difficulté de compréhension de la procédure pour porter plainte. Le fait que cette clientèle a déjà beaucoup à gérer au quotidien et les usagers n'ont pas toujours l'énergie et la capacité de porter plainte.

#76 • internet

Je crois qu'à force de vouloir traiter humainement et de façon égalitaire, on oublie qu'une personne vivant avec des symptômes sévères de psychose peut avoir droit aux soins et pour cela, la confidentialité devrait pouvoir être rompue pour mieux aider la personne. L'idée n'est pas de retirer à l'utilisateur ses droits humains fondamentaux, mais de lui offrir l'encadrement nécessaire à son rétablissement.

#97 • internet

La méconnaissance de leurs droits. Où et comment puis-je me renseigner pour faire valoir mes droits? La peur d'être jugé, comment va t'on me répondre? Serais-je respecté?

#110 • téléphone

La deshumanisation, l'utilisateur a l'impression de s'adresser à une machine lors de problème, c'est trop complexe et pas assez proche de l'humain

#123 • téléphone

Ne connaissent pas les droits, ont peur des représailles, n'ont pas l'éducation ou les moyens techniques

#125 • téléphone

L'infantilisation de la clientèle, de stigmatisation

Barrière linguistique et communication (n=11)

#2 • internet

leur connaissance de leurs droits

leur aisance à communiquer, à les verbaliser, à les faire comprendre, à être écouté

#7 • internet

Les principaux obstacles sont la barrière de la langue, la complexité du système de santé , ainsi que la difficulté pour certains usagers de comprendre leurs droits.

#17 • internet

La peur des préjugés qui deviennent des micro-agressions

#23 • internet

La langue

#60 • internet

La méconnaissance linguistique et celles des codes culturels

#61 • internet

les termes utilisés notamment et le manque de proximité avec les ressources.

#67 • internet

langue

#79 • internet

la barrière de la langue au niveau de la communication et de la revendications de leurs droits

Le manque de temps , car les démarches sont parfois longues, ce qui découragent les gens

le manque d'accompagnement et de soutien tout le long des démarches / certaines personnes de sont pas autonomes

la méconnaissance des droits et des services

La violence et le contrôle que certaines personnes de l'entourage peut avoir sur la personne dont les droits sont bafoués

#80 • internet

les usagers sont stigmatisés

#99 • internet

La stigmatisation et la perception qu'on les personnes des services de santé des personnes en situation d'itinérance et vivant avec des enjeux de dépendance et de santé mentale.

#116 • téléphone

Leurs difficultés, de ne pas être informés, en situation d'itinérance ou avec des difficultés mentales... difficultés de communication avec les personnes en difficulté

non classable (n=9)

#8 • internet

Déjà répondu plus haut.

#11 • internet

6tout d

#30 • internet

Voir les questions précédentes

#32 • internet

-

#37 • internet

avoir une renocntre

#55 • internet

N.A

#66 • internet

x

#69 • internet

Racisme systémique

#71 • internet

Ne sais pas

q9 — 9. Quels droits des usagers sont les plus souvent compromis selon vous? (ex. accès aux services, consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions, etc.)

Propriété annotée : *Quel droit les répondants identifient-ils comme le plus souvent compromis (type de droit ou problème principal) ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 112 réponses (88 internet, 24 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Accès aux services	60	53.6%	43	17
Consentement éclairé et participation	27	24.1%	22	5
Manque de ressources / délais / qualité des services	8	7.1%	8	0
Communication et langue adaptée	4	3.6%	3	1
Confidentialité	4	3.6%	3	1
non classable	9	8.0%	9	0
Total	112		88	24

Accès aux services (n=60)

#1 • internet

Accès aux services, dignité, inclusion

#5 • internet

L'accès aux services...

#6 • internet

accès aux services, surtout pour les 21 ans et plus (en déficience intellectuelle)

#9 • internet

accès aux services

#13 • internet

accès aux services

#14 • internet

Accès au service.

#16 • internet

Accès au services

#18 • internet

accès aux services

#19 • internet

accès aux services

#21 • internet

accès aux services et être bien informé de l'aide qui peut leur être offerte, et ce que si les services existent

#25 • internet

À partir de notre expérience quotidienne au sein de l'Académie Stella, nous constatons que plusieurs droits fondamentaux des usagers vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale sont régulièrement compromis, parfois de manière flagrante, parfois de manière plus insidieuse. Ces atteintes aux droits ne sont pas toujours le fruit d'une intention malveillante, mais elles résultent souvent d'un ensemble de facteurs structurels, culturels et organisationnels qui, combinés, aboutissent à une réalité où les droits inscrits dans les lois québécoises demeurent partiellement lettre morte pour une partie importante de la population que nous desservons.

Le premier droit régulièrement compromis est le droit d'accès aux services. Malgré les engagements répétés du gouvernement à améliorer l'accès aux soins en santé mentale, les listes d'attente demeurent considérables. Obtenir un rendez-vous avec un psychiatre peut prendre plusieurs mois, voire plus d'un an dans certaines régions. L'accès à un psychologue dans le réseau public demeure un parcours du combattant, ce qui force les personnes qui en ont les moyens à se tourner vers le privé, et laisse celles qui n'ont pas ces moyens dans une situation de privation de soins. Pour nos bénéficiaires, l'accès à des services spécialisés adaptés à leur condition, comme la thérapie cognitivo-comportementale pour le trouble de stress post-traumatique ou la thérapie comportementale dialectique pour le trouble de la personnalité limite, relève trop souvent du privilège plutôt que du droit. Cette inégalité d'accès constitue une première atteinte fondamentale qui conditionne toutes les autres.

Le deuxième droit fréquemment compromis est le droit au consentement libre et éclairé. Ce droit, pourtant consacré par le Code civil du Québec et par la jurisprudence, est régulièrement bafoué dans le contexte des soins en santé mentale. Les médications psychiatriques sont souvent prescrites sans que l'utilisateur reçoive une information complète sur les effets secondaires potentiels, les alternatives thérapeutiques disponibles, les risques à long terme ou la durée prévisible du traitement. Certains usagers nous rapportent avoir reçu des prescriptions sans qu'on leur explique même le nom exact du médicament ou la raison précise de sa prescription. Dans les contextes de garde en établissement, de garde préventive ou d'autorisation judiciaire de soins, la notion de consentement devient encore plus problématique, et les mécanismes censés protéger l'utilisateur fonctionnent de manière inégale selon les établissements, les médecins et les régions. Le consentement, lorsqu'il existe, est parfois obtenu dans des contextes de vulnérabilité extrême où la personne n'a ni la capacité ni le temps de réfléchir véritablement à ce qu'on lui propose.

Le troisième droit régulièrement compromis est le droit à la confidentialité et à la protection des renseignements personnels. Les dossiers médicaux en santé mentale contiennent des informations extraordinairement sensibles, et pourtant les fuites, les partages inappropriés entre professionnels et les divulgations non autorisées demeurent fréquents. Nous rencontrons régulièrement des bénéficiaires dont le diagnostic a été communiqué à leur employeur, à leur propriétaire, à des membres de leur famille ou à des tiers sans leur consentement explicite. Dans certains cas, des informations sensibles apparaissent dans des dossiers accessibles à un nombre étonnamment large de personnes au sein du réseau. L'informatisation des dossiers, bien qu'elle présente des avantages indéniables, a également multiplié les risques d'atteintes à la confidentialité. Pour les personnes vivant avec un trouble de santé mentale, une telle atteinte peut avoir des conséquences dévastatrices, tant sur le plan personnel que professionnel.

Le quatrième droit fréquemment compromis est le droit à la participation aux décisions qui les concernent. Trop souvent, les plans de traitement, les plans d'intervention et les orientations cliniques sont élaborés sans la participation réelle de l'utilisateur. On lui présente des décisions déjà prises, on lui demande de signer des documents qu'il n'a pas eu le temps de comprendre, on décide pour lui plutôt qu'avec lui. Cette approche paternaliste, encore très présente dans le réseau, contrevient directement aux principes de l'approche centrée sur la personne et du rétablissement, pourtant officiellement adoptés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La participation de l'utilisateur, lorsqu'elle

existe, se limite souvent à une consultation de façade plutôt qu'à une véritable codécision. Nos bénéficiaires nous rapportent fréquemment se sentir comme des objets de soins plutôt que comme des sujets actifs de leur propre démarche de santé.

Le cinquième droit régulièrement compromis est le droit à l'accompagnement par la personne de son choix. Ce droit, pourtant clairement inscrit dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, est régulièrement contesté par les établissements. Nous avons rencontré des situations où l'accompagnement par un intervenant de l'Académie Stella, par un proche ou par un représentant communautaire a été refusé ou découragé. Dans certains cas, les professionnels préfèrent s'entretenir seuls avec l'utilisateur, invoquant des motifs de confidentialité ou d'efficacité clinique, alors même que l'utilisateur souhaite explicitement être accompagné. Ce refus d'accompagnement place l'utilisateur dans une position d'isolement face à l'institution, ce qui compromet directement sa capacité à faire valoir ses préférences et à comprendre les décisions le concernant. Le droit d'être accompagné, avec présence d'un chien d'assistance, est également régulièrement bafoué dans certains environnements de soins, malgré les dispositions légales qui le protègent.

Le sixième droit fréquemment compromis est le droit à l'information. Les utilisateurs ont pourtant le droit d'être informés sur leur état de santé, sur les services disponibles, sur les procédures applicables, sur les recours possibles. Or, l'information transmise est souvent incomplète, partielle, orientée ou carrément omise. Les utilisateurs découvrent tardivement, parfois par nous, qu'ils avaient droit à certains services, à certaines procédures de plainte, à certaines formes d'accommodement. Ce déficit informationnel résulte tantôt d'un manque de temps des professionnels, tantôt d'une culture institutionnelle qui ne valorise pas suffisamment la transmission d'information, tantôt d'un choix délibéré de ne pas informer pour éviter des demandes supplémentaires. Peu importe sa cause, il prive les utilisateurs de la capacité d'exercer pleinement leurs autres droits, puisque l'exercice d'un droit suppose sa connaissance.

Le septième droit régulièrement compromis est le droit au respect et à la dignité. Ce droit fondamental, consacré par la Charte des droits et libertés de la personne, est bafoué de multiples façons dans le réseau de la santé mentale. Les utilisateurs nous rapportent des paroles humiliantes, des attitudes condescendantes, des comportements infantilisans, des blagues déplacées sur leur condition. Dans les salles d'urgence, les personnes en crise psychiatrique sont parfois laissées sur des civières pendant de nombreuses heures sans information, sans intimité, sans soutien émotionnel. Dans certaines unités psychiatriques, les règles de vie imposées, bien que parfois justifiées par des motifs de sécurité, franchissent la ligne vers la déshumanisation. Le port de vêtements d'hôpital imposé, la fouille systématique des effets personnels, l'interdiction de certains objets personnels sans explication adéquate, toutes ces pratiques portent atteinte à la dignité des personnes.

Le huitième droit fréquemment compromis est le droit à des services adaptés et de qualité. Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale ont droit à des services qui tiennent compte de leur condition spécifique, de leurs besoins particuliers, de leurs préférences culturelles et linguistiques. Or, l'adaptation des services demeure souvent théorique. Les accommodements nécessaires, comme la présence d'un chien d'assistance, l'accès à un environnement moins stimulant pour les personnes autistes, la présence d'une personne de confiance pour les personnes en état dissociatif ou la traduction pour les personnes allophones, sont régulièrement refusés ou octroyés avec difficulté. La qualité des services varie également considérablement d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre, d'un professionnel à l'autre, créant une loterie géographique qui n'a rien à voir avec le principe d'égalité d'accès à des soins de qualité.

Le neuvième droit régulièrement compromis est le droit à la continuité des services. Les ruptures de services, les changements répétés d'intervenants, les transferts non préparés, les fins de suivi sans orientation vers d'autres ressources constituent une réalité quotidienne pour nos bénéficiaires. Cette discontinuité est particulièrement dommageable en santé mentale, où la relation thérapeutique constitue elle-même un élément central du traitement. Chaque changement d'intervenant oblige la personne à recommencer son récit, à rebâtir un lien de confiance, à expliquer à nouveau sa condition.

Cette répétition constitue une forme de violence invisible qui épuise les usagers et compromet l'efficacité même des services qui leur sont offerts.

Le dixième droit fréquemment compromis est le droit de porter plainte sans crainte de représailles. Bien que ce droit soit formellement garanti, la crainte des représailles demeure très présente chez les usagers. Nous avons rencontré des situations où des bénéficiaires ayant porté plainte ont constaté un changement dans l'attitude du personnel à leur égard, une diminution de l'accessibilité de certains services, voire des représailles directes sur le plan clinique. Même lorsque ces représailles ne sont pas prouvées, la perception de leur possibilité suffit à décourager la majorité des personnes concernées. Le mécanisme de protection théorique ne compense pas la vulnérabilité réelle dans laquelle se trouve l'utilisateur face à une institution dont il dépend.

Le onzième droit régulièrement compromis est le droit à la vie privée, notamment dans les milieux d'hébergement et les unités psychiatriques. Le partage de chambres, le manque d'intimité lors des examens, l'absence de lieux pour discuter confidentiellement avec un proche ou un intervenant extérieur, la présence de caméras de surveillance dans certains espaces communs, constituent autant d'atteintes à la vie privée des personnes hébergées. Pour les usagers vivant avec un trouble de stress post-traumatique, ces conditions peuvent réactiver des symptômes et aggraver leur condition plutôt que de la soulager.

Le douzième droit fréquemment compromis est le droit à la non-discrimination. Les personnes vivant avec un trouble de santé mentale font face à une discrimination structurelle qui se manifeste dans de multiples sphères. Discrimination à l'emploi, lorsque leur condition est découverte ou soupçonnée. Discrimination au logement, lorsqu'elles déclarent leur besoin d'un chien d'assistance. Discrimination dans l'accès à certains commerces ou services, lorsqu'elles sont accompagnées de leur chien ou lorsqu'elles présentent des symptômes visibles. Discrimination médicale également, lorsque leurs plaintes physiques sont attribuées à leur condition psychologique plutôt qu'examinées sérieusement, phénomène parfois appelé « contamination diagnostique » ou « overshadowing diagnostique », et qui conduit régulièrement à des erreurs de diagnostic graves et à des souffrances évitables.

Le treizième droit régulièrement compromis est le droit au libre choix du professionnel ou de l'établissement. Dans les faits, ce droit est fortement limité par la pénurie de ressources, par les territoires de desserte, par les listes d'attente et par la rareté de certaines spécialités. Un usager insatisfait de son psychiatre, par exemple, n'a souvent pas d'autre option réaliste que de poursuivre avec lui, puisque changer signifierait attendre de nombreux mois avant d'en rencontrer un autre. Ce faux choix constitue une atteinte subtile mais réelle à l'autonomie de l'utilisateur.

Le quatorzième droit fréquemment compromis est le droit à la représentation et à la défense par un tiers. Bien que les usagers aient le droit d'être représentés dans leurs démarches, notamment par un organisme comme le nôtre, cette représentation est régulièrement contestée ou minimisée par les institutions. Les interlocuteurs préfèrent souvent traiter directement avec l'utilisateur, écartant délibérément les représentants au motif que « la personne peut parler pour elle-même », même lorsque cette personne a explicitement choisi d'être représentée. Cette pratique, contraire à l'esprit des lois sur la défense des droits, place l'utilisateur dans une position affaiblie face à l'institution.

Enfin, le quinzième droit régulièrement compromis est le droit à une indemnisation juste en cas d'atteinte aux droits. Même lorsqu'une violation est reconnue, les indemnisations sont généralement symboliques, les excuses formelles sont rarement présentées, et les correctifs systémiques sont presque inexistantes. L'utilisateur obtient, au mieux, une reconnaissance de la faute commise, sans que cela n'entraîne de changements tangibles dans les pratiques ni de réparation significative du tort subi.

Tous ces droits compromis ne sont pas des violations théoriques ou occasionnelles. Ils constituent le pain quotidien des personnes que nous accompagnons à l'Académie Stella. Chaque journée dans notre organisme nous met en présence de situations où l'un ou plusieurs de ces droits sont bafoués, souvent simultanément. Cette réalité appelle à notre avis une mobilisation collective pour que l'écart entre les droits formellement reconnus et les droits effectivement exercés soit progressivement comblé.

Sans cette mobilisation, les lois les mieux intentionnées demeureront partiellement sans effet pour les personnes qui en dépendent le plus, et la promesse d'égalité portée par notre système de santé et de services sociaux restera partiellement non tenue à l'égard des personnes vivant avec un handicap psychologique ou un trouble de santé mentale.

#26 • internet

Accès aux services

services adaptés

#27 • internet

Accès aux services et ce dans un délai raisonnable.

#29 • internet

accès aux services

#32 • internet

Accès aux services, confidentialité, participation aux décisions.

#35 • internet

accès aux services

#38 • internet

accès aux services et participation aux décisions

#39 • internet

accès aux services, à l'accompagnement, à l'hébergement adéquat, à l'information

#42 • internet

accès aux services

#43 • internet

Accès aux services

#44 • internet

accès aux services

#48 • internet

accés au service

#49 • internet

Acced

#52 • internet

Accès aux services.

#54 • internet

L'accès aux services : Les délais d'attente importants et le rationnement de certains services (comme le soutien à domicile ou le transport adapté) limitent l'accès réel aux soins requis.

La participation aux décisions : En raison de la lourdeur du système ou de la vulnérabilité cognitive de certains usagers, les décisions de trajectoire de soins ou de vie sont trop souvent prises pour eux, plutôt qu'avec eux, ce qui compromet leur droit à l'autodétermination.

#59 • internet

accès aux services

#61 • internet

Accès aux services.

#62 • internet

L'accès aux services dans des délais raisonnables ;

La participation réelle aux décisions concernant les services ;

L'accès à une information claire et adaptée ;

La continuité des services et des suivis ;

Dans certains cas, l'adaptation des services aux besoins particuliers de la personne.

#63 • internet

Accès aux services

Participation aux décisions

#64 • internet

Du côté de notre organisme, c'est l'accès physiques au lieu de service avec leur chien-guide ou d'assistance.

#71 • internet

Accès aux services

#76 • internet

L'accès aux services. Une personne incapable de reconnaître son besoin de soins mérite de les recevoir.

#77 • internet

accès aux services. On respecte le droit de refuser des services aux aînées qui ont des troubles cognitifs alors qu'ils oublient de manger , se laver etc..aucun filet de protection de type curatelle ou placement est mis en place alors que c'est un manque total de respect de la dignité humaine. ET ca on le voit souvent.

#78 • internet

Accès aux services

#79 • internet

l'accès au services et le consentement éclairé

#87 • internet

Droits aux services. Droits à la langue.

#89 • internet

Droit à l'information, l'accès au dossier ;

Droit d'accès aux services, à l'évaluation des besoins, à la prise en charge biopsychosociale ; droit de recevoir des soins et des services de qualité

Droit de porter plainte ;

Droit de participer aux décisions, droit d'être accompagné et soutenu par une personne proche aidante ;

#91 • internet

Accès aux services

#92 • internet

Accès aux services : lorsqu'il y a des troubles de santé mentale et des enjeux de santé physique, les équipes traitantes se limitent à traiter un seul problème plutôt que les adresser dans une perspective holistique et pluridisciplinaire. Les listes d'attente compromettent les droits d'avoir accès à des services dans des délais raisonnables.

Consentement éclairé et participation aux décisions : Les usagers ont une compréhension limitée de leur plans de traitements et ont peu de connaissances de leurs droits et des offres de services.

#95 • internet

Dans le cas des familles d'enfants handicapés, les intervenants ne leur nomme pas l'éventails des services possibles. Les familles doivent nommer leurs besoins. Je ne peux pas nommer mon besoin de place protocole si je ne sais pas que ça existe

#97 • internet

accès à un médecin de famille, difficulté à obtenir un rendez-vous avec un médecin en cas d'urgence. J'entends souvent des aînés dire que "mon médecin de famille ne répond qu'à une question lorsque je vais le voir pour une consultation." L'utilisateur doit reprendre un rendez-vous pour poser une autre question. Souvent ce même médecin pratique à l'autre bout de la ville. C'est un comportement abusif et la carte d'assurance maladie se fait aller pour des consultations. Pourquoi les CLSC n'offrent-ils pas plus de services ? et l'urgence des CLSC accueillent moins de 20 personnes par jours.

#102 • internet

Accès aux services, car très peu de spécialistes formés en réadaptation oncologique dans le réseau publique

#104 • internet

L'accès aux services est brimé dans le sens les intervenants pivots n'expliquent pas ou ne présentent pas toutes les options possibles auxquelles les usagers auraient droit. La participations aux décisions ne se fait pas toujours en collaboration avec l'utilisateur.

#105 • téléphone

L'accès aux services

#106 • téléphone

accès aux services et l'aide pour cet accès

#107 • téléphone

accès aux services qui est trop compliqué et le consentement éclairé. On devrait pouvoir avoir accès à des services facilement, cela ne devrait pas être une épreuve

#109 • téléphone

accès aux services

#111 • téléphone

Tout ça ! accès aux services, consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions,

#112 • téléphone

accès aux services, la prise en charge par les professionnels, information sur les droits en santé mentale

#115 • téléphone

tout ça ! accès aux services, consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions

#116 • téléphone

Accès aux services

#117 • téléphone

accès aux services

#118 • téléphone

accès aux services

#119 • téléphone

accès aux services, consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions, le droit d'être soigné

#120 • téléphone

accès aux services

#122 • téléphone

accès aux services

#124 • téléphone

accès aux services

#125 • téléphone

accès aux services, consentement éclairé, confidentialité (souvent le CIUSSS outrepassé ce droit)

#127 • téléphone

accès aux services

#129 • téléphone

Le manque d'accès aux services

Consentement éclairé et participation (n=27)

#4 • internet

consentement éclairé, accès aux services

#8 • internet

- Droit à l'information : Être informé sur son état de santé, les traitements possibles, leurs risques et les services disponibles dans son milieu.

- Droit aux services : Recevoir des services adéquats sur les plans scientifique, humain et social, avec continuité.

- Droit de choisir son professionnel ou l'établissement : Choisir, dans la mesure du possible, qui prodiguera les soins et où ils seront reçus.

- Droit de consentir à des soins ou de les refuser : Accepter ou refuser un traitement de façon libre

et éclairée. C'est surtout le libre et éclairé qui est peu respecté.

- Droit de participer aux décisions : Participer activement à toute décision affectant sa santé ou son bien-être, notamment à l'élaboration de son plan d'intervention.

-Droit d'être accompagné, assisté et représenté : Être aidé par une personne de son choix lors de démarches ou de rendez-vous.l

#23 • internet

Décision éclairée, n'ont pas accès à l'ensemble des informations et possibilités ou ne peuvent souvent pas intellectuellement y avoir accès

#31 • internet

participation aux décisions, respects de la vie privée

#33 • internet

Accès services, consentement éclairé face à la médication et participation aux soins

#34 • internet

L'accès aux services, le consentement éclairé, le patient et sa famille ne semblent pas de réels partenaires de soins.

Plus spécifiquement pour les pères, la participation aux échanges menant aux prises de décisions au sujet de leur enfant (consentement, demandé sans réelles consultations)

#36 • internet

Le droit à l'information

Le droit de choisir son professionnel et son établissement

Le droit de participer aux décisions

#40 • internet

consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions

#53 • internet

Compréhension des services, limite des services, consentement éclairé, accès à des services

#60 • internet

Je pense que c'est le consentement éclairé et la participation aux décisions dans le cas où il y a l'utilisation d'interprète, notamment

#65 • internet

Selon nous, les droits les plus souvent compromis concernent l'autonomie des usagers, leur possibilité de faire des choix libres et éclairés, ainsi que leur pleine inclusion dans les démarches les concernant. Plusieurs usagers rencontrent aussi des difficultés à obtenir un accompagnement adapté à leurs besoins.

#68 • internet

Le droit aux services

Le droit à la participation aux décisions

Le droit de choisir

Le droit de consentir ou de refuser

#69 • internet

Participation aux décisions

#70 • internet

Accès et participation aux décisions.

#84 • internet

^Participation aux décisions.

#85 • internet

Participation aux décisions ; accès aux services ; droit à la dignité (certains se font suggérer l'aide médicale à mourir dans le demander...)

#90 • internet

Consentement éclairé, confidentialité

#93 • internet

Possiblement le consentement éclairé et la participation aux décisions, considérant qu'on peut présumer qu'ils ne saisissent pas toujours qu'ils ont un choix et s'en remettent probablement à l'autorité compétente.

#96 • internet

Surtout consentement éclairé, confidentialité, participation aux décisions

#98 • internet

consentement éclairé/ participation au décision

#101 • internet

consentement éclairée, considération de leur douleur

#103 • internet

La privatisation détériore l'accès aux services dans une perspective d'Égalité. Le consentement éclairé est complètement bafoué dans de nombreuses situations où la P-38 est utilisée (parfois à L'excès) pour hospitaliser des personnes contre leur gré. La participation aux décisions en matière de santé est vraiment peu respectée par le gouvernement québécois, on n'a qu'à pensé au projet de loi 15 "pour un système de santé plus efficace" adopté malgré l'opposition de centaines d'organisations de la société civile comme les OCASSS (organisations communautaires autonomes en santé et services sociaux) ou encore les syndicats en SSS. Le PL15 a accéléré la privatisation et modifié à plusieurs niveaux la gouvernance du réseau : reculs pour les comités d'usagers qui permettaient une certaine participation de la population aux décisions.

#110 • téléphone

La participation aux décisions, la confidentialité (choses ensuite retenues contre la personne) le droit d'être accompagné (parfois ce n'est même pas accepté lors de problème), accès aux services (les rouages sont complexes, portes d'entrées...)

#113 • téléphone

participation aux décisions les concernant

#114 • téléphone

participation aux décisions : les familles ne se sentent pas maître de leur destin

#126 • téléphone

consentement éclairé : mal informé entre autres

#128 • téléphone

accès aux services, consentement éclairé (la langue, la culture des nouveaux arrivants leur nuit, le fait de ne pas comprendre le vocabulaire ou les formulaires

Manque de ressources / délais / qualité des services (n=8)

#0 • internet

L'ensemble de leurs droits - en santé mentale du moins.

#11 • internet

Tout cela ainsi que le manque de ressources plus numéro 6

#17 • internet

Accès aux services, services exempts de préjugé

#24 • internet

Selon notre expérience, plusieurs droits peuvent être compromis de façon simultanée selon la situation vécue par l'utilisateur. Le droit d'accès aux services est l'un des plus fréquemment affectés, notamment en raison des délais d'attente, du manque de ressources et de la complexité du réseau.

Le droit à la participation aux décisions et à être entendu peut également être compromis lorsque les usagers ont l'impression que leurs besoins ou leur réalité ne sont pas pleinement pris en compte.

Nous observons aussi des enjeux liés au consentement éclairé lorsque l'information n'est pas toujours transmise de façon claire ou adaptée aux capacités, à la langue ou au niveau de compréhension de l'utilisateur.

La confidentialité peut également représenter un enjeu pour certaines personnes, particulièrement dans de petites communautés ou lorsqu'il existe une crainte de jugement ou de répercussions.

De façon générale, lorsque plusieurs vulnérabilités se croisent, plusieurs droits peuvent être compromis en même temps plutôt qu'un seul droit isolé.

#28 • internet

- recevoir des soins et des services dignes et adéquats, prescrits par les lois, règlements, politiques et plan d'actions

#47 • internet

Tous

#50 • internet

Accès aux services... attentes interminables...

#100 • internet

Accès aux services

Consentement éclairé pour plusieurs traitements, mais ceux par rapport la transidentité c'est soudainement ultra important au point qu'il faut des lettres de psychothérapeutes lorsque le médecin peut le faire. Heureusement, plusieurs médecins dans certaines cliniques (non pas dans les CIUSSS) font le consentement éclairé de leur côté et ça se passe très bien.

Les services au niveau de la santé mentale sont très faible. Peu de services, peu d'aide, beaucoup

d'attente.

Participation aux décisions pour faire des changements à l'interne, c'est très rare que de l'aide de l'extérieur ou de patients est demandé.

Le processus de plainte qui donne rarement des résultats. Donc, peu de changement se produit lorsqu'un droit a été bafoué.

Souvent beaucoup de problème à l'administration. Les professionnels de la santé sont parfois bien formé, mais aucune la personne qui accueille les patients.

Communication et langue adaptée (n=4)

#2 • internet

accès

écoute, respect, compréhension de leur situation

#88 • internet

L'accessibilité pour les personnes sourdes.

#94 • internet

-L'accessibilité à une intervention sensible à la culture de l'utilisateur.

-S'assurer que l'utilisateur donne un consentement optimal au service qui lui est offert.

-L'accès au service au moment où il le nécessite le plus (priorisation des dossiers).

#123 • téléphone

accès aux services et le langage et la communication adaptée et cela va trop vite

Confidentialité (n=4)

#12 • internet

Accès aux services, confidentialité,

#15 • internet

accès aux services et confidentialité. Nos communautés se buttent souvent à des portes fermées dû à leurs conditions de vie ou leurs manques de documents, ou simplement parce que le réseau fonctionne sur un horaire de travail incompatible avec la vie. La confidentialité parce que nous avons souvent entendu des groupes communautaires que des partenaires du réseau révèlent des informations (statut VIH/migratoire/trans/etc.) d'une personne, alors que certaines de ces informations sont illégales à partager et que d'autres sont tout sauf nécessaires.

#58 • internet

la confidentialité

#108 • téléphone

confidentialité : on a souvent des informations confidentielles qui nous sont partagées sans autorisation de l'utilisateur et l'accès aux services

non classable (n=9)

#7 • internet

rien

#20 • internet

L'ensemble des éléments nommées.

#30 • internet

Voir les questions précédentes

#66 • internet

x

#72 • internet

Représentation en cour

#80 • internet

tous ceux nommés plus haut

#81 • internet

Un peu tout cela...

#83 • internet

Aucune idée, on ne fait pas bcp affaire avec le CIUSSS.

#99 • internet

Tous les exemples de la question sont applicable.

q10-Comment — 10. Comment votre organisme contribue-t-il actuellement à la défense des droits des usagers ?

Question mère (q10) : Comment l'organisme contribue à la défense des droits

Propriété annotée : *quelles types d'action sont mentionnées*

Résumé des catégories

6 catégories • 17 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Orienter / référer vers des services	5	29.4%	NA	NA
Collaborer avec des partenaires	4	23.5%	NA	NA
Offrir des services directs et un accompagnement	4	23.5%	NA	NA
Plaider et représenter les usagers	2	11.8%	NA	NA
Aider dans les démarches administratives	1	5.9%	NA	NA
Coordonner l'écosystème / mener de la recherche	1	5.9%	NA	NA
Total	17		NA	NA

Orienter / référer vers des services (n=5)

#58 •

référence vers d'autre organisme de défense des droits

#62 •

Dans le cadre de nos services, nous informons les familles des ressources et services pouvant être offerts par les CIUSSS et autres partenaires du réseau.

La mission de notre organisme vise principalement l'inclusion, le développement du plein potentiel, les activités adaptées, les services de répit, les loisirs et le plein air pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Nous ne sommes pas un organisme spécialisé en défense des droits ou en accompagnement juridique.

#111 •

référencement

#112 •

référencement (CAVAC, IVAC...)

#122 •

Références dans d'autres organismes

Collaborer avec des partenaires (n=4)

#6 •

participation à des tables de concertation

#106 •

Comités des aînés

#113 •

Partenariat avec d'autres organismes pour leurs droits et services en santé mentale et prévention

#115 •

Bons partenariats avec autres organismes grâce à la personne ressource

Offrir des services directs et un accompagnement (n=4)**#25 •**

Prise en charge de dossier, accompagnement

#109 •

logement, hébergement, accompagnement individuel

#123 •

Soutien à domicile

#129 •

Réponse aux besoins, direction dans le système, suivis personnels

Plaider et représenter les usagers (n=2)**#15 •**

Notre rôle de regroupement nous amène à siéger sur des concertations auprès du réseau de la santé. Nous apportons des plaidoyers et revendications dans ces espaces.

#125 •

pas de représentation, mais communications auprès d'institutions. Mettre de l'avant la prise de parole et les droits humains

Aider dans les démarches administratives (n=1)**#114 •**

Régulariser la situation administrative (langue, services, ressources...)

Coordonner l'écosystème / mener de la recherche (n=1)**#26 •**

Il se peut que nous participons à de recherches afin de créer un écosystème et faciliter l'accès aux services.

q11__1 — 11.1 Pour quelles raisons ?

Question mère (q11) : Facilité/difficulté à porter plainte pour les usagers

Propriété annotée : *Quelle est l'appréciation principale de l'accessibilité et de l'efficacité du dispositif de plainte (clarté, formation, ressources, confiance) ?*

Résumé des catégories

5 catégories • 17 réponses (16 internet, 1 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Accessible/clair	9	52.9%	9	0
Méfiance envers le traitement des plaintes	3	17.6%	3	0
Ne sait pas / pas d'information	2	11.8%	2	0
Ressources/énergie insuffisantes	2	11.8%	2	0
Info présente mais manque formation	1	5.9%	0	1
Total	17		16	1

Accessible/clair (n=9)

#1 • internet

Nous offrons de multiples plateformes pour expression des griefs etc

#5 • internet

Ils ont accès aux coordonnées et nous les supportons dans leurs démarches au besoin.

#10 • internet

Dès leur arrivée, on leurs explique leurs droits et comment porter plainte, l'affiche du commissaire aux plaintes se trouve près des cabines téléphoniques, et les membres du personnel savent qu'ils ne doivent pas intervenir. Et c'est respecté.

#14 • internet

Le chemin pour porter plainte ou manifester une insatisfaction est facile d'accès par le rôle du commissaire aux plaintes.

#37 • internet

La documentation et les contacts sont afficher dans nos immeubles ainsi que nommer lors des accueils

#50 • internet

parce que nous affichons la procédure à suivre en cas du désir d'un usager à désirer porter plainte à notre organisme.

Nous avons un représentant aux usagers le cas échéant...

#52 • internet

Auprès de leurs intervenants, ils peuvent ce confier.

#54 • internet

Un mécanisme installé depuis longtemps avec le CIUSS, accès au formulaire.

#90 • internet

Nous référons au bon endroit

Méfiance envers le traitement des plaintes (n=3)

#8 • internet

C'est facile car le réseau leur rappelle toujours qu'ils peuvent porter plainte et comment. Après c'est l'énergie qui manque parmi les autres défis à gérer. Également le commissaire aux plaintes et parfois même le protecteur donne trop souvent raison à l'établissement même quand injustifié. Les mécanismes du processus de plainte sont à revoir en profondeur.

#49 • internet

Mais souvent sans grand résultat

#104 • internet

C'est assez facile. Ils savent qu'il peuvent porter plainte au commissaire aux plaintes. Par contre, il ont peur de ne pas être pris au sérieux ou alors de subir des représailles.

Ne sait pas / pas d'information (n=2)

#83 • internet

Je ne sais pas

#95 • internet

Nous n'avons pas d'informations sur ce sujet

Ressources/énergie insuffisantes (n=2)

#23 • internet

Très peu d'employés

#103 • internet

Facile mais pas de portée nécessairement efficace dans tous les cas

Info présente mais manque formation (n=1)

#120 • téléphone

Ils ont accès à porter plainte l'information est suffisante, mais qu'il y ait plus de formation

q11__2 — 11.2 Pour quelles raisons ?

Question mère (q11) : Facilité/difficulté à porter plainte pour les usagers

Propriété annotée : *Quel est le principal type d'obstacle évoqué par la réponse qui empêche une personne de manifester une insatisfaction ou de porter plainte ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 88 réponses (65 internet, 23 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Méconnaissance / information	20	22.7%	16	4
Complexité / lourdeur administrative	18	20.5%	12	6
Barrières d'accès pratiques	15	17.0%	10	5
Capacités personnelles limitées	15	17.0%	12	3
Peur de représailles ou découragement	15	17.0%	10	5
non classable	5	5.7%	5	0
Total	88		65	23

Méconnaissance / information (n=20)

#16 • internet

Manque d'information sur le processus

#18 • internet

Processus méconnu, peu de soutien, limitations des usagers

#20 • internet

Manque d'information et peur de ne pas être écouté. Ils sont épuisé de se battre pour exister.

#33 • internet

Savoir à qui s'adresser et sentir que plainte est bien reçue.

#39 • internet

manque de soutien et d'information, difficile de croire que l'action portera des fruits

#40 • internet

manque de confiance, ne pas savoir nos droits, la langue

#41 • internet

Connaisse pas leurs droits, ne parle pas la langue

#53 • internet

Ils ne savent pas comment faire la plainte, comment la formuler, parfois, ils ne se rendent pas compte que leurs droits son bafouillés.

#60 • internet

Les usagers ne connaissent pas les mécanismes de plainte et des fois ont la crainte de le faire pour ne pas que cela impacte la qualité des services reçus

#65 • internet

Les usagers ne savent pas toujours où s'adresser pour déposer une plainte ou exprimer une insatisfaction. Il est souvent nécessaire de les guider afin qu'ils comprennent le fonctionnement des démarches formelles. Dans plusieurs situations, nous communiquons également avec leurs intervenants, travailleurs sociaux, infirmières ou médecins afin de faciliter les échanges et le suivi de la situation.

#70 • internet

Informations et capacité de se mobiliser. Niveau de littératie faible chez certains.

#77 • internet

il ne savent pas que ça existe, ne savent pas comment , ni ou le faire

#81 • internet

Méconnaissance des droits ...

#88 • internet

Les limites linguistiques y sont pour beaucoup et la méconnaissance des mécanismes formels.

#91 • internet

Je pense qu'ils n'ont pas toujours l'information que c'est un droit qu'ils ont.

#93 • internet

Le cas échéant, ils faut d'abord qu'ils comprennent avoir été lésés et saches qu'il existe un tel mécanisme, à quoi s'ajoute la difficulté d'exprimer clairement la situation à un tiers.

#111 • téléphone

L'accessibilité, le fait que les dossiers sont fermés facilement lorsque l'utilisateur se dit incompris, les gens ne savent même pas qu'ils peuvent porter plainte, le manque de connaissance

#114 • téléphone

Méconnaissance des droits, des comités des usager... donc ni comment porter plainte

#126 • téléphone

Ils n'ont pas les informations nécessaires

#127 • téléphone

On a eu à le faire pour certains cas et on a eu beaucoup de difficulté à joindre les comités des usagers car les boîtes vocales n'étaient pas dirigées et les numéros n'étaient plus bon. Donc manque d'information adéquate même pour l'organisme

Complexité / lourdeur administrative (n=18)

#17 • internet

Démarches longues

#28 • internet

1. La loi, en regard du régime de plaintes, ne parle aucunement d'insatisfaction.
2. Une plainte c'est un droit que l'utilisateur prétend avoir été enfreint
3. Les commissaires répondent rarement à la plainte en regard d'un droit

4. Une réponse appelée réponse à une insatisfaction ne fait pas partie du Régime de plaintes, du moins en regard de la Loi

5. De sorte qu'en majorité, les réponses des commissaires ne répondent pas réellement aux plaintes

#32 • internet

La personne va manifester à un personne externe par exemple son insatisfaction mais ne voudra pas aller porter plainte parce que compliquée, peur de ne pas être entendu, peur des représailles

#34 • internet

Dédales administratifs et manque de soutien dans les procédures. Trop complexe pour des universitaires, alors pour des personnes avec des enjeux de littéracie, cela est presque impossible.

#42 • internet

Complexe, demande du temps, de l'énergie et ils se sentent non entendue car il y a rarement des répercussions positives à la suite d'une plainte. Un coup d'épée dans l'eau pour les familles déjà épuisées.

#48 • internet

pas de processus accessible facile pour porter plainte ou pour obtenir de l'information

#63 • internet

bureaucratie

Les services se renvoient la balle.

#69 • internet

Ils ont le sentiment que c'est un lourd processus qui ne mènera à rien.

#71 • internet

C'est une impression. Difficile à dire mais dès que le système est trop gros, tout est difficile.

#78 • internet

Précarité de leur situation, difficulté de faire les suivis, bureaucratie complexe associée à une telle démarche

#100 • internet

Processus long et compliqué pour la plus part du temps. Peu de connaissance sur comment porter plainte. La connaissance de ses droits est aussi une barrière parce que si on ne les connaît pas, les personnes ne vont pas porter plainte lorsqu'elles sont bafouées.

#102 • internet

Accessibilité ou lourdeur administrative liée à la démarche de faire une plainte

#117 • téléphone

Manque d'information, les délais, la complexité des demandes, leur santé mentale

#118 • téléphone

La complexité du système, la marginalisation, l'énergie et la confiance

#119 • téléphone

La complexité du système, la façon dont on collige les plaintes c'est très difficile pour les personnes démunies, l'accès limitant au web et aux technologies...

#122 • téléphone

Les procédures sont très longues et complexes avec des résultats décevants et aléatoires, trop d'énergie via résultat

#124 • téléphone

Le manque d'énergie pour se battre dans la complexité du système et ses délais. Il y a un manque de confiance envers le système et sur les résultats

#129 • téléphone

Où porter plainte pour l'utilisateur ? Quel serait le résultat par rapport à l'énergie et la complexité des demandes

Barrières d'accès pratiques (n=15)**#0 • internet**

Encore faut-il que la personne puisse avoir toutes les informations utiles et l'accompagnement pour bien diriger sa plainte. Aussi, lorsque la personne est hospitalisée, elle est parfois privée de son téléphone... Lorsqu'un groupe comme nous est obligé d'aller porter un timbre à une personne hospitalisée pour qu'elle puisse adresser une plainte, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce système.

#7 • internet

barrière linguistique

#15 • internet

Système basé sur une boîte automatisée, services de plainte souvent en ligne alors que la littératie numérique n'est pas certaine auprès de plusieurs populations.

#29 • internet

il est difficile de savoir à qui s'adresser et d'être pris en considération

#31 • internet

nos usagers sont des personnes avec un handicap visuel. il est donc très difficile d'avoir accès à l'information ou avoir des personnes pour les aider

#47 • internet

Où, comment, à qui, trop long et ça va donner quoi ?

#72 • internet

Car il y a peu d'aide, en répondant, je réalise qu'on n'interpelle pas suffisamment les org. de défense

#84 • internet

Le système fait qu'il est compliqué pour le patient de savoir où et à qui s'adresser. Difficulté à parler à une personne au téléphone et où la difficulté à avoir accès à internet ou ordi.

#96 • internet

Parce qu'ils sont mineurs

#97 • internet

Qui est responsable dans mon secteur, du service aux plaintes pour le citoyen ?

Il faut se renseigner auprès d'une personne faisant parti des organismes du quartier.

#105 • téléphone

L'accès difficile

#106 • téléphone

Tout l'accès aux plaintes est difficile : trouver les bonnes personnes, l'ordinateur, la crainte de perdre des services...

#123 • téléphone

Accès, information, manque d'information, énergie, capacités, la solitude...

#125 • téléphone

Nous on met à disposition les informations sur les défenses des droits et actions et devons les informer et les aider et même à cela c'est une grosse machine que peu de notre clientèle ferait seul.

#128 • téléphone

La crainte des représailles, la difficulté de l'accès, la langue et culture différente des nouveaux arrivants, la complexité du système... L'accès à un ordinateur et comprendre la façon de faire

Capacités personnelles limitées (n=15)

#2 • internet

niveau de littératie basse

en mode suivie

autres priorités, charge mentale

#3 • internet

Il s'agit d'une clientèle peu éduqués avec difficultés à lire et écrire.

#9 • internet

Quand une personne est en survie ou en grande précarité, ce n'est pas sa priorité

#25 • internet

À partir de notre expérience concrète à l'Académie Stella, nous pouvons affirmer sans détour qu'il est généralement très difficile pour les personnes que nous représentons de manifester une insatisfaction ou de porter plainte. Cette difficulté n'est pas marginale, elle est systémique, et elle touche la très grande majorité de nos bénéficiaires à des degrés divers. Loin de constituer une simple formalité administrative accessible à tous, le processus de plainte représente pour nos usagers un parcours semé d'obstacles dont chacun, pris individuellement, peut suffire à décourager une démarche, et dont l'accumulation rend la démarche quasi impraticable sans accompagnement soutenu.

La première difficulté tient à la nature même de la condition de nos bénéficiaires. Vivre avec un trouble de santé mentale ou un handicap psychologique signifie souvent composer quotidiennement avec une énergie limitée, une concentration fluctuante, une anxiété parfois envahissante, une estime de soi fragile et une capacité d'organisation altérée. Or, formuler une plainte exige précisément les ressources qui font défaut aux personnes concernées : il faut structurer un récit cohérent des événements, identifier les faits pertinents, retrouver des dates précises, conserver des preuves, rédiger une lettre claire, respecter des délais, rappeler des interlocuteurs qui ne rappellent pas, répéter son

histoire à de multiples reprises. Pour une personne en épisode dépressif, pour une personne vivant avec un trouble anxieux généralisé, pour une personne en phase de stabilisation après un épisode psychotique, ces exigences représentent une montagne. Plusieurs de nos bénéficiaires nous confient abandonner leur démarche simplement parce qu'ils n'en ont plus la force, même lorsqu'ils savent que leurs droits ont été bafoués.

La deuxième difficulté tient à la peur des conséquences. Cette peur, que nous avons déjà évoquée précédemment, constitue un frein extraordinairement puissant. Porter plainte contre un psychiatre, contre une équipe soignante, contre un établissement, c'est risquer de compromettre la relation thérapeutique, c'est craindre d'être perçu comme un patient difficile, c'est redouter que son dossier soit dorénavant traité avec plus de froideur ou de réserve. Cette peur n'est pas irrationnelle. Nos bénéficiaires nous rapportent régulièrement des situations où, après avoir manifesté une insatisfaction, ils ont perçu un changement dans l'attitude du personnel à leur égard. Même lorsque ce changement n'est pas objectivement prouvable, sa possibilité suffit à dissuader la plupart des personnes. La dépendance de l'utilisateur envers le système dans lequel il souhaite porter plainte constitue un déséquilibre fondamental qui mine à la base l'exercice de ce droit.

La troisième difficulté tient à la complexité du système de plaintes lui-même. Pour un usager ordinaire, comprendre à qui s'adresser selon la nature de son insatisfaction relève du casse-tête. S'agit-il d'un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ? Du Protecteur du citoyen ? D'un ordre professionnel ? De la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ? Du Curateur public ? D'un tribunal administratif ? D'un recours civil ? Chaque instance a ses propres procédures, ses propres délais, ses propres critères de recevabilité, son propre langage. Se tromper d'instance, c'est perdre du temps, parfois dépasser des délais, et devoir recommencer ailleurs. Cette complexité décourage jusqu'aux personnes les mieux outillées. Pour nos bénéficiaires, elle constitue souvent un obstacle insurmontable sans accompagnement professionnel.

La quatrième difficulté tient à la méconnaissance des droits et des recours. Beaucoup de nos bénéficiaires ignorent tout simplement qu'ils peuvent porter plainte, ou pensent que ce droit est réservé à certaines situations graves, ou croient que leur parole ne sera pas crue. Lorsqu'ils découvrent, parfois grâce à nous, qu'ils auraient pu porter plainte plus tôt, les délais sont fréquemment expirés. L'information sur les droits et les recours circule mal, elle est rédigée dans un langage peu accessible, elle est dispersée entre de multiples sources, et elle n'est que rarement proactivement transmise aux usagers au moment où ils en auraient besoin.

La cinquième difficulté tient à la crédibilité accordée à la parole des usagers. Lorsqu'une personne vivant avec un trouble de santé mentale exprime une insatisfaction, cette parole est souvent réinterprétée à travers le prisme de son diagnostic. On suggère que la personne est en crise, qu'elle interprète mal les événements, qu'elle projette sur le personnel des émotions qui lui appartiennent, qu'elle est dans un mécanisme de transfert, que sa perception est altérée par sa condition. Cette décrédibilisation systémique décourage profondément les personnes concernées. À quoi bon formuler une plainte si l'on sait d'avance qu'elle sera disqualifiée en raison de son origine ? Ce mécanisme particulièrement pernicieux touche les personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite, un trouble psychotique ou un trouble dissociatif, qui voient leur parole systématiquement mise en doute avant même d'être entendue.

La sixième difficulté tient à la lourdeur émotionnelle du processus. Porter plainte, c'est revisiter l'événement qui a causé le tort, le décrire en détail, le documenter, le défendre face à la contestation éventuelle de l'autre partie. Pour une personne ayant vécu une atteinte à sa dignité, une humiliation, un geste inapproprié, une négligence, ce processus constitue une forme de revictimisation. Plusieurs de nos bénéficiaires nous disent vouloir simplement tourner la page, oublier ce qui s'est passé, ne plus y penser. Cette réaction, parfaitement compréhensible, prive néanmoins le système de l'information dont il aurait besoin pour s'améliorer, et prive la personne d'une reconnaissance qui pourrait être réparatrice.

La septième difficulté tient aux délais. Les délais pour obtenir une réponse à une plainte sont souvent

longs, parfois plusieurs mois, parfois plus d'une année. Pendant toute cette période, la personne attend, ressasse, espère. Cette attente constitue une charge supplémentaire pour des personnes dont les ressources psychiques sont déjà limitées. Certains de nos bénéficiaires développent, durant cette attente, des symptômes aggravés d'anxiété ou de dépression directement liés à l'incertitude dans laquelle ils sont maintenus. D'autres abandonnent en cours de route, simplement parce que l'attente est devenue insoutenable.

La huitième difficulté tient à la perception d'inutilité. Beaucoup de nos bénéficiaires, souvent après avoir vécu des expériences antérieures infructueuses, sont convaincus qu'une plainte ne changera rien. Ils estiment que le système protège les siens, que les institutions se couvrent mutuellement, que les conclusions seront favorables aux professionnels plutôt qu'à eux. Cette perception, qu'elle soit fondée ou non, est ancrée dans l'expérience collective des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, et elle se transmet d'une personne à l'autre, d'une génération de bénéficiaires à la suivante. Convaincre une personne de porter plainte suppose souvent, préalablement, de reconstruire chez elle une confiance minimale dans la possibilité d'un changement, ce qui constitue en soi un travail considérable.

La neuvième difficulté tient aux obstacles matériels. Porter plainte demande du temps, des déplacements, des photocopies, des appels téléphoniques, parfois l'accès à un ordinateur et à internet, parfois des frais postaux ou de transport. Pour des personnes vivant souvent dans des conditions de précarité économique, ces obstacles matériels ne sont pas négligeables. Une personne qui dépend de la solidarité sociale, qui n'a pas de véhicule, qui partage un logement sans espace privé pour téléphoner en confidentialité, se trouve dans une position objectivement défavorable pour mener à terme une démarche de plainte.

La dixième difficulté tient à l'isolement dans lequel se trouvent beaucoup de nos bénéficiaires. Porter plainte seul, sans soutien, sans personne pour valider son expérience, pour relire sa lettre, pour l'accompagner aux rencontres, pour absorber sa frustration lorsque le processus piétine, est extrêmement difficile. Or, nombreux sont les usagers qui, précisément en raison de leur trouble de santé mentale, vivent dans un isolement relationnel significatif. Leurs proches, lorsqu'ils existent, sont parfois épuisés, parfois eux-mêmes fragilisés, parfois incapables de comprendre la situation vécue. L'absence de soutien relationnel constitue ainsi un facteur majeur de renoncement aux démarches.

Malgré tous ces obstacles, une partie de nos bénéficiaires parvient néanmoins à manifester une insatisfaction ou à porter plainte, le plus souvent avec notre accompagnement soutenu. Lorsque cela se produit, nous constatons que le processus peut parfois aboutir à des résultats positifs : une reconnaissance de l'erreur commise, un changement de pratiques, parfois une forme de réparation symbolique. Ces succès, bien que minoritaires par rapport au volume des atteintes réelles aux droits, sont importants. Ils montrent que le système peut répondre, lorsqu'on le sollicite avec persévérance et compétence. Mais ils ne doivent pas masquer la réalité de fond : la grande majorité des atteintes aux droits vécues par nos bénéficiaires ne font jamais l'objet d'une plainte formelle, non parce qu'elles sont mineures, mais parce que le chemin pour les dénoncer est trop exigeant.

Notre rôle à l'Académie Stella consiste précisément à tenter de combler cet écart. Nous accompagnons les personnes qui souhaitent porter plainte en les aidant à structurer leur récit, à identifier la bonne instance, à rédiger leurs communications, à préparer leurs rencontres, à faire face aux réactions défensives des institutions, à supporter les délais et à interpréter les réponses reçues. Cet accompagnement transforme radicalement la capacité d'une personne à mener sa démarche jusqu'au bout. Nous constatons cependant que notre capacité d'accompagnement est elle-même limitée par nos ressources, et que de nombreuses personnes qui auraient besoin de nous ne nous trouvent pas ou nous trouvent trop tard.

Ce que nous observons donc, au final, c'est une asymétrie profonde entre la facilité théorique de porter plainte, telle que la présentent les documents officiels et les sites institutionnels, et la difficulté réelle de le faire, telle que la vivent les personnes concernées. Cette asymétrie n'est pas anodine. Elle signifie que les mécanismes de plainte, conçus pour protéger les usagers, protègent en réalité davan-

tage ceux qui sont déjà outillés, informés et soutenus, que ceux qui en auraient le plus besoin. Elle signifie aussi que le système reçoit une image tronquée de son propre fonctionnement, puisque les insatisfactions les plus graves, vécues par les personnes les plus vulnérables, sont précisément celles qui ont le moins de chances d'être formellement exprimées. Pour que le droit de porter plainte devienne un droit réellement accessible, il faudrait repenser en profondeur les modalités de son exercice, renforcer considérablement les ressources d'accompagnement indépendantes, simplifier radicalement les procédures, raccourcir les délais, protéger effectivement contre les représailles, et surtout, accorder une crédibilité pleine et entière à la parole des usagers, sans la filtrer systématiquement à travers le prisme de leur diagnostic. Tant que ces transformations ne seront pas réalisées, la manifestation d'une insatisfaction demeurera, pour les personnes que nous représentons, une démarche possible en théorie mais ardue en pratique, et cette ardeur constituera elle-même une forme d'atteinte à leurs droits.

#27 • internet

Parce qu'ils sont vulnérables et ne sont pas équipés pour se défendre. Ils ont également une mauvaise compréhension du système.

#44 • internet

Les usagers ne veulent pas se défendre, trop long, trop compliqué, trop énergivore

#58 • internet

pas la force de le faire, se sentent incompris et un sentiment d'injustice

#61 • internet

Ils ne savent pas comment et nous ne sommes pas outillé pour les accompagner (aucune formation sur ce sujet et parfois un manque de temps)

#64 • internet

Il s'agit d'une clientèle souvent vulnérable et ils ont besoin d'aide et de soutien pour porter plainte

#76 • internet

Les usagers peuvent avoir des difficultés cognitives associés à leur condition de santé mentale. De plus, malgré la sensibilisation, le rapport d'autorité que peut représenter l'hôpital peut peut-être nuire à la liberté d'expression.

#79 • internet

parce que souvent c'est un fardeau de plus sur leurs épaules et ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. C'est des cas et des situations complexes que les gens vivent. La santé mentale aussi fragilise le fait de porter plainte

#80 • internet

peut de temps à accorder à ce genre de processus qui trop souvent ne donne rien et désaffiliation + problèmes multiples et nombreux qui facilitent l'abandon.

#109 • téléphone

Les gens ne sont pas capable d'utiliser les outils, internet et c'est trop complexe

#110 • téléphone

C'est complexe car les gens n'ont pas toujours l'éducation ou le niveau de langage pour se défendre, même se rappeler le défilé des événements, les usagers ne savent même pas qu'il faut tout écrire en détail. Aussi, souvent les usagers ne sont pas crus en cas de plainte. Les gens peuvent aussi avoir peur des représailles ou d'être pénalisé...

#116 • téléphone

Ils ne savent pas comment faire et ont besoin d'accompagnement autant au niveau matériel que pour comprendre

Peur de représailles ou découragement (n=15)**#6 • internet**

la peur d'avoir encore moins de services

#12 • internet

Leur voix compte bien peu

#24 • internet

Plusieurs usagers ne connaissent pas les mécanismes de plainte existants ni leurs droits. Les démarches peuvent sembler complexes, longues et peu accessibles, particulièrement pour les personnes vivant des enjeux de santé mentale, de précarité résidentielle, de handicap, de barrières linguistiques ou d'isolement social.

Certaines personnes craignent également des répercussions sur les services qu'elles reçoivent, de ne pas être prises au sérieux, ou revivent des expériences négatives avec des institutions, ce qui peut les décourager de porter plainte.

Lorsqu'une personne est déjà en situation de crise ou tente de répondre à des besoins de base (logement, sécurité alimentaire, santé), le processus de plainte devient rarement une priorité malgré des expériences insatisfaisantes.

#30 • internet

Méfiance du système

#36 • internet

Les personnes ont l'impression que leur plainte ne changera rien, puisque les structures en place font en sorte que certains droits ne peuvent pas être respectés, et que la structure est peu encline à changer

#38 • internet

très peu pris au sérieux

#62 • internet

Les services étant souvent difficiles à obtenir et les listes d'attente importantes, certaines familles peuvent hésiter à exprimer une insatisfaction ou à déposer une plainte par crainte que cela ait un impact négatif sur leur accès aux services ou sur leur relation avec les intervenants du réseau.

#68 • internet

Barrières d'accès, crainte de représailles, barrières liées à la compréhension du processus, épuisement.

#85 • internet

Le CAAP aide énormément. Sinon, beaucoup de résistance institutionnelle.

#92 • internet

Même si la démarche peut être facile administrativement, les usagers n'ont pas confiance qu'elle va mener à un quelconque changement et ont l'impression que le rapport d'autorité est trop grand.

#107 • téléphone

Accessibilité est difficile et pour les clientèles marginalisés ils ont peur que cela soit utilisé contre eux d'aller chercher de l'aide

#108 • téléphone

Manque de connaissance et complexité du système, la peur des représailles

#112 • téléphone

C'est compliqué, complexe, peur des représailles, se battre contre une institution leur semble inutile

#113 • téléphone

Ils ne connaissent pas leurs droits, peur de représailles des gangs, complexité de comprendre le système, manque d'organisation et mauvaise image des institutions société

#115 • téléphone

Ils ont peur des répercussions

non classable (n=5)

#11 • internet

No 6

#43 • internet

Nous n'avons jamais eu à faire cette démarche

#89 • internet

Bureaucratie

Manque d'informations

Manque de soutien et d'accompagnement

#94 • internet

-Ils craignent de perdre l'accès aux services du CLSC.

-Méconnaissance de la procédure nécessaire pour porter plainte.

-Choix de ne pas porter plainte, considérant les multiples problématiques vécues.

#101 • internet

voir réponses précédente

q12-Comment — 12. À quelle instance du réseau de la santé et des services sociaux pourriez-vous référer un usager qui aurait à exprimer une plainte ou une insatisfaction ?

Question mère (q12) : Instances vers qui référer une plainte

Propriété annotée : *Quel type d'acteur la réponse propose comme interlocuteur pour une plainte (ex. organisme communautaire, instance de santé locale, autorité de protection, etc.) ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 26 réponses (13 internet, 13 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Ne sait pas / impossible à identifier	5	19.2%	4	1
Organisme communautaire / aidant local	5	19.2%	1	4
Comité/porte-parole des usagers ou CAAP	4	15.4%	2	2
Instance de surveillance/ombudsman	4	15.4%	3	1
Instance juridique/ de protection des droits (Conseil, droit de la personne)	4	15.4%	3	1
Établissement de santé local (CLSC/CIUSS)	4	15.4%	0	4
Total	26		13	13

Ne sait pas / impossible à identifier (n=5)

#23 • internet

Je ne saurais pas ou référer un usagé

#45 • internet

Non Profit

#48 • internet

je ne sais pas puisque nous sommes un services privés actuellement

#97 • internet

Quel est le nom du commissaire ? Qui est responsable de comité des usagers ? Tellement de questions sans réponses que je suis épuisé avant de faire ma demande.

#113 • téléphone

policiers et agents communautaires

Organisme communautaire / aidant local (n=5)

#10 • internet

CU de notre organisme

#110 • téléphone

Aide communautaire (commission des droits de la jeunesse), mais je ne l'ai jamais mené à terme, car les usagers interrompaient le processus, c'est un autre combat qui demande tellement d'énergie.

#122 • téléphone

Nos partenaires communautaires

#125 • téléphone

organisme Action et autonomie

#128 • téléphone

Liens avec organisateurs communautaires

Comité/porte-parole des usagers ou CAAP (n=4)

#28 • internet

CAAP

Conseil pour la protection des malades

#42 • internet

CAAP

#105 • téléphone

Commissaire aux plaintes, mais plus au comité des usagers ou CLSC

#119 • téléphone

On a pas le réflexe de passer par les comités des usagers, on ne les connaît pas assez

Instance de surveillance/ombudsman (n=4)

#8 • internet

Protecteur dans certains cas pour des plaintes qu'on peut adresser en première instance.

#25 • internet

Lorsqu'un usager de nos services à l'Académie Stella souhaite exprimer une insatisfaction ou porter une plainte, plusieurs instances peuvent être sollicitées selon la nature de la situation, le type d'établissement concerné, la profession du professionnel impliqué et le type de recours recherché. Notre rôle consiste précisément à orienter la personne vers l'instance la plus appropriée et à l'accompagner dans sa démarche. Voici un portrait détaillé des principales instances vers lesquelles nous pouvons diriger un usager, ainsi que des situations pour lesquelles chacune est compétente.

La première instance, et souvent la porte d'entrée du régime d'examen des plaintes, est le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, désigné dans chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Ce commissaire est prévu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et constitue le premier recours formel pour toute personne insatisfaite des services reçus dans un centre hospitalier, un CLSC, un CHSLD, un centre de réadaptation, un centre jeunesse ou tout autre établissement relevant d'un centre intégré de santé et de services sociaux ou d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Le commissaire local a pour mandat de recevoir la plainte, de l'examiner, de mener les consultations nécessaires auprès du personnel concerné, de formuler des conclusions et, le cas échéant, de recommander des mesures correctives. Il dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour traiter une plainte. Le commissaire local est également accessible pour une simple manifestation d'insatisfaction qui ne prendrait pas la forme d'une plainte formelle, ce qui en fait un interlocuteur souple et relativement accessible. Il peut recevoir la plainte verbalement, par écrit, en personne, par téléphone ou par courriel. Pour nos bénéficiaires, le

commissaire local constitue souvent la première étape que nous recommandons, parce qu'il permet une résolution relativement rapide et proche du lieu où la situation s'est produite.

La deuxième instance est le commissaire aux plaintes et à la qualité des services pour les services médicaux, lorsque la plainte concerne spécifiquement un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident exerçant dans un établissement. Dans ces cas, la plainte est automatiquement transmise par le commissaire local au médecin examinateur de l'établissement, qui dispose d'un mandat spécifique pour examiner les plaintes concernant les professionnels médicaux. Le médecin examinateur peut conclure que la plainte nécessite un examen par le comité de discipline, qu'elle justifie des mesures correctives, ou qu'elle ne nécessite aucune suite. L'utilisateur insatisfait de la conclusion du médecin examinateur peut demander la révision de cette décision par le comité de révision de l'établissement, qui constitue une seconde instance interne pour ce type de plaintes.

La troisième instance, accessible en cas d'insatisfaction quant aux conclusions du commissaire local ou en l'absence de réponse dans le délai prescrit, est le Protecteur du citoyen, qui agit comme Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux pour les plaintes de deuxième niveau. Le Protecteur du citoyen constitue une instance indépendante du réseau de la santé, relevant directement de l'Assemblée nationale, ce qui lui confère une autorité morale considérable. Il peut enquêter de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, formuler des recommandations aux établissements, aux ministères et au gouvernement, et rendre publics ses constats par la publication de rapports. Pour nos bénéficiaires, le Protecteur du citoyen représente un recours particulièrement précieux lorsque la démarche auprès du commissaire local n'a pas donné les résultats escomptés, ou lorsque la situation révèle un problème systémique qui dépasse le cas individuel. Il convient toutefois de noter que le Protecteur du citoyen n'a pas compétence pour les plaintes concernant spécifiquement un médecin, un dentiste, un pharmacien ou un résident, ces plaintes devant suivre le parcours du médecin examinateur puis du comité de révision.

La quatrième catégorie d'instances regroupe les ordres professionnels, auxquels l'utilisateur peut s'adresser lorsque sa plainte concerne la conduite d'un professionnel particulier dans l'exercice de sa profession. Au Québec, chaque profession réglementée dispose de son propre ordre professionnel, qui est responsable de recevoir les plaintes concernant la conduite déontologique de ses membres. Le Collège des médecins du Québec reçoit les plaintes concernant les médecins, notamment pour des questions de compétence clinique, de déontologie ou d'éthique professionnelle. L'Ordre des psychologues du Québec reçoit les plaintes concernant les psychologues et les détenteurs du permis de psychothérapeute. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec reçoit les plaintes concernant les infirmières et infirmiers. L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec reçoit les plaintes concernant les travailleurs sociaux. D'autres ordres existent pour les ergothérapeutes, les psychoéducateurs, les sexologues, les criminologues et d'autres professions impliquées dans les services de santé et les services sociaux. Chaque ordre professionnel dispose d'un syndic dont le rôle est d'enquêter sur les plaintes et de décider s'il y a lieu de déposer une plainte devant le conseil de discipline de l'ordre. Pour nos bénéficiaires, les ordres professionnels constituent un recours particulièrement pertinent lorsque la conduite d'un professionnel spécifique est en cause, notamment dans des situations de manquement déontologique grave, de bris de confidentialité, de conduite inappropriée ou de négligence professionnelle.

La cinquième instance est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui est compétente lorsque la plainte concerne une discrimination fondée sur l'un des motifs prévus par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Pour nos bénéficiaires, cette instance est particulièrement pertinente lorsque la discrimination subie est liée au handicap, ce qui inclut les troubles de santé mentale reconnus comme handicaps au sens de la Charte. Les situations de refus d'accommodement raisonnable, de refus d'accès à un service en raison de la présence d'un chien d'assistance, de discrimination à l'emploi, au logement ou dans l'accès aux biens et services, relèvent directement de cette instance. La Commission peut mener des enquêtes, proposer des mesures de médiation, et saisir le Tribunal des droits de la personne lorsque la situation le justifie. Les décisions

du Tribunal peuvent entraîner des condamnations à des dommages-intérêts, à des dommages moraux et même à des dommages punitifs dans les cas de discrimination intentionnelle.

La sixième instance est le Curateur public du Québec, compétent lorsque la plainte concerne la protection d'une personne inapte ou vulnérable, notamment en matière de régimes de protection, de mandats de protection homologués, ou de traitement inadéquat d'une personne représentée. Pour nos bénéficiaires sous régime de protection, ou pour leurs proches, le Curateur public peut constituer un recours important lorsque les droits d'une personne inapte semblent avoir été compromis.

La septième catégorie de recours concerne les tribunaux administratifs et judiciaires. Le Tribunal administratif du Québec, dans sa section des affaires sociales, entend notamment les contestations relatives aux décisions rendues en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, communément appelée P-38, ainsi que les décisions concernant l'inaptitude à consentir aux soins. Pour les personnes ayant fait l'objet d'une garde en établissement, d'une autorisation judiciaire de soins ou d'une évaluation psychiatrique imposée, ces recours peuvent être déterminants. Les tribunaux civils, quant à eux, peuvent être saisis pour des recours en dommages-intérêts lorsque la faute commise a causé un préjudice matériel ou moral significatif, bien que ces recours soient généralement longs, coûteux et exigeants, et qu'ils soient rarement la première option que nous recommandons à nos bénéficiaires.

La huitième instance est le Commissaire à la santé et au bien-être, lorsqu'il est opérationnel, qui a pour mandat d'évaluer la performance globale du système de santé et des services sociaux et de formuler des recommandations au gouvernement. Bien que cette instance ne reçoive pas directement les plaintes individuelles, elle peut constituer un relais important pour les problèmes systémiques, notamment lorsqu'un ensemble de situations individuelles révèle un dysfonctionnement plus large.

La neuvième catégorie regroupe les comités des usagers et les comités des résidents, présents dans chaque établissement du réseau. Ces comités, bien qu'ils ne reçoivent pas formellement les plaintes au sens strict, ont un rôle important d'information, de défense collective des droits et d'accompagnement des usagers dans leurs démarches. Ils peuvent orienter une personne vers les bonnes instances, l'informer sur ses droits, et parfois intervenir collectivement auprès de l'administration de l'établissement sur des problèmes récurrents. Pour nos bénéficiaires hébergés en CHSLD ou en ressources intermédiaires, les comités des résidents constituent souvent un premier lieu d'écoute accessible.

La dixième instance est la Commission d'accès à l'information du Québec, compétente lorsque la plainte concerne l'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier médical ou social, le refus de correction d'un dossier, ou une atteinte à la confidentialité des renseignements personnels. Pour nos bénéficiaires, cette instance est particulièrement pertinente lorsqu'une fuite de renseignements confidentiels a eu lieu, lorsque l'accès à leur propre dossier leur a été refusé, ou lorsque des informations erronées contenues dans leur dossier n'ont pas été corrigées malgré leur demande.

La onzième instance, dans un registre différent mais pertinent pour certaines situations, est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, pour les situations où un usager est également un travailleur ayant subi une lésion professionnelle en lien avec sa santé mentale, ou pour certaines questions relatives aux normes du travail lorsque des accommodements liés à un trouble de santé mentale sont refusés par un employeur.

La douzième instance, pour les situations les plus graves, est le Directeur des poursuites criminelles et pénales, par l'intermédiaire des services policiers, lorsque les faits reprochés constituent une infraction criminelle. Les situations d'agression, d'abus sexuel, de voies de fait ou de négligence criminelle commises par un professionnel ou dans un établissement peuvent faire l'objet d'une plainte criminelle parallèlement aux autres recours disponibles.

Il convient de souligner que ces différentes instances ne sont pas mutuellement exclusives. Une même situation peut parfois justifier des démarches parallèles auprès de plusieurs instances. Une situation d'agression commise par un professionnel dans un établissement peut, par exemple, donner lieu

simultanément à une plainte au commissaire local, à une plainte à l'ordre professionnel du professionnel concerné, à une plainte criminelle, et à un recours civil pour dommages-intérêts. Notre travail d'accompagnement consiste précisément à aider la personne à comprendre les recours disponibles, à évaluer les avantages et les inconvénients de chacun, à prioriser les démarches en fonction de ses objectifs et de ses ressources, et à l'accompagner tout au long du parcours choisi.

Nous tenons également à préciser que, parallèlement aux instances officielles, il existe des organismes communautaires spécialisés dans la défense des droits qui peuvent offrir un accompagnement précieux. Les organismes membres du regroupement des organismes d'aide et d'accompagnement aux plaintes, financés notamment par les agences de la santé et des services sociaux, ont pour mandat spécifique d'aider les usagers à formuler et à mener leurs plaintes dans le réseau de la santé. Leur rôle est complémentaire au nôtre et nous collaborons régulièrement avec eux lorsque la situation s'y prête. D'autres organismes plus spécialisés, comme les groupes de défense des droits en santé mentale présents dans chaque région, offrent également une expertise pointue sur les questions spécifiques touchant les personnes vivant avec un trouble de santé mentale.

En somme, le paysage des recours disponibles est riche et diversifié, mais sa complexité constitue elle-même, comme nous l'avons souligné précédemment, un obstacle important pour les personnes que nous représentons. C'est pourquoi notre rôle d'orientation et d'accompagnement est essentiel. Sans cet accompagnement, les usagers se perdent souvent dans ce labyrinthe institutionnel, s'adressent à la mauvaise instance, dépassent des délais, ou abandonnent en cours de route. Avec cet accompagnement, les chances d'aboutir à une démarche significative augmentent considérablement, et les droits formellement reconnus par la législation québécoise ont une chance d'être effectivement exercés par celles et ceux à qui ils sont destinés.

#103 • internet

également le Protecteur du citoyen

#109 • téléphone

Le commissaire aux plaintes n'est pas évident pour nous, on ne sait pas c'est qui

Instance juridique/ de protection des droits (Conseil, droit de la personne) (n=4)

#4 • internet

commission des droits de la personne

#34 • internet

Commission des droits de la personne

#95 • internet

Commission des droits de la personne, Ruta, Office des personnes handicapées

#111 • téléphone

le droit de la personne

Établissement de santé local (CLSC/CIUSS) (n=4)

#106 • téléphone

A-B- et CLSC

#107 • téléphone

a et b, mais je ne l'ai jamais fait. Mais directement au CIUSS ou CLSC pour les référer

#108 • téléphone

a-b, CLSC, organisme communautaire

#117 • téléphone

Les jeunes en difficulté sont mal accueillis dans les CLSC car leurs problèmes y sont minimisés et ils se sentent invalidés dans leurs besoins. Ce serait bien que les intervenants n'attendent pas les extrêmes

q13 — 13. Auriez-vous des commentaires à formuler sur la facilité de trouver la bonne instance pour porter plainte ou pour exprimer une insatisfaction ?

Propriété annotée : *Quel est l'objectif principal du commentaire : signale-t-il principalement une difficulté, propose-t-il une amélioration, affirme-t-il que c'est clair/facile, ou ne donne-t-il pas de contenu utile ?*

Résumé des catégories

5 catégories • 63 réponses (42 internet, 21 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Propose une amélioration	25	39.7%	21	4
Signale une difficulté	24	38.1%	9	15
Dit que c'est clair/facile	5	7.9%	3	2
Aucun renseignement / refus de répondre	4	6.3%	4	0
non classable	5	7.9%	5	0
Total	63		42	21

Propose une amélioration (n=25)

#15 • internet

Instaurer une ligne téléphonique qui mène directement à un être humain.

#21 • internet

Pas tous les représentant dans un comité d'usagers sont bien informé eux-mêmes.

Il faut simplifier les démarches/protocoles administratives. 45 jours est beaucoup trop long pour traite une plainte officielle.

#23 • internet

Avoir une affiche obligatoire affiché dans tous les organismes et sur la page du 211

#24 • internet

De façon générale, il n'est pas toujours facile pour les usagers de trouver la bonne instance pour porter plainte ou exprimer une insatisfaction. Les mécanismes existants sont souvent peu connus, et il peut être difficile de comprendre vers qui se tourner selon la situation.

L'information n'est pas toujours visible, accessible ou présentée dans un langage clair. Pour plusieurs de nos usagers, la complexité administrative, les barrières linguistiques, les limitations liées à un handicap, ainsi que les enjeux de santé mentale ou de précarité peuvent rendre ces démarches encore plus difficiles.

Il serait utile de simplifier les processus, de mieux diffuser l'information et d'offrir davantage d'accompagnement afin que les usagers puissent faire valoir leurs droits plus facilement.

#29 • internet

mettre en place un service de médiation

#36 • internet

Avoir des affichages clairs sur les coordonnées pour porter plainte, qui s'adapte au niveau de langage de tous

#42 • internet

Lors du premier contact avec la famille, un professionnel devrait prendre le temps de leur expliquer leurs droits, il faudrait que le processus soit simple, ensuite il faudrait que les familles aient confiance en ce système.

#44 • internet

Aller à la rencontre des gens en personnes ou au téléphone. En ligne ou sur une base volontaire ne sont pas des moyens très efficaces avec les populations vulnérables

#53 • internet

Une approche humaine qui comprend la difficulté de communication

#61 • internet

Des agents qui peuvent répondre spécifiquement à ces questions. Je crois que les partenaires doivent pouvoir référer à quelqu'un, mais ne pourront jamais accompagner dans toute les subtilités de démarches. Il devrait donc y avoir une personne comme un agent de liaison.

#68 • internet

Idéalement, il y aurait une seule instance qui recevrait les plaintes et s'occuperait par la suite de la faire suivre à l'instance concernée. Une sorte de guichet d'accès mais pour la défense des droits.

#70 • internet

Documentation écrite accessible.

#76 • internet

Brochure à la fin de la période d'hospitalisation remise aux usagers

#77 • internet

une meilleure publicité vulgarisé, visible simple à réaliser

#81 • internet

Avoir une documentation précise et claire et simple à consulter

#88 • internet

Il faut penser à de courtes capsules d'information adaptées en LSQ informant la population ciblée quant à l'existence même de ces instances.

#89 • internet

Rendre facile et accessible l'information en ligne

Offrir du soutien et de l'accompagnement pour compléter les documents et formulaires

Promouvoir l'accès au processus de plainte

#97 • internet

Sensibiliser la population par des rencontres informatives en présentiel ou sur le web. Distribuer par les maisons des documents papiers explicatifs des services qui sont offerts dans le quartier. Avoir une ligne d'écoute et de renseignements pour les usagers qui ont une insatisfaction. Où me diriger, quels papiers remplir, avoir un support physique en rencontrant une personne qui peut nous éclairer.

#100 • internet

Nous référons le CAP parce que le monde ne le connaît pas d'habitude. Donc, plus de visibilité à mon avis. Le processus avec le CAP semble assez simple qui est un gros plus, mais peu de mordant.

#101 • internet

vulgarisation, traduction du matériel

#103 • internet

un site web présentant les droits, les recours, les récents changements législatifs, serait utile

#105 • téléphone

Il faudrait que ce soit plus clair et simple pour les droits et porter plainte et mieux former les organismes pour pouvoir les référer au bon endroit. Même pour les organisme c'est complexe, le CIUSS est tellement grand et tellement de portes que ça peut être mêlant

#113 • téléphone

Il manque de affiches, des dépliants pour informer mieux et sensibiliser de leurs droits

#114 • téléphone

Que ce soit plus clair et concret pour savoir à qui s'adresser

#129 • téléphone

Très difficile, vraiment pas évident même pour nous ! C'est l'ensemble des organismes qui devraient être informés par le CIUSS pour pouvoir référer

Signale une difficulté (n=24)

#14 • internet

Selon notre point de vue, ce n'est pas tant l'instance pour porter plainte qui est un obstacle. Mais l'impression d'avoir le droit de faire part de son insatisfaction ou de sa plainte. La peur de déplaire, de heurter des personnes qui nous aide.

#25 • internet

Nous avons effectivement de nombreux commentaires à formuler sur la facilité, ou plus exactement sur la difficulté, de trouver la bonne instance pour porter plainte ou exprimer une insatisfaction dans le réseau de la santé et des services sociaux. Cette question nous apparaît d'ailleurs centrale, car elle touche à un paradoxe fondamental du système : la multiplication des instances, présentée comme une garantie de protection des droits des usagers, produit en réalité une complexité qui constitue elle-même un obstacle majeur à l'exercice de ces droits. Nous souhaitons partager ici plusieurs observations issues de notre pratique quotidienne à l'Académie Stella.

Notre premier commentaire porte sur la complexité intrinsèque du paysage institutionnel. Comme nous l'avons détaillé précédemment, il existe au Québec plus d'une douzaine d'instances différentes susceptibles de recevoir une plainte ou une insatisfaction en matière de santé et de services sociaux. Chacune de ces instances possède son propre mandat, ses propres critères de recevabilité, ses propres procédures, ses propres délais et son propre vocabulaire. Pour un professionnel aguerri, naviguer dans ce paysage exige déjà une attention soutenue. Pour un usager ordinaire, surtout lorsqu'il vit avec un trouble de santé mentale, cette complexité constitue un obstacle quasi insurmontable. La question apparemment simple « à qui dois-je m'adresser » n'admet pas de réponse simple, et cette absence de réponse claire décourage dès le départ un nombre important de personnes qui auraient pourtant des motifs légitimes d'insatisfaction.

Notre deuxième commentaire concerne la logique de segmentation qui préside à l'organisation des recours. Les instances sont segmentées selon la nature du service concerné, la profession du presta-

taire, le type de droit en cause et le type de réparation recherchée. Cette segmentation, qui reflète une logique administrative et juridique cohérente du point de vue du système, est profondément contre-intuitive du point de vue de l'utilisateur. Lorsqu'une personne a vécu une situation problématique, elle ne la vit pas comme un événement segmenté, mais comme une expérience globale. Une hospitalisation psychiatrique difficile peut comporter simultanément des aspects relevant du commissaire local, du médecin examinateur, de l'ordre des infirmières, de l'ordre des médecins, du Tribunal administratif du Québec, de la Commission des droits de la personne et, dans certains cas, d'une plainte criminelle. Demander à l'utilisateur de décomposer son expérience selon les catégories administratives du système pour emprunter le bon canal pour chaque aspect constitue une exigence qui ignore la réalité vécue des personnes concernées.

Notre troisième commentaire porte sur la qualité de l'information disponible pour s'orienter. L'information sur les recours existants est dispersée entre de multiples sources : sites web des établissements, site du ministère de la Santé et des Services sociaux, sites des ordres professionnels, site du Protecteur du citoyen, site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, documents papier remis à l'admission dans certains établissements, dépliants disponibles dans certains lieux publics. Cette dispersion fait qu'aucune source unique ne présente un portrait complet et à jour de l'ensemble des recours disponibles. De plus, l'information présentée sur chacun de ces sites est souvent rédigée dans un langage administratif ou juridique difficilement accessible, avec des termes comme « recevabilité », « compétence *ratione materiae* », « épuisement des recours préalables » ou « délai de prescription » qui n'ont aucun sens pour la plupart des usagers. Une personne qui tente de s'informer par elle-même se retrouve rapidement submergée par une masse d'informations partielles, parfois contradictoires, et souvent incompréhensibles.

Notre quatrième commentaire concerne les erreurs d'orientation et leurs conséquences. Une erreur dans le choix de l'instance n'est pas sans conséquence. Si une personne s'adresse à une instance qui n'est pas compétente pour sa situation, elle recevra généralement une réponse lui indiquant que sa plainte n'est pas recevable, sans nécessairement être clairement redirigée vers l'instance appropriée. Pendant ce temps, les délais de prescription peuvent continuer à courir, et la personne peut se retrouver forclosée dans son recours véritable. Nous avons vu des situations où des bénéficiaires avaient investi des semaines, voire des mois, à tenter de faire progresser une plainte auprès d'une instance qui n'était pas la bonne, pour finalement découvrir trop tard que le recours approprié n'était plus accessible. Ces situations sont particulièrement frustrantes et démoralisantes, et elles nourrissent chez les personnes concernées un sentiment durable de trahison par le système.

Notre cinquième commentaire porte sur la superposition et les chevauchements entre instances. Certaines situations peuvent relever simultanément de plusieurs instances, et il n'est pas toujours évident de comprendre comment ces instances interagissent entre elles. Une plainte concernant un médecin peut-elle être portée simultanément au commissaire local et au Collège des médecins ? La démarche auprès d'une instance suspend-elle les délais applicables aux autres ? L'échec d'une démarche interdit-il les démarches subséquentes ? Ces questions, qui relèvent de subtilités juridiques, ne sont pas clairement expliquées aux usagers, et leur méconnaissance peut compromettre l'efficacité des démarches entreprises. Nous consacrons une part importante de notre travail à clarifier ces questions pour nos bénéficiaires, mais il serait profondément souhaitable que le système lui-même rende cette information accessible et claire.

Notre sixième commentaire concerne l'inégalité dans l'accès à l'orientation. Les personnes qui disposent d'un réseau social étoffé, d'un capital culturel important, d'un accès à des professionnels de confiance ou à des ressources juridiques, ont beaucoup plus de chances de trouver rapidement la bonne instance que celles qui ne disposent pas de ces ressources. Or, la population que nous représentons compte précisément une forte proportion de personnes en situation d'isolement, de précarité économique et de faible capital culturel. La complexité du système de recours reproduit ainsi les inégalités sociales existantes, et confère aux plus vulnérables une double peine : ce sont eux qui ont le plus souvent des motifs légitimes de plainte, et ce sont eux qui ont le moins de moyens

pour les faire valoir.

Notre septième commentaire porte sur l'absence d'un guichet unique. Dans plusieurs pays et plusieurs juridictions, on a mis en place des guichets uniques en matière de plaintes, dont le rôle est de recevoir toute manifestation d'insatisfaction, d'analyser la situation et de rediriger la personne vers la ou les instances appropriées, tout en assurant un suivi de la démarche. Au Québec, un tel dispositif unifié n'existe pas. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services joue partiellement ce rôle pour les situations qui surviennent dans un établissement du réseau, mais son mandat ne s'étend pas aux plaintes concernant les professionnels en pratique privée, aux questions de discrimination, aux questions relatives au consentement aux soins ou à la protection des personnes inaptes. L'absence d'un guichet véritablement universel oblige l'utilisateur à comprendre par lui-même la nature juridique de sa situation avant même de pouvoir s'orienter, ce qui constitue une inversion problématique de la logique qui devrait prévaloir. Dans un système conçu du point de vue de l'utilisateur, c'est au système qu'il devrait revenir d'identifier la nature de la situation et d'assurer son orientation, et non à l'utilisateur de qualifier juridiquement son propre vécu.

Notre huitième commentaire concerne la variabilité de l'accueil réservé aux demandes d'information. Lorsque nos bénéficiaires tentent par eux-mêmes de s'orienter en contactant directement certaines instances, la qualité de l'accueil qu'ils reçoivent est très variable. Certaines instances offrent un accueil chaleureux, prennent le temps d'écouter la situation et redirigent activement la personne vers l'instance appropriée. D'autres se limitent à répondre que la situation ne relève pas de leur compétence, sans offrir d'orientation supplémentaire. Cette variabilité est particulièrement éprouvante pour nos bénéficiaires, qui peuvent vivre un refus d'accueil comme une nouvelle forme de rejet, s'ajoutant à l'expérience initiale qui motivait leur démarche. Certaines personnes, après deux ou trois tentatives infructueuses, renoncent purement et simplement à poursuivre, convaincues que personne ne les écoutera jamais.

Notre neuvième commentaire porte sur l'évolution des structures du réseau. Les réformes successives du réseau de la santé et des services sociaux au Québec ont modifié à plusieurs reprises les structures organisationnelles et, par conséquent, les circuits de plainte. La création des centres intégrés de santé et de services sociaux et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux a transformé le paysage institutionnel, et les usagers comme les intervenants peinent parfois à s'y retrouver. Les commissaires locaux, autrefois rattachés à des établissements relativement petits et identifiables, sont désormais rattachés à des organisations immenses couvrant de vastes territoires, ce qui complique l'identification de l'interlocuteur approprié. Les documents d'information disponibles ne sont pas toujours mis à jour au rythme de ces changements, et il n'est pas rare qu'une personne tente de joindre une structure qui a été fusionnée, renommée ou dissoute. Cette instabilité administrative constitue un obstacle supplémentaire à l'orientation des usagers.

Notre dixième commentaire concerne la dimension linguistique. Pour les personnes dont la langue première n'est ni le français ni l'anglais, l'accès à l'information sur les recours est considérablement plus difficile. Bien que plusieurs instances offrent des services dans quelques langues, la couverture linguistique demeure limitée, et l'information détaillée sur les procédures est rarement disponible dans les langues autochtones ou dans les langues des communautés immigrantes récentes. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'accès aux services téléphoniques d'information demeure parfois problématique malgré les dispositifs prévus à cet effet. Pour les personnes ayant un handicap cognitif ou un niveau de littératie limité, la rédaction même des documents d'information constitue un obstacle, car peu de matériel est disponible en langue simplifiée ou adaptée.

Notre onzième commentaire porte sur le temps nécessaire pour s'orienter. Même lorsqu'une personne finit par identifier l'instance appropriée, le processus d'orientation lui-même peut prendre des semaines, voire des mois, pendant lesquels la personne attend, cherche, hésite, abandonne, reprend, se décourage. Ce temps d'orientation s'ajoute aux délais de traitement de la plainte elle-même, et peut faire en sorte que plusieurs mois s'écoulent entre le moment où la situation problématique a été vécue et le moment où une démarche formelle est enfin engagée. Pour nos bénéficiaires, cette

durée est souvent incompatible avec leurs ressources psychiques et leurs impératifs de vie, et elle contribue directement au taux élevé d'abandon des démarches.

Notre douzième commentaire concerne la nécessité d'un accompagnement humain. Toutes les observations qui précèdent convergent vers un constat central : trouver la bonne instance pour porter plainte ou exprimer une insatisfaction est, dans l'état actuel du système québécois, une démarche qui exige pratiquement toujours un accompagnement humain pour nos bénéficiaires. Les outils d'information en ligne, les documents papier, les lignes téléphoniques générales, aussi bien conçus soient-ils, ne remplacent pas l'accompagnement par une personne qui connaît le système, qui prend le temps d'écouter la situation spécifique, qui valide l'expérience vécue, qui explique les options disponibles, qui aide à choisir la démarche appropriée et qui soutient la personne tout au long du processus. Cet accompagnement est précisément ce que nous offrons à l'Académie Stella, et c'est également ce qu'offrent les organismes communautaires de défense des droits en santé mentale, les comités des usagers, et certains intervenants particulièrement dévoués au sein du réseau. Mais la capacité collective de ces ressources d'accompagnement est très inférieure aux besoins réels de la population, ce qui signifie qu'un nombre considérable de personnes se retrouvent sans soutien au moment où elles en auraient le plus besoin.

Au final, notre principal constat est que la facilité de trouver la bonne instance pour porter plainte est, de manière paradoxale, inversement proportionnelle à la vulnérabilité de la personne concernée. Les personnes les mieux outillées, les plus informées, les mieux entourées, parviennent généralement à s'orienter efficacement, parfois avec un peu d'effort, mais sans obstacle insurmontable. Les personnes les plus vulnérables, au contraire, se heurtent à un mur institutionnel dont la complexité les dépasse, et dont la traversée exige précisément les ressources qui leur font défaut. Or, ce sont ces personnes vulnérables qui, statistiquement, ont le plus souvent des motifs de porter plainte, parce qu'elles sont celles dont les droits sont le plus fréquemment compromis. Le système actuel produit donc un résultat profondément inéquitable : les plaintes qui parviennent aux instances compétentes ne reflètent pas l'ensemble des situations problématiques réellement vécues, mais seulement celles qui ont été portées par les personnes ayant eu la capacité de franchir les obstacles d'orientation. Cette distorsion fausse la perception que le système a de son propre fonctionnement et empêche une véritable amélioration des pratiques dans les domaines où les atteintes aux droits sont les plus fréquentes.

Nous croyons fermement qu'une simplification radicale du paysage des recours, la mise en place d'un guichet véritablement universel, la production d'outils d'information adaptés à tous les niveaux de littératie et à toutes les situations linguistiques, et surtout un renforcement massif des ressources d'accompagnement indépendantes, constituent des conditions essentielles pour que le droit de porter plainte cesse d'être un droit théorique réservé aux mieux nantis et devienne un droit réellement exerçable par toutes les personnes qui en auraient besoin. Tant que ces transformations ne seront pas réalisées, la complexité du système de plaintes continuera de constituer, pour nos bénéficiaires, un obstacle au moins aussi important que les situations problématiques qui motivent initialement leurs démarches.

#32 • internet

Ça semble compliqué, pas facile à trouver et moins connu.

#34 • internet

C'est souvent difficile, car chaque institution a son formulaire et ses démarches particulières

#50 • internet

C'est à la personne de consulter quoi faire...

#62 • internet

Il peut être difficile pour plusieurs familles de comprendre les différentes instances du réseau et de

savoir vers qui se tourner pour exprimer une insatisfaction ou déposer une plainte.

Les démarches peuvent sembler complexes, particulièrement pour les familles déjà en situation de fatigue ou ayant un proche présentant des besoins importants. De plus, comme les services sont souvent difficiles à obtenir, certaines familles peuvent hésiter à porter plainte par crainte d'un impact négatif sur leur accès aux services ou leur relation avec les intervenants.

Une information plus simple, accessible et mieux centralisée, incluant les mécanismes confidentiels ou anonymes lorsque possibles, aiderait à rassurer les familles et à mieux faire connaître les recours disponibles.

#78 • internet

Nous n'avons pas accompagné de jeune dans une plainte ces dernières années, mais nous devrions nous informer au préalable pour trouver la bonne trajectoire. Nous n'avons pas de référent clair.

#83 • internet

Je n'en ai aucune idée moi-même donc j'espère que l'information est facile à trouver et sinon, ce serait à régler.

#85 • internet

Je réfère toujours au CAAP ; je n'ai pas d'information sur la meilleure instance selon le cas...

#106 • téléphone

Très difficile

#108 • téléphone

Très difficile, compliqué de trouver l'information et donc décourageant

#110 • téléphone

C'est très difficile même pour nous de trouver la bonne personne pour aider, il manque d'informations claires !

#111 • téléphone

C'est compliqué, il faut aller sur le site et ils demandent beaucoup de paperasse, c'est complexe et décourageant

#112 • téléphone

Je ne connais même pas le Comité des usagers donc on ne connaît même pas les instances qui peuvent aider

#115 • téléphone

Ce n'est pas facile c'est même compliqué pour nous

#116 • téléphone

Je ne connais pas le Comité des usagers

#117 • téléphone

Pas facile même pour nous en tant qu'organisme avec expérience

#119 • téléphone

C'est complexe même pour nous, imaginez les usagers !

#120 • téléphone

Ils doivent demander à des organismes comme nous pour les trouver

#123 • téléphone

C'est difficile dans le sens que cela ne vaut la peine d'investir de l'énergie là dedans

#124 • téléphone

L'utilisateur a vraiment besoin d'aide pour y arriver s'ils sont désorganisés ou en difficulté

#125 • téléphone

C'est difficile dans le réseau sur internet, même nous on se perd. Parler à un être humain c'est presque impossible. Il manque d'accessibilité

#127 • téléphone

C'est très difficile car il n'y a pas d'information centralisée pour les plaintes ou insatisfactions, ni leurs mandats respectifs pour aider les usagers ou même les organismes en cas de plainte

#128 • téléphone

Le roulement de personnel au CIUSS, donc pas de transition adéquate vers les différentes instances du CLSC qui peuvent aider

Dit que c'est clair/facile (n=5)

#0 • internet

Non, car nous sommes habitués.

#84 • internet

Pour moi pas vraiment mais pour un patient oui.

#94 • internet

- Sur internet, il est facile de trouver la bonne instance pour porter plainte et ce à l'aide de différentes langues.

-Par contre, il serait souhaitable d'afficher clairement la procédure à suivre dans les CLSC à des endroits ciblés accessible à la vue des usagers.

#122 • téléphone

Facile à trouver, pas facile à être dans ce système

#126 • téléphone

C'est assez clair, mais ce qui est difficile c'est de faire valoir sa plainte pour qu'elle soit retenue

Aucun renseignement / refus de répondre (n=4)

#1 • internet

Ne s'applique pas

#8 • internet

Nn.

#54 • internet

non.

#72 • internet

Non

non classable (n=5)

#7 • internet

none

#16 • internet

non

#26 • internet

NO n

#31 • internet

non

#60 • internet

Non

q16-Comment — 16. Avant aujourd’hui, aviez-vous déjà entendu parler de l’existence de Comités des usagers ou de résidents (CLSC, hôpitaux, CHSLD) de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal?

Question mère (q16) : Connaissait déjà les comités des usagers avant la consultation ?

Propriété annotée : *Quel est le niveau de connaissance de l’existence des Comités des usagers ?*

Résumé des catégories

4 catégories • 8 réponses (4 internet, 4 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Connaissance limitée	3	37.5%	2	1
Très faible connaissance	3	37.5%	0	3
Connaissance générale	1	12.5%	1	0
Connaissance précise locale	1	12.5%	1	0
Total	8		4	4

Connaissance limitée (n=3)

#12 • internet

Oui, mais peu

#65 • internet

Dur à dire, puisque notre organisation est spécialisée auprès des usagers sourds, malentendants et sourd aveugles, qui fréquentent souvent les CLSC, hôpitaux, CHSLD et centres de réadaptation.

Nous avons déjà entendu parler des Comités des usagers, mais il existe peu de ressources accessibles, de visibilité ou d’informations adaptées (sites web, communications, etc.). Cela peut rendre plus difficile l’accès aux informations, l’orientation vers les bonnes ressources et la compréhension des démarches disponibles.

#119 • téléphone

Nous les connaissons peu, car il manque de liens entre nous ! On ne les connaît pas assez

Très faible connaissance (n=3)

#111 • téléphone

rarement

#113 • téléphone

pas vraiment, on a pas les informations

#118 • téléphone

Très peu

Connaissance générale (n=1)

#4 • internet

Nous savons qu'il existe un comité d'usagers dans chaque secteur

Connaissance précise locale (n=1)

#94 • internet

Nous connaissons le CLSC, les hôpitaux et le CHSLD. Par contre, nous n'avions pas connaissance du Comité des usagers du CIUSSS de l'Est-de- l'Île-de-Montréal.

q17__1 — 17.1 Si oui, comment avez-vous trouvé l'expérience ?**Question mère (q17)** : Recours récent à un comité des usagers ?**Propriété annotée** : *Quel est le sentiment global exprimé envers l'expérience du Comité des usagers ?***Résumé des catégories**

3 catégories • 7 réponses (6 internet, 1 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Positif	3	42.9%	2	1
Négatif	2	28.6%	2	0
Très positif	2	28.6%	2	0
Total	7		6	1

Positif (n=3)

#5 • internet

Bien

#41 • internet

bonne

#105 • téléphone

Tout à fait correct on a eu le soutien demandé

Négatif (n=2)

#28 • internet

- échange d'informations

- souvent les comités sont tenus dans l'ignorance des événements dont le Conseil pour la protection des malades apprend et qu'il tente d'élucider

#77 • internet

pas claire et long comme processus

Très positif (n=2)

#0 • internet

Nous avons une très bonne expérience avec le comité d'usagers de l'IUSMM.

#18 • internet

Super !

q18__1 — Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations

Question mère (q18) : Les Comités des usagers ont un mandat qui leur est accordé par la loi et qui comporte plusieurs fonctions. Auriez-vous des suggestions ou des commentaires à formuler sur la façon dont les Comités des usagers peuvent remplir les fonctions suivantes ?

Propriété annotée : *quelles suggestions sont mentionnées pour renseigner les usagers ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 54 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Relayer via des partenaires communautaires	13	24.1%	NA	NA
Diffuser en ligne	11	20.4%	NA	NA
Méconnaissance / incertain	11	20.4%	NA	NA
Tenir des sessions en présentiel	8	14.8%	NA	NA
Adapter l'accessibilité	6	11.1%	NA	NA
Distribuer des documents imprimés	5	9.3%	NA	NA
Total	54		NA	NA

Relayer via des partenaires communautaires (n=13)

#15 •

Faire une tournée des groupes communautaires de leur territoire.

#18 •

faire circuler d'avantage l'information auprès des populations vulnérables

#24 •

Les Comités des usagers pourraient renforcer leur visibilité et leur accessibilité auprès des populations plus marginalisées ou en situation de vulnérabilité. Plusieurs usagers ne connaissent pas leurs droits ni l'existence de ces mécanismes de soutien.

Suggestions :

- utiliser un langage simple et accessible, avec des ressources multilingues
- être davantage présents dans les organismes communautaires, refuges, CLSC, hôpitaux et autres milieux fréquentés par les populations vulnérables
- offrir plus d'accompagnement concret pour aider les usagers à naviguer les plaintes et faire valoir leurs droits
- consulter directement les usagers sur leurs besoins et expériences
- poursuivre des efforts de sensibilisation auprès des institutions pour réduire la stigmatisation envers les personnes en situation de précarité, d'itinérance, de handicap, de neurodiversité ou de santé mentale

#25 •

Sassurer que tout les organismes de chiens d'assistance puissent renseigner sur leurs droits et leurs obligations

#28 •

L'Administration doit faciliter la diffusion de l'information que les comités tentent de faire tenir aux usagers, aux résidents et aux familles

#38 •

visiter les ressources communautaires pour transmettre l'information

#40 •

Organiser des rencontres dans les organismes communautaires dans la langue des usagers.

#49 •

Plus de liens avec les organismes pour diffuser information

#72 •

Envoyer de la documentation par courriel ou se présenter dans les org. comm. Ou informer les org. comm. directement

#88 •

Nous souhaitons contribuer avec les Comités des usagers d'abord à les sensibiliser à la situation particulière des personnes sourdes et prendre exemple sur les initiatives du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) et de son Programme Sourds.

#89 •

Faire la promotion dans les Associations de personnes atteintes via des webinaires, rejoindre les organismes communautaires (formations)

#107 •

Je ne savais pas, ni ma clientèle ne les connais. Ils faudrait qu'ils soient plus visible et ils devraient communiquer et afficher dans les organismes communautaires car on ne les connaît pas!

#108 •

Nous connaissons vaguement les comités des usagers, ce serait bien que les organismes communautaires soient mieux informés

Diffuser en ligne (n=11)

#17 •

Publicité, balados, etc

#26 •

Plus de publicité, séances d'information,.

#29 •

plus de publicité

#42 •

Idéalement, appeler les nouvelles familles pour prendre contact avec eux et se présenter. Et transmettre de la documentation aux familles via courriel ou la poste.

#53 •

Description clair et concise des droits

#85 •

Publications sur les réseaux sociaux, infolettes

#87 •

Diffusion des informations sur les droits

#92 •

Avoir des sources d'information claires et faciles d'accès

#93 •

Intégrer les renseignements de manière à les rendre accessibles lors de la prise d'une rendez-vous (mention et référence lorsqu'on appelle au 811 ou se connecte au GAP).

#94 •

-Multiplier les moyens de diffusion de l'information dans le but de rejoindre un plus grand nombre d'utilisateurs.

-Informez le plus rapidement possible les utilisateurs des changements concernant leurs droits et leurs obligations (s'il y en a).

-Rejoindre, deux fois par année, toutes les administrations des organismes communautaires, dans le but que les intervenants reçoivent l'information pertinente aux utilisateurs.

#99 •

Se faire plus connaître.

Méconnaissance / incertain (n=11)

#8 •

Beaucoup le font de moins en moins. Parfois par manque d'expertise.

#22 •

on n'entend pas vraiment parler

#36 •

Je ne connais pas assez le mandat en profondeur de ce comité des utilisateurs pour me prononcer.

#71 •

Ne sais pas

#83 •

Je ne sais pas

#97 •

Qui est responsable du comité des utilisateurs dans mon secteur ?

Comment puis-je contacter la personne responsable ?

Je n'ai pas d'ordinateur, qu'est-ce que je dois faire pour parler à quelqu'un ?

Je voudrais faire valoir mes droits face à une situation d'abus qui m'est arrivée lors d'un rendez-vous. Suis-je en droit de faire une plainte ? Et comment ?

#100 •

Oui

#103 •

Je ne connais pas assez les fonctions des Comités pour me prononcer sur leur performance

#106 •

Bien fait

#110 •

Il y a faire parceque la clientèle n'est pas au courant

#123 •

Le terme n'est pas clair : Comité des usagers on ne comprend pas bien leur mission et Comité de défense des droits des usagers. On dirait que ça pourrait même être pour des comités de loisirs

Tenir des sessions en présentiel (n=8)

#7 •

Le comité pourrait offrir davantage d'information simple et accessible, notamment par des brochures multilingues, des ateliers d'information et des rencontres dans les organismes communautaires

#21 •

Il serait bien d'offrir des sessions d'informations sur les droits, mais par clientèles/programmes.

#54 •

Décentraliser l'information. Les Comités gagneraient à sortir des murs du CIUSSS pour aller là où les usagers passent du temps de qualité, comme dans les centres de jour communautaires. Par exemple, animer de courtes causeries informelles ou fournir des outils visuels simplifiés (grandes affiches, fiches synthèse) conçus spécifiquement pour les proches aidants fatigués.

#58 •

les informer lors des rendez-vous

#60 •

Oui, le comité pourrait faire des présentations dans les organismes communautaires afin de se faire connaître

#61 •

Faire des présentations et laisser des dépliants. encourager les discussions et l'accessibilité facile.

#79 •

faire un peu plus de sensibilisation et d'information comme des kiosques

#81 •

Documentation, conférences,...

Adapter l'accessibilité (n=6)

#5 •

Qu'ils soit informés sur leurs droits mais également ceux des autres. Que la liberté de un s'arrête là

où celle des autres débute.

#59 •

dans plusieurs langues

#62 •

Continuer à offrir une information simple, claire et accessible aux usagers et à leurs familles concernant leurs droits, les ressources disponibles et les recours possibles au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

#65 •

Les Comités des usagers pourraient améliorer la diffusion d'informations accessibles et adaptées aux différents besoins de communication des usagers. Une meilleure visibilité des droits, des démarches possibles et des ressources disponibles aiderait les usagers à mieux comprendre leurs obligations et à exercer leurs droits plus facilement.

Il serait également important de développer des outils accessibles, comme des capsules vidéo avec une voix claire, des sous-titres et des interprétations en langue des signes, afin de mieux rejoindre les personnes sourdes, malentendantes et sourd aveugles. Une meilleure sensibilisation dans les milieux de santé et de services sociaux permettrait aussi de mieux soutenir les personnes plus vulnérables ou isolées.

#68 •

Vulgariser et imager les informations

#125 •

Rendre l'information plus accessible

Distribuer des documents imprimés (n=5)

#50 •

Peut-être remettre une simple description de ce qui est à faire aux usagers à leur arrivée.

#77 •

donner des exemples faciles sur pourquoi porter plainte

#84 •

Distribuer pamphlet.

#95 •

Fiches informatives offertes aux parents sur l'éventail des services offerts par le CLSC

#127 •

Prendre d'autres moyens que le WEB, plusieurs sont allophones, presque illétrés, ça serait important de fournir les feuillets de défense des droits aux maisons de transition et organismes communautaires pour être affichés et dépliants simples à lire et à comprendre. Mettre à jour vos informations pour que les contacts soient bons.

q18__2 — Promouvoir l'amélioration de la qualité de leurs conditions de vie

Question mère (q18) : Les Comités des usagers ont un mandat qui leur est accordé par la loi et qui comporte plusieurs fonctions. Auriez-vous des suggestions ou des commentaires à formuler sur la façon dont les Comités des usagers peuvent remplir les fonctions suivantes ?

Propriété annotée : *quelles suggestions mentionnées pour promouvoir l'amélioration ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 34 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Consulter et faire participer les usagers	8	23.5%	NA	NA
Informar, former, promouvoir la santé	6	17.6%	NA	NA
Assurer la transparence / rendre compte	4	11.8%	NA	NA
Faire respecter les lois et la qualité des soins	2	5.9%	NA	NA
Plaider auprès des instances politiques	2	5.9%	NA	NA
Renforcer les moyens (personnel/financement)	2	5.9%	NA	NA
non classable	10	29.4%	NA	NA
Total	34		NA	NA

Consulter et faire participer les usagers (n=8)

#7 •

Il serait utile de consulter régulièrement les usagers afin de mieux comprendre leurs besoins réels et d'identifier les problèmes récurrents dans les services.

#21 •

Malheureusement depuis la création des CIUSSS, les comités d'usagers n'ont pas autant de voix qu'auparavant. Il serait pertinent d'avoir des rencontres mensuelles avec les administrations pour discuter de problèmes/difficultés constatés.

#26 •

Consulter les usagers afin d'avoir leurs avis.

#40 •

Organiser des rencontres dans les organismes communautaires dans la langue des usagers.

#42 •

Porter la voix des usagers...mais surtout avoir un impact réel sur le terrain. Donnez leur un pouvoir d'action réel.

#62 •

Continuer à demeurer à l'écoute des besoins réels des usagers et des familles afin de contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie et de leur expérience au sein du réseau.

#85 •

Sondage auprès des usagers et des groupes communautaires

#94 •

-Prendre en considération et agir favorablement, selon les commentaires et suggestions des usagers eux-mêmes.

-Poursuivre les sondages comme celui-ci dans le but d'améliorer les services et ainsi la qualité des conditions de vie de nos usagers.

Informier, former, promouvoir la santé (n=6)

#17 •

Promouvoir votre ouverture face aux différences

#33 •

Faire un travail de lutte à la stigmatisation.

Sensibilisation des professionnels au masquage diagnostique

#65 •

Les Comités des usagers pourraient contribuer à l'amélioration des conditions de vie en favorisant des services plus accessibles, inclusifs et adaptés aux besoins réels des usagers. Il serait important de mieux tenir compte des différentes réalités vécues, notamment celles des personnes sourdes, malentendantes et sourd aveugles.

Le développement d'outils accessibles, comme des capsules vidéo avec sous-titres, voix claire et langue des signes, pourrait également améliorer l'accès à l'information, l'autonomie et la participation des usagers dans leur parcours de soins et de services.

#84 •

Distribuer pamphlet.

#88 •

Un programme de promotion de la santé est essentiel. Vous référer au REFIPS (refips.org)

#93 •

Offrir des conférences ou formations en ligne offertes au grand public.

Assurer la transparence / rendre compte (n=4)

#15 •

Publier des rapports annuel du comité : sur quels enjeux ont-ils été sollicités, à propos de quoi auraient-ils voulu s'exprimer, qu'est-ce qui facilite ou rend difficile (voir impossible) leur rôle.

#53 •

Information concise

#58 •

sondage, infolettre

#97 •

Beaucoup de personnes ne savent pas tous ce qui est offert pour leur venir en aide dans notre quartier.

Faire respecter les lois et la qualité des soins (n=2)

#28 •

Les administrations doivent respecter les Lois et surtout s'assurer qu'elles prodiguent les soins prévus aux dites lois, des soins qui soient dignes et adéquats

#59 •

Elles n'ont pas accès quand elles attendent de clarifier leur statut

Plaider auprès des instances politiques (n=2)

#68 •

Effectuer des pressions politiques pour diminuer le cout de la vie.

#89 •

Favoriser l'accès aux services

Renforcer les moyens (personnel/financement) (n=2)

#29 •

plus de moyens humains et financiers

#100 •

Tout le monde veut améliorer la qualité de vie, mais il faut mettre les services en place pour le faire et non les couper. Plus de soins pour les personnes trans et de meilleur formation devrait aider pour cette communauté.

non classable (n=10)

#5 •

Je ne sais pas

#25 •

-

#36 •

Je ne connais pas assez le mandat en profondeur de ce comité des usagers pour me prononcer.

#50 •

Cela est un choix personnel et intime

#60 •

Sans objet

#71 •

Ne sais pas

#72 •

Ne sait pas

#83 •

Je ne sais pas

#95 •

Non

#103 •

Je ne connais pas assez les fonctions des Comités pour me prononcer sur leur performance

q18__3 — Participer à l'évaluation de leur degré de satisfaction par rapport aux services obtenus de l'établissement

Question mère (q18) : Les Comités des usagers ont un mandat qui leur est accordé par la loi et qui comporte plusieurs fonctions. Auriez-vous des suggestions ou des commentaires à formuler sur la façon dont les Comités des usagers peuvent remplir les fonctions suivantes ?

Propriété annotée : *quelles suggestions mentionnées pour évaluer la satisfaction ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 38 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Sonder / administrer un questionnaire	11	28.9%	NA	NA
Adapter les modalités	8	21.1%	NA	NA
Exige rigueur professionnelle / critique méthodologique	4	10.5%	NA	NA
Assurer un suivi longitudinal	3	7.9%	NA	NA
Mener une approche qualitative	1	2.6%	NA	NA
non classable	11	28.9%	NA	NA
Total	38		NA	NA

Sonder / administrer un questionnaire (n=11)

#17 •

Sondage

#18 •

envoyer un sondage

#26 •

Sondage de satisfaction anonyme.

#38 •

A travers des sondages

#42 •

Envoyer des sondages électronique et de vive voix...si vous prenez le temps de sonder, les résultats parleront d'eux même.

#53 •

question courte

#58 •

questionnaire anonyme

#87 •

Sondages

#92 •

Sondage de satisfaction (papier et virtuel) et entretiens qualitatifs

#95 •

Sondage aux usagers

#126 •

Ce serait bien de mettre en place un système d'évaluation de la satisfaction des usagers, AVANT que cela ne devienne une plainte

Adapter les modalités (n=8)

#7 •

Des sondages simples, anonymes et disponibles en plusieurs langues pourraient encourager davantage de personnes à partager leur expérience et leurs préoccupations.

#29 •

formulaire à disposition en ligne et papier

#40 •

Organiser des rencontres dans les organismes communautaires dans la langue des usagers.

#62 •

Favoriser des mécanismes de consultation simples et accessibles permettant aux usagers et aux familles d'exprimer leur satisfaction, leurs préoccupations et leurs besoins de façon respectueuse et constructive.

#77 •

Ils pourrait être davantage en lien avec les tables de quartier ou les organisateurs communautaire, ils sont loin de la communauté et complètement déconnecté du public

#88 •

Sondage adapté en LSQ

#93 •

Envoyer par courriel ou remplir avec l'utilisateur au téléphone un formulaire pour évaluer leur satisfaction suite à un rendez-vous.

#123 •

Un questionnaire papier avec les aînés pendant les RDV

Exige rigueur professionnelle / critique méthodologique (n=4)

#21 •

avoir des questionnaires anonymes sur la qualité de vie des résidents et des services rendues. Mais cela voudrait dire qu'il faudrait demander des questions explicites dans ses questionnaires.

Il serait pertinent de faire des évaluations d'efficacité des services.

#28 •

Cet exercice relève et requiert une assise professionnelles afin qu'elle donne des résultats significatifs,

ce qui malheureusement ne se fait pas

#50 •

Comprendre que depuis la loi 21 en 2012, de très bons thérapeutes s'abstiennent certains actes thérapeutiques de crainte d'être investigués et confrontés par l'OPQ

#100 •

Faire des évaluations pourraient être bien afin de voir où sont les problèmes et les bons coups. Il a de bonnes et ça vaut la peine aussi de les voir

Assurer un suivi longitudinal (n=3)

#68 •

Systématiser les évaluations après chaque suivi

#76 •

Peut-être assurer un suivi à plus long terme de leur degré de satisfaction. L'évaluation du degré de satisfaction peut être changée à plus ou moins long terme.

#97 •

Les personnes qui ont obtenu des services sont satisfaits des résultats. Même si elles ont attendu longtemps une fois qu'elles ont été pris en charge elles obtiennent de l'aide.

Mener une approche qualitative (n=1)

#54 •

Privilégier les approches qualitatives et humaines. Au lieu des questionnaires impersonnels, le Comité pourrait organiser des "groupes de discussion" (focus groups) mobiles au sein même des organismes partenaires. Les usagers s'expriment beaucoup plus librement autour d'une table avec une oreille attentive qu'en cochant des cases sur un formulaire.

non classable (n=11)

#5 •

Je ne sais pas

#25 •

-

#36 •

Je ne connais pas assez le mandat en profondeur de ce comité des usagers pour me prononcer.

#60 •

Sant objet

#71 •

Ne sais pas

#72 •

Ne sait pas

#83 •

Je ne sais pas

#85 •

-

#89 •

Ne sais pas

#94 •

-Voir les réponses précédentes.

#103 •

Je ne connais pas assez les fonctions des Comités pour me prononcer sur leur performance

q18__4 — Défendre leurs droits et leurs intérêts collectifs

Question mère (q18) : Les Comités des usagers ont un mandat qui leur est accordé par la loi et qui comporte plusieurs fonctions. Auriez-vous des suggestions ou des commentaires à formuler sur la façon dont les Comités des usagers peuvent remplir les fonctions suivantes ?

Propriété annotée : *quelles suggestions mentionnées pour mieux défendre les droits ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 34 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Incertitude / manque d'information	12	35.3%	NA	NA
Accroître la visibilité / informer le public	5	14.7%	NA	NA
Assurer l'accessibilité et le contact direct	5	14.7%	NA	NA
Collaborer avec des partenaires	5	14.7%	NA	NA
Actions ciblées vers communautés/linguistique	3	8.8%	NA	NA
Renforcer le pouvoir d'action du comité	3	8.8%	NA	NA
non classable	1	2.9%	NA	NA
Total	34		NA	NA

Incertitude / manque d'information (n=12)

#5 •

Je ne sais pas

#21 •

Les membres de comités d'usagers ont souvent peur de dénoncer ouvertement des difficultés/problèmes constatés avec des administrations par crainte de représailles envers leur membre de famille vulnérable.

#36 •

Je ne connais pas assez le mandat en profondeur de ce comité des usagers pour me prononcer.

#53 •

Les questionnés sur leur perception

#59 •

serait bien utile mais pas accessible.

#71 •

Ne sais pas

#77 •

Meme chose

#83 •

Je ne sais pas

#89 •

Ne sais pas

#94 •

-Voir les réponses précédentes.

#100 •

Oui

#103 •

Je ne connais pas assez les fonctions des Comités pour me prononcer sur leur performance

Accroître la visibilité / informer le public (n=5)

#54 •

Démystifier le rôle d'accompagnateur. Le Comité doit se faire connaître comme un allié bienveillant et non comme une instance juridique intimidante. Il serait pertinent de promouvoir des exemples de réussites (ex. : comment une intervention du comité a permis de rétablir des heures de soutien à domicile) pour donner confiance aux usagers et briser la peur de porter plainte.

#58 •

les informer sur leur droit, mettre en place des comités et informé les usagers

#62 •

Sensibiliser les établissements aux réalités vécues par les usagers et leurs familles, particulièrement pour les personnes ayant des besoins plus complexes.

#72 •

Envoyer de la documentation par courriel ou se présenter dans les org. comm.

#93 •

En rendant le comité plus accessible par plus de visibilité et un moyen clair et simple d'entrer en contact avec celui-ci.

Assurer l'accessibilité et le contact direct (n=5)

#29 •

service de médiation

#33 •

Offrir accompagnement

#68 •

Simplifier le processus de plainte

#79 •

peut être sonder les utilisateurs de vos services, un comité de consultation pour aller voir c'est quoi les besoins des usagers

#97 •

Il est très important de faire connaître à la population les services qui sont offerts. Avoir la possibilité

de parler à une personne ressource, soit en téléphonant ou en ayant une adresse courriel.

Collaborer avec des partenaires (n=5)

#15 •

créer des solidarités avec le milieu communautaire, mais aussi les travailleuses du réseau de la santé.

#25 •

Sassurer que tout les organismes de chiens d'assistance puissent défendre les intérêts de leur usagers avant leur propre intérêt

#85 •

Collaborer avec les organismes de défense des droits des usagers

#87 •

Collaborer étroitement avec les groupes communautaires

#88 •

Encourager et financer un projet sourds santé qui répondrait à la fois au problème d'accès mais aussi à l'action citoyenne dans le domaine.

Actions ciblées vers communautés/linguistique (n=3)

#7 •

Le comité pourrait renforcer sa présence dans les communautés culturelles et auprès des nouveaux arrivants afin de mieux faire connaître son rôle et d'identifier les enjeux vécus par différents groupes d'usagers

#17 •

Ouverture aux différences

#40 •

Organiser des rencontres dans les organismes communautaires dans la langue des usagers.

Renforcer le pouvoir d'action du comité (n=3)

#26 •

Veiller à ce que le personnel fait son travail. Si un employé rapporte une situation de négligence aux travail, se donner le droit d'évaluer la situation et poser l'action juste.

#28 •

C'est le rôle le plus important et c'est pourquoi le concept de comité de bénéficiaire fut inséré dans la Loi au début des années 70.

L'administration doit connaître ce rôle et respecter l'autonomie des comités dans l'exercice de leur rôle

#42 •

Porter la voix des usagers...mais surtout avoir un impact réel sur le terrain. Donnez leur un pouvoir d'action réel.

non classable (n=1)

#60 •

Sans objet

q18__5 — À la demande d'une personne, défendre ses droits et ses intérêts en tant qu'utilisateur(-ère) ou résident(e) auprès de toute autorité compétente

Question mère (q18) : Les Comités des usagers ont un mandat qui leur est accordé par la loi et qui comporte plusieurs fonctions. Auriez-vous des suggestions ou des commentaires à formuler sur la façon dont les Comités des usagers peuvent remplir les fonctions suivantes ?

Propriété annotée : *quelles suggestions pour mieux défendre les droits ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 28 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Accompagner individuellement	11	39.3%	NA	NA
Ne sait pas / sans objet	7	25.0%	NA	NA
Informé / sensibiliser	3	10.7%	NA	NA
Renforcer les comités	3	10.7%	NA	NA
Questionner / contrôler les intervenants	2	7.1%	NA	NA
Obligation des professionnels	1	3.6%	NA	NA
non classable	1	3.6%	NA	NA
Total	28		NA	NA

Accompagner individuellement (n=11)

#17 •

Avoir une personne non-rémunéré par les CIUSSS

#26 •

Accompagner la personne dans le processus. Lui donner l'information et le soutien nécessaire.

#40 •

Accompagnement, référence, information

#42 •

Avoir accès à des traducteurs, accompagner la personne pour lui simplifier la tâche, etc.

#68 •

Offrir un accompagnement personnalisé

#77 •

l'accompagnement dans la démarche quand la personne le requiert et lui faire part des résultats de sa plainte.

#87 •

Accompagnement

#92 •

Offrir de l'accompagnement individuel aux personnes qui cherchent à défendre leurs droits et intérêts

#93 •

En guidant pas à pas la personne dans les démarches et en l'accompagnant au besoin pour aider à exprimer le problème rencontré pour formuler une plainte, par exemple.

#97 •

Expliquer les démarches et procédures à la personne qui se sent lésé dans ses droits en tant qu'usager. Accompagner cette personne tout au long de sa démarche.

#100 •

Parfois les patients ne savent pas où aller pour défendre leur droit et comment le faire. Les aider à les défendre aux bons endroits serait bien.

Ne sait pas / sans objet (n=7)

#5 •

Je ne sais pas

#36 •

Je ne connais pas assez le mandat en profondeur de ce comité des usagers pour me prononcer.

#60 •

Sans objet

#71 •

Ne sais pas

#83 •

Je ne sais pas

#89 •

Ne sais pas

#103 •

Je ne connais pas assez les fonctions des Comités pour me prononcer sur leur performance

Informier / sensibiliser (n=3)

#25 •

C'est primordiale dans le domaine de la santé mentale

#88 •

Sensibiliser les usagers à l'existence des mécanismes leur permettant de contester ou de faire des représentations auprès des autorités compétentes par l'entremise d'une plateforme Sourds Santé.

#94 •

-Informier la personne des étapes des actions qui seront prises.

-S'assurer que la personne a une mise jour, régulièrement, par rapport aux interventions qui ont été complétées.

Renforcer les comités (n=3)

#8 •

Il devrait y avoir plus d'accompagnement individuel des comités des usagers. Les comités des usagers le font jusqu'ici de moins en moins.

#21 •

Il faut que les membres des comités d'usagers soient bien informés des droits d'usagers et n'aient pas peur de représailles.

#29 •

prise en charge par l'aide juridique, OBNL dédiée

Questionner / contrôler les intervenants (n=2)

#22 •

Tout le monde se lance la balle et on arrive à rien à la fin

#53 •

questionner les intervenants autour de la personne

Obligation des professionnels (n=1)

#72 •

Est-ce que le TS/ergo... pourraient avoir l'obligation de faire connaître cette possibilité aux personnes ???

non classable (n=1)

#85 •

-

q18__6 — Accompagner et assister tout(e) usager(-ère) ou résident(e) dans toute démarche, y compris pour formuler une plainte

Question mère (q18) : Les Comités des usagers ont un mandat qui leur est accordé par la loi et qui comporte plusieurs fonctions. Auriez-vous des suggestions ou des commentaires à formuler sur la façon dont les Comités des usagers peuvent remplir les fonctions suivantes ?

Propriété annotée : *quelles suggestions pour mieux accompagner les usagers ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 31 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Indécis/aucune précision	11	35.5%	NA	NA
Informé / expliquer	5	16.1%	NA	NA
Soutenir personnellement	5	16.1%	NA	NA
Renforcer les organismes	3	9.7%	NA	NA
Accompagnement pair-aidant/indépendant	2	6.5%	NA	NA
Aider concrètement (formulaires/représentation)	2	6.5%	NA	NA
non classable	3	9.7%	NA	NA
Total	31		NA	NA

Indécis/aucune précision (n=11)

#5 •

Je ne sais pas

#8 •

Idem réponse précédente

#36 •

Je ne connais pas assez le mandat en profondeur de ce comité des usagers pour me prononcer.

#42 •

Absolument !

#59 •

oui mais pas possible pour les raisons déjà mentionnées

#71 •

Ne sais pas

#83 •

Je ne sais pas

#87 •

d'accord

#94 •

-Voir les réponses précédentes

#103 •

Je ne connais pas assez les fonctions des Comités pour me prononcer sur leur performance

#105 •

Ça ils le font bien

Informier / expliquer (n=5)

#18 •

expliquer les étapes de la démarche avant le début du processus

#21 •

Le manque d'information/connaissance demeure un point à travailler.

#40 •

Accompagnement, référence, information

#88 •

Campagne de sensibilisation adaptée portant sur les droits des usagers.

#95 •

Il est important que les familles ne parlant pas français ou anglais ait accès à des traducteurs

Soutenir personnellement (n=5)

#7 •

Le comité pourrait proposer davantage de soutien personnalisé, notamment avec l'aide d'interprètes ou de médiateurs culturels lorsque la langue représente un obstacle.

#68 •

Offrir un accompagnement personnalisé

#92 •

Offrir de l'accompagnement individuel aux personnes qui cherchent à défendre leurs droits et intérêts

#97 •

Il est très important que l'utilisateur se sente en confiance avec la personne ressource. Que l'aide soit faite de façon respectable, avec un sentiment de confiance, de confidentialité.

#100 •

Les aider et les mettre en confiance pour faire des plaintes

Renforcer les organismes (n=3)

#25 •

Offrir des formations obligatoires aux organismes aidants ... droits de la personne, code civil, etc...

#29 •

OBNL dédiée

#72 •

Informers les org. comm. des moyens

Accompagnement pair-aidant/indépendant (n=2)

#17 •

Par une personne non-rémunérée par les CIUSSS

#76 •

Proposer que ces démarches soient réalisées avec l'accompagnement d'un.e pair.e aidant.e.

Aider concrètement (formulaires/représentation) (n=2)

#53 •

c'est difficile puisque ce n'est pas nous qui devons faire la plainte mais l'utilisateur. Souvent, la personne va se décourager avant.

#93 •

Une aide concrète pour remplir des formulaires ou discuter de son cas avec les instances concernées.

non classable (n=3)

#60 •

Sans objet

#85 •

-

#89 •

Réponses précédentes

q19 — 19. Auriez-vous des suggestions afin que votre organisme puisse davantage collaborer avec les Comités des usagers de l'Est-de-l'Île-de-Montréal?

Propriété annotée : *quelles suggestions mentionnées pour plus de collaboration ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 52 réponses (NA internet, NA téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Organiser des rencontres ou ateliers	20	38.5%	NA	NA
Communiquer / transmettre de l'information	15	28.8%	NA	NA
Désigner une personne-ressource	5	9.6%	NA	NA
Déjà collaborent / satisfaction	4	7.7%	NA	NA
Barrières ou manque de disponibilité	3	5.8%	NA	NA
non classable	5	9.6%	NA	NA
Total	52		NA	NA

Organiser des rencontres ou ateliers (n=20)

#7 •

Nous aimerions développer une meilleure communication entre le comité des usagers et les organismes communautaires, organiser des rencontres d'information communes et partager plus régulièrement les ressources disponibles pour les usagers.

#28 •

- rechercher et offrir aux membres des comités diverses formations offertes par le Conseil pour la protection des malades sur divers thèmes :

NOUVEAU : L'action des comités dans les médias, le pouvoir d'agir et ses limites (Me Paul G. Brunet)

NOUVEAU : Les niveaux de soins attendus en CHSLD, MDA et MA (Me Paul G. Brunet)

Pour un examen de la Directive du CNU du 12 décembre 2025 sur les CUÉ (Me Paul G. Brunet)

Un document qui remplace le Cadre de référence des comités des usagers et de résidents produit par le MSSS en 2018, avec ses limites.

LES 30 DROITS DES USAGERS, EN HÔPITAL, EN CHSLD ET DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ EN GÉNÉRAL (ME PAUL G. BRUNET)

Un aperçu des droits en cause, des principaux griefs rencontrés et des recours.

L'INTIMIDATION, LES REPRÉSAILLES (ME PAUL G. BRUNET)

Le phénomène, son identification ; les symptômes, sa présence dans un lieu d'hébergement.

Projet de loi 15, PROJET DE LOI 106, LOI 2, réforme Dubé ET LA SUITE, un aperçu pour les comités affiliés (Me Paul G. Brunet)

Un bref retour sur l'état des dispositions des projets de loi qui se sont succédé quant aux droits des usagers et au fonctionnement des comités d'usagers et de résidents.

Le vrai rôle d'un comité d'usagers ou de résidents (Me Paul G. Brunet)

On y décrit le rôle tel qu'inscrit dans la loi et dans la littérature, et non celui que certains voudraient bien qu'il joue.

Les pratiques d'intervention directe en CHSLD (Me Paul G. Brunet)

Comment se présenter, informer les autorités du rôle que le comité et ses membres entendent jouer au sein de l'établissement et auprès de l'Administration, dans le respect de la loi et de l'autorité, mais jamais avec complaisance.

Pourquoi, comment : l'alternative des caméras en CHSLD (Me Paul G. Brunet)

Une solution extrême, souvent en désespoir de cause, face à l'inaction et l'absence de suivi de demandes ou de plaintes des usagers ou de leurs familles.

Le droit à demander l'aide médicale à mourir et surtout le droit d'être soigné et traité dignement (Me Paul G. Brunet)

Les situations d'application, les conditions et la collaboration obligée de l'Administration et du personnel soignant.

La confidentialité du dossier d'un usager (Me Paul G. Brunet)

C'est le droit pour l'usager d'exiger que ne soient pas divulgués, sans son consentement, les renseignements sur sa santé, consignés à son dossier.

Les formations peuvent se donner en présentiel ou en virtuel et le nombre limite de participants pour chaque formation est de 50 personnes.

#36 •

Que ce comité se fasse plus visible, notamment en venant présenter ces services aux organismes communautaire de leur territoire.

#40 •

Organiser des rencontres dans les organismes communautaires dans la langue des usagers.

#42 •

Être plus actif dans le milieu de la DITSA de Montréal, sur les tables, les comités, les journées thématiques, etc. Contacter les organismes pour se faire connaître et créer le lien de confiance avec ceux-ci pour y référer des membres.

#54 •

Pour maximiser la collaboration dans l'Est-de-l'Île, nous suggérons de créer des maillages de proximité : inviter le Comité à tenir des cliniques d'information mobiles dans nos centres de jour, identifier un répondant pivot pour faciliter les références rapides en cas de crise, et inclure leurs outils d'information dans nos trousseaux d'accueil destinées aux familles et proches aidants.

#60 •

Oui, prévoir une première rencontre

#72 •

Ne sait pas, mais on aimerait bien les rencontrer.

#77 •

se rapprocher des organisateurs communautaire ou table de quartier

#79 •

venir former les intervenants et acteurs du milieu communautaires sur vos démarches et service à la table de concertation

#88 •

Oui, nous lançons un sondage portant sur l'accessibilité des personnes sourdes et malentendants à nos services de santé. Il s'agit d'une pré-recherche qui mènera à une recherche élargie menant à combler les obstacles de communication par divers dispositifs technologiques, humains et organisationnels

#89 •

Offrir des webinaires, des formations

#97 •

Avoir la possibilité d'avoir des ateliers d'informations auprès du public : c'est quoi le comité des usagers? Comment je peux demander de l'aide? Où? Existe-t'il un numéro de téléphone, une adresse courriel? Est-ce que je serai bien accueilli, la confidentialité.

#110 •

Il devrait y avoir des présentations des services des comités des usagers des CLSC locaux, et de la documentation aux tables de concertation dans Hochelaga. Les organismes communautaires ne sont pas vraiment au courant des services offerts par les Comités des usagers

#114 •

Ce qui serait intéressant c'est que les Comités des usagers rencontrent la table de quartier pour expliquer leur mandat et donner de l'information au milieu communautaire

#117 •

On les connaît peu. Ce serait pertinent d'avoir une représentation soit à la table de quartier ou dans un souper communautaire ou dans une réunion d'équipe pour présenter leurs services. Je ne pense pas que les formats papiers soient efficaces auprès des jeunes, il faut penser soit au présentiel soit à une application.

#119 •

Des rencontres et des liens avec les organismes communautaires. Il devrait y avoir des rencontres en présentiel, dans les tables de quartiers, présenter leurs mandats dans les réunions d'équipe...

#123 •

Le communautaire est ouvert aux collaborations et pour se connaître car notre organisme ne connaissais pas du tout les comités des usagers. Ça pourrait passer par le CLSC ou une rencontre annuelle

#125 •

Le Comité des usagers essaie de se rapprocher du milieu communautaire par des présentations dans les organismes ou des rencontres. Si les organismes communautaires connaissent mieux les Comités ils pourront mieux informer les usagers qui en auraient besoin

#126 •

Un Atelier proposé pour nos membres pour mieux connaître les services par les comités des usagers

Communiquer / transmettre de l'information (n=15)

#8 •

Contactez-nous (Pardi, Parents pour la déficience intellectuelle). On pourra en discuter.

#16 •

Nous devrions en connaître davantage sur ce comité

#24 •

Une meilleure communication entre les Comités des usagers et les organismes communautaires serait utile. Par exemple :

- mieux faire connaître leur rôle et leurs services
 - établir des personnes-ressources claires pour les références
 - offrir des séances d'information aux organismes communautaires
 - créer davantage d'espaces de collaboration ou de concertation avec les organismes terrain qui accompagnent les usagers au quotidien
-

#25 •

Reconnaitre le travail et le devouement de celle-ci et d'inclure son étude et son rôle sur le sujet des chiens d'assistance en santé mental.

#47 •

Affiche sur comment rejoindre, à qui parler, accès direct vu que nous sommes un OBNL.

#58 •

être sur le comité, recevoir des infolettre

#62 •

Une meilleure connaissance mutuelle des services offerts et un partage d'information occasionnel pourraient favoriser l'orientation des familles vers les bonnes ressources selon leurs besoins.

#71 •

Mieux faire connaître le rôle du Comité des usagers

#100 •

Être mis au courant, le courriel que nous avons reçu est un bon début

#103 •

La LDL concentre son intervention sur les projets de loi, les politiques publiques, avec un angle du droit à la santé. Nous éclairons nos analyses à partir des obligations du Québec et du Canada à l'international, en regard des droits humains. Nous pourrions collaborer de temps à autre pour permettre à ce cadre de référence de parvenir aux usagers.

#105 •

Nous rappeler leur existence plus souvent afin que nos équipes soient au courant de leurs services, avec des courriels, appels, dépliants...

#111 •

Cela devrait être publicisé car je ne le savais pas, ni ma clientèle. Il faudrait que les comités envoie l'information aux organismes communautaires. Il devrait y avoir une personne mandatée du Comités pour informer les organismes communautaires et leurs usagers de leur existence et de leurs services. Envois de dépliants clairs sur leurs mandats, rencontres sur tables de concertations

#112 •

Les mandats sont bons, mais on en a jamais entendu parler, il faudrait que les comités fasse le tour des organismes communautaires, dépliants, email, en personne etc... pour nous informer.

#115 •

Le mandat des comités des usagers est très intéressant ! Je ne vous connaissais pas, il nous faudrait avoir ces informations et nous pourrions alors référer certains de nos usagers en cas de besoin.

#127 •

Que les comités nous envoie la documentation à jour

Désigner une personne-ressource (n=5)

#85 •

Grâce à votre sondage je saurai que je peux vous communiquer et vous référer des usagers. Sinon, ce serait super d'avoir le nom et le contact d'une ou des personnes à contacter dans le futur.

#93 •

Un représentant pourrait éventuellement entrer en contact avec la direction pour expliquer les services offerts de part et d'autres et envisager une rencontre de style questions réponses avec les usagers si jugé pertinent.

#94 •

-Obtenir le nom et les coordonnées d'une personne ressource que nous pouvons contacter dans le but d'établir un lien et une collaboration.

#101 •

contactez nous : directionadjointe@cjsm.ca

#120 •

Un lien direct, téléphone, représentation

Déjà collaborant / satisfaction (n=4)

#18 •

nous collaborons déjà

#38 •

Nous collaborons avec CIUSSS de l'Ouest

#113 •

C'est vraiment très bien ce que font les comités

#121 •

Ce n'est pas vraiment un besoin pour nous

Barrières ou manque de disponibilité (n=3)

#50 •

non nous survivons de plusieurs bénévoles qui manquent de temps pour ces sujets.

Notre mission est importante et nous portons le focus à la réussir.

#87 •

Non. Nous n'utilisons pas les services du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

#124 •

Le temps nous manque tellement

non classable (n=5)

#5 •

Non

#15 •

non

#69 •

Non

#83 •

Non

#95 •

Non

q20 — 20. Souhaitez-vous ajouter un commentaire ou une recommandation ?

Propriété annotée : *Quel est le type principal de commentaire ou recommandation formulé par la réponse (information/visibilité, partage des résultats, accessibilité, collaboration, critique du sondage, absence de commentaire) ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 38 réponses (26 internet, 12 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Demande d'information / meilleure visibilité	15	39.5%	6	9
Pas de commentaire / refus de répondre	8	21.1%	8	0
Proposer collaboration avec le communautaire	4	10.5%	3	1
Améliorer accessibilité / communication inclusive	2	5.3%	1	1
Critique du sondage (moment / pertinence)	2	5.3%	2	0
Partager résultats avec organismes	2	5.3%	1	1
non classable	5	13.2%	5	0
Total	38		26	12

Demande d'information / meilleure visibilité (n=15)

#7 • internet

Nous croyons qu'il est essentiel de continuer à sensibiliser les usagers à leurs droits de façon proactive, particulièrement les personnes immigrantes ou vulnérables qui connaissent moins bien le système de santé et des services sociaux.

#62 • internet

Les familles vivant avec une personne en situation de handicap doivent souvent naviguer dans un réseau complexe. Toute initiative visant à simplifier l'accès à l'information et aux ressources disponibles est bénéfique pour les usagers et leurs proches.

#70 • internet

Je crois que les comités d'usagers font un bon travail, mais ils ne sont pas tellement connus de la population en général.

#93 • internet

En ce qui concerne notre organisme, nos services ne sont pas spécialement propices à interagir quant aux besoins en lien avec le système de santé et services sociaux, notamment parce que nous n'offrons aucun suivi individuel. Il arrive des des usagers expriment des inquiétudes ou des problématiques et qu'on leur indiquent qu'ils peuvent par exemple se tourner vers le CLSC ou le 811 pour trouver réponse à leurs besoins. Mais ce type d'interaction demeure relativement limité.

#97 • internet

Les citoyens devraient être mieux renseigner au sujet du comité des citoyens. C'est un enjeu majeur de connaître les fonctions de ce comité. Je crois que beaucoup de personnes aimeraient formuler des plaintes ou des recommandation, mais elles ne connaissent pas la marche à suivre.

Je voudrais vous dire que le sondage est très long à compléter.

#104 • internet

Rendre plus visible le processus par lequel un usager pourrait s'impliquer au sein du comité des usagers.

#106 • téléphone

Je ne connais pas assez leurs services, les organismes communautaires devraient être mieux informés pour pouvoir référer

#108 • téléphone

Expliquer le mandat et les services des comités par dépliants ou autre aux organismes communautaires

#109 • téléphone

Nous manquons d'information mais c'est tout de même rare que nous en aurions besoin

#116 • téléphone

Je ne connais pas du tout les Comités des usagers, leurs mandats sont très bien ! Ce serait bien qu'il y ait une représentation physique dans les organismes communautaires et à la table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve

#118 • téléphone

On ne les connaît pas, mais on aimerait avoir des informations directes avec nos membres

#119 • téléphone

Je trouve ces mandats super ! On pourrait grandement se servir de leurs expertise pour aider nos usagers, mais ce n'est ni connu ni accessible même pour nous en tant qu'organisme communautaire

#120 • téléphone

Tous les points sont bons, formidables, il faudrait accès à cette information autant au niveau du communautaire que des usagers. De l'information lors des consultations, dépliants, posters...

#123 • téléphone

C'est vraiment un manque d'information ou de la clarté de l'ampleur de leurs mandats, surtout au niveau de leur accompagnement. Il pourrait y avoir des dossiers complémentaires à développer avec le communautaire, par ex. de l'accompagnement physique pour les personnes âgées

#128 • téléphone

Mieux faire connaître ce Comité à la population, nous ne l'avons appris que par le CIUSS lorsqu'ils cherchaient de nouveaux membres. Le présentiel serait bien mieux, à l'hôpital ou au CLSC directement aux usagers pour faire des rencontres. Un organisateur communautaire du CIUSS pourrait avoir mandat pour faire de l'information dans les rencontres populaires pour informer et engager des conversations sur les droits des usagers

Pas de commentaire / refus de répondre (n=8)

#5 • internet

Non

#8 • internet

J'espère que ce sondage sera utile et bonifiera réellement les pratiques à terme.

#15 • internet

non

#36 • internet

non

#89 • internet

Non

#94 • internet

Merci !

#95 • internet

Non

#101 • internet

merci pour le formulaire

Proposer collaboration avec le communautaire (n=4)

#24 • internet

Les droits des usagers doivent être abordés avec une approche plus accessible, inclusive et tenant compte des réalités intersectionnelles. Les personnes vivant plusieurs formes de vulnérabilité font souvent face à des obstacles supplémentaires pour faire respecter leurs droits.

Une plus grande collaboration entre le réseau public et les organismes communautaires est essentielle, puisque les organismes communautaires sont souvent en première ligne pour accompagner les personnes qui ont de la difficulté à naviguer le système.

#42 • internet

J'aimerais que ce sondage aie un impact réel pour nos familles qui doivent se battre constamment pour avoir des services, de l'aide, de l'accompagnement... ce qui laisse souvent les plus démunis seuls derrière n'ayant pas les ressources pour se battre.

#88 • internet

Il est important de nous interroger sur la communication inclusive et un accès universel à nos services.

Nous sommes le Centre de Communication Adaptée, organisme financé par le programme PESOC. (surdite.org et fransosourd.com , sourdef.net). Nous souhaitons contribuer à vos travaux.

#129 • téléphone

Il faudrait s'assurer que les usagers sachent tout ce que font les comités des usagers et je trouve que c'est la responsabilité du CIUSS donc des organisateurs communautaires qui devraient informer tous les organismes communautaires de ces mandats et créer des événements avec les membres pour que les droits et les fonctionnements de l'accessibilité au réseau soit compris

Améliorer accessibilité / communication inclusive (n=2)

#2 • internet

Utiliser un autre terme qu'usager ou clientèle quand on parle de personnes qui fréquentent une

ressource communautaire

On parle de participante, de membre, de personnes qui fréquentent notre organisme, etc.

#124 • téléphone

Ces mandats ne sont pas exprimés de façon accessible pour 90% de notre clientèle

Critique du sondage (moment / pertinence) (n=2)

#74 • internet

Votre sondage ne s'adressait pas vraiment à notre situation d'organisme.

#84 • internet

Votre questionnaire tombe dans un bien mauvais moment. c est la fin d année et la préparation des AGA pour les obnl.

Partager résultats avec organismes (n=2)

#60 • internet

Oui, merci de me contacter à direction@cfiq.ca

#115 • téléphone

Ce serait bien que les résultats de cette étude soit disponible aussi pour les organismes communautaires ayant participé au sondage !

non classable (n=5)

#25 • internet

Académie Stella chien d'Assistance fondée en 2017

#44 • internet

Notre organisme n'est pas sur le territoire de l'Est-de-L'île nous travaillons avec le CIUSSS-NIM.

#69 • internet

Un commentaire : Nous sommes un organisme qui est situé sur le territoire du CIUSSS Centre-Sud mais desservons une population sur tout le territoire de la CMM

#85 • internet

-

#87 • internet

q21-Comment — 21. Dans quel secteur d'activité votre organisme œuvre-t-il dans l'Est de Montréal ?

Question mère (q21) : Secteur(s) d'activité de l'organisme

Propriété annotée : *Quel est le secteur d'activité principal visé par la réponse (thème/service fourni) ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 50 réponses (33 internet, 17 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Santé et services médicaux/psychosociaux	12	24.0%	8	4
Emploi / insertion socioprofessionnelle	11	22.0%	5	6
Familles, victimes et soutien communautaire	8	16.0%	5	3
Handicap et neurodiversité	6	12.0%	6	0
Logement et itinérance	6	12.0%	2	4
Genre, femmes et LGBTQ+	5	10.0%	5	0
non classable	2	4.0%	2	0
Total	50		33	17

Santé et services médicaux/psychosociaux (n=12)

#16 • internet

Soutien aux personnes prises avec une maladie neurologique : SP

#25 • internet

Santé mentale et l'accompagnent de chien d'assistance

#48 • internet

soins infirmiers podologiques

#58 • internet

accompagnement pour les personnes qui vivent avec l'épilepsie

#74 • internet

Thérapie pour hommes

#89 • internet

Santé, maladie chronique, handicaps, invalidité

#98 • internet

cancer

#102 • internet

Santé (principalement séquelles oncologiques)

#119 • téléphone

Itinérance et réduction des méfaits, santé

#122 • téléphone

santé et bien être des hommes

#125 • téléphone

Santé mentale

#128 • téléphone

Santé et services sociaux

Emploi / insertion socioprofessionnelle (n=11)

#3 • internet

Employabilité

#40 • internet

Immigration

#43 • internet

Insertion socioprofessionnelle

#60 • internet

Employabilité

#61 • internet

Réinsertion sociale

#105 • téléphone

Employabilité

#113 • téléphone

Insersion

#115 • téléphone

Organisme accompagnement installation et intégration des nouveaux arrivants

#120 • téléphone

insertion socio professionnelle

#121 • téléphone

lutte au décrochage

#127 • téléphone

personne en précarité, immigrants récemment arrivés, réinsertion

Familles, victimes et soutien communautaire (n=8)

#8 • internet

Accompagnement des familles de personnes ayant une déficience intellectuelle.

#30 • internet

Proches aidants, et immigrants

#49 • internet

Proches aidants

#71 • internet

Accompagnement aux familles de personnes assassinées ou disparues

#103 • internet

Organisme d'action communautaire autonome en défense collective des droits

#106 • téléphone

aide sociale et aînés

#107 • téléphone

violence conjugale

#110 • téléphone

Lutte à la pauvreté

Handicap et neurodiversité (n=6)

#11 • internet

Groupe de support pour les adultes ayant un tdah

#21 • internet

autisme

#42 • internet

Déficience intellectuelle

#53 • internet

Déficience intellectuelle

#62 • internet

Personne en situation de handicap

#64 • internet

Attribuer des chien-guide et des chien d'assistance.

Logement et itinérance (n=6)

#82 • internet

Logement communautaire (Accès logis)

#83 • internet

Maison de transition pour ex-détenus fédéraux

#108 • téléphone

Prévention itinérance, éducation, logement, jeunesse

#109 • téléphone

Logement de transition et logement permanent

#117 • téléphone

Jeunesse et itinérance

#118 • téléphone

Droit au logement itinérance

Genre, femmes et LGBTQ+ (n=5)

#2 • internet

Femmes

#17 • internet

Personnes lesbiennes et lesboqueers incluant les personnes trans et non-binaires

#79 • internet

femmes

#97 • internet

Défense des droits des femmes.

#100 • internet

diversité de genre

non classable (n=2)

#44 • internet

immigration

#65 • internet

Sensibilisation culturelle et inclusion

q23-Comment — 23. Quelle(s) clientèle(s) votre organisme dessert-il principalement ?**Question mère (q23)** : Clientèle(s) desservie(s)**Propriété annotée** : *Quel type de clientèle principale est désigné (handicap, identité sexuelle, âge, vulnérabilité sociale, ou toute la population) ?***Résumé des catégories**

7 catégories • 33 réponses (24 internet, 9 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Adultes	8	24.2%	5	3
Communautés LGBTQ+	6	18.2%	6	0
Personnes en situation de handicap	6	18.2%	6	0
Personnes vulnérabilisées / marginalisées	6	18.2%	3	3
Jeunes / tranches d'âge spécifiques	3	9.1%	1	2
Tous / non spécifié	3	9.1%	2	1
non classable	1	3.0%	1	0
Total	33		24	9

Adultes (n=8)

#5 • internet

Adulte

#28 • internet

patients d'hôpitaux

résidents de CHSLD

#39 • internet

adultes

#53 • internet

Adulte

#100 • internet

adultes

#105 • téléphone

Adultes

#109 • téléphone

hommes seuls 35 ans et +

#125 • téléphone

Adultes 18 ans et +

Communautés LGBTQ+ (n=6)

#17 • internet

Personnes lesbiennes et lesboqueers incluant les personnes trans et non-binaires

#37 • internet

LGBTQ+

#40 • internet

lgbtq+

#50 • internet

LBGTQ

#66 • internet

personnes trans et non binaires

#73 • internet

lgpt

Personnes en situation de handicap (n=6)

#3 • internet

Personnes handicapées

#31 • internet

personnes avec un handicap visuel

#35 • internet

Personnes vivant avec une Déficience intellectuelle

#42 • internet

DI

#85 • internet

Personnes en situation de handicap

#104 • internet

Personnes handicapées et particulièrement personnes ayant une lésions médullaires.

Personnes vulnérabilisées / marginalisées (n=6)

#0 • internet

santé mentale

#24 • internet

Adultes (18 ans et plus), incluant des personnes non binaires, des personnes en situation d'itinérance ou de précarité résidentielle, des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale, de dépendance, de handicap ou de neurodiversité, ainsi que d'autres personnes en situation de vulnérabilité sociale.

#103 • internet

N/A. Nous mettons souvent l'accent de divers enjeux de droits humains sur les populations vulné-

rabilisées (personnes au statut migratoire précaire, personnes itinérantes, personnes racisées, etc)

#115 • téléphone

Les nouveaux arrivants

#118 • téléphone

Les personnes mal logées

#119 • téléphone

Toute personne industrie du sexe, itinérance et drogue

Jeunes / tranches d'âge spécifiques (n=3)

#95 • internet

Enfants ayant un retard moteur ou handicap physique

#117 • téléphone

de 18 à 30 ans

#120 • téléphone

18-35 première expérience avec défis en santé mentale ou autre...

Tous / non spécifié (n=3)

#21 • internet

tous les âges

#48 • internet

les services podologiques infirmières sont offerts à toutes les catégories de clientèle

#127 • téléphone

Tous

non classable (n=1)

#18 • internet

autres organismes communautaires et institutions

q24-Comment — 24. Plus spécifiquement, dans quelle thématique votre organisme concentre-t-il sa mission ?

Question mère (q24) : Thématique(s) de la mission de l'organisme

Propriété annotée : *Quel est le groupe cible principal visé par la mission de l'organisme ?*

Résumé des catégories

7 catégories • 74 réponses (53 internet, 21 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Personnes avec déficience / maladies chroniques	18	24.3%	17	1
Itinérance / précarité résidentielle	16	21.6%	11	5
Jeunes, familles et proches aidants	13	17.6%	6	7
Aînés	6	8.1%	3	3
Femmes	6	8.1%	4	2
Immigrants / nouveaux arrivants	3	4.1%	2	1
non classable	12	16.2%	10	2
Total	74		53	21

Personnes avec déficience / maladies chroniques (n=18)

#8 • internet

Soutien et accompagnement des parents et proches de personnes ayant une déficience intellectuelle et défense des droits.

#16 • internet

Notre organisme contribue à garder l'autonomie des personnes atteintes de SP et à briser l'isolement qu'une maladie tel que la SP apporte

#21 • internet

personnes handicapées

#25 • internet

Suivi , formation , acquisition de chien d'assistance en santé mentale

#31 • internet

defenses des droits des personnes vivant avec une déficience visuelle

#39 • internet

déficience intellectuelle

#42 • internet

DI

#48 • internet

soins infirmiers podologiques

#62 • internet

Services adaptés pour personnes en situation de handicap

#64 • internet

Chien-guide, chien d'assistance

#86 • internet

déficiência intellectuelle

#88 • internet

Communautés sourdes de Montréal et du Québec

#89 • internet

Santé, maladie chronique, handicaps, invalidité

#93 • internet

prévention et promotion de la santé mentale, soutien à l'autonomie, au pouvoir d'agir, à l'équilibre émotionnel et biopsychosocial, briser l'isolement

#98 • internet

cancer

#102 • internet

Santé (séquelles oncologiques)

#104 • internet

Personnes en situation de handicap

#119 • téléphone

usage de drogue, réalités avec santé mentale

Itinérance / précarité résidentielle (n=16)

#1 • internet

Soutien alimentaire

#9 • internet

logement

#18 • internet

lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

#19 • internet

Itinérance, relocalisation et stabilité résidentielle

#20 • internet

Hébergement d'urgence et logement sociaux

#24 • internet

Itinérance / précarité résidentielle, recherche de logement, écoute active, référence et accompagnement psychosocial

#36 • internet

Prévention de l'itinérance

#61 • internet

Hébergement, suivi clinique, aide au retour en communauté et plan de sortie. A noter que notre point de service est à Ahuntsic, mais nos résidents vont parfois éventuellement demeurer dans les secteurs identifiés plus haut ou on déjà un second domicile dans ces secteurs.

#82 • internet

Logement subventionné sécuritaire

Empowerment

#83 • internet

Séjours en maison de transition pour ex-détenus fédéraux

#91 • internet

Personnes à risque d'itinérances et itinérance

#109 • téléphone

Toutes ces réponses pour logement : transition de logement, sortie de prison, hospital, itinérance, nouveaux arrivants...

#114 • téléphone

À Hébergement aide

#116 • téléphone

Hébergement en cas d'itinérance

#117 • téléphone

itinérance

#118 • téléphone

Logement

Jeunes, familles et proches aidants (n=13)

#3 • internet

Employabilité

#35 • internet

Repit

#43 • internet

employabilité

#47 • internet

à la jeunesse

#49 • internet

Proches aidants

#53 • internet

Offrir des services pour le développement de l'autonomie

#105 • téléphone

Employabilité

#108 • téléphone

Prévention itinérance, éducation, logement, jeunesse en accompagnement individuel

#111 • téléphone

Jeunes 18-35

#113 • téléphone

insertion socio professionnelle

#120 • téléphone

18-35 première expérience avec défis en santé mentale ou autre...

#121 • téléphone

lutte au décrochage

#124 • téléphone

prévention de la négligence enfants

Aînés (n=6)

#45 • internet

Demance

#63 • internet

Offrir aux aînés un éventail d'activités et de services sociocommunautaires axé sur le bien-être et la santé globale tout en favorisant l'entraide et la solidarité sociale.

#81 • internet

Défense collective des droits des aînés

#106 • téléphone

défense des droit : aide sociale et aînés à leur pension de vieillesse ensuite

#123 • téléphone

Sociabilisation et aide aux personnes âgées

#125 • téléphone

Briser l'isolement

Femmes (n=6)

#2 • internet

tout ce qu'une femme peut vivre

#17 • internet

Violence conjugale, demande d'asile, violence sexuelle, bien être, etc

#97 • internet

Défendre les droits et intérêts des femmes, améliorer leurs conditions de vie et de promouvoir leur autonomie sur les plans : social, économique et politique. Égalité, solidarité, justice, liberté, paix.

#100 • internet

transidentité

#126 • téléphone

Défense collective des droits femmes avec un handicap (Grand Montréal et tout Québec)

#128 • téléphone

Femmes de 18 ans et + / autonomie santé mentale, violence, femmes immigrantes intégration, aînés

Immigrants / nouveaux arrivants (n=3)

#15 • internet

Soutien aux personnes vivant avec le VIH, le VHC ou d'autres ITSS. Prévention du VIH, du VHC et des autres ITSS. Réduction des méfaits. Défense des droits des communautés touchées par le VIH, le VHC, les ITSS, ou qui utilisent des substances.

#40 • internet

Immigrants

#127 • téléphone

personne en précarité, immigrants récemment arrivés, réinsertion

non classable (n=12)

#6 • internet

activités

#23 • internet

Sécurité alimentaire

#27 • internet

Éducation

#44 • internet

bénévolat

#46 • internet

permettre de participer au bal en toute dignité

#58 • internet

accompagnement

#75 • internet

Aide sociale

#77 • internet

amélioration des conditions de vie

#79 • internet

briser l'isolement , mais nous intervenons dans des problématiques multiples

#103 • internet

défense collective des droits / éducation aux droits / plaidoyer

#110 • téléphone

et aux personnes seules

#129 • téléphone

Éducation et développement communautaire
